VIGINDÚSTRIA BRASIL 2025

VIGILÂNCIA DE FATORES DE SAÚDE E SEGURANÇA EM TRABALHADORES DA INDÚSTRIA

[Inserir ficha catalográfica e expediente]

Universidade de Pernambuco
Grupo de Pesquisa em Estilos de Vida e Saúde

- Mauro Virgilio Gomes de Barros
- Fernanda Cunha Soares
- Jorge Bezerra
- Marco Aurélio de Valois Correia Júnior
- Marcos André Moura dos Santos
- Rildo de Souza Wanderley Júnior
- Simone Storino Honda Barros

Lista de tabelas

Tabela 1. Distribuição das características demográficas dos participantes segundo a estratégia de amostragem.

Tabela 2. Distribuição da amostra por porte de empresa e por região geográfica. SESI, Brasil, 2025.

Tabela 3. Características demográficas dos participantes (n= 57.952) e respectivas estimativas ponderadas. SESI, Brasil, 2025.

Tabela 4. Prevalência (IC95%) de tabagismo em trabalhadores(as) da indústria, segundo características demográficas. SESI, 2025.

Tabela 5. Prevalência (IC95%) de consumo episódico pesado de bebidas alcoólicas em trabalhadores(as) da indústria, segundo características demográficas. SESI, 2025.

Tabela 6. Prevalência (IC95%) de baixa frequência de consumo de frutas ou hortaliças em trabalhadores(as) da indústria, segundo características demográficas. SESI, 2025.

Tabela 7. Prevalência (IC95%) de consumo excessivo de refrigerantes ou sucos artificiais em trabalhadores(as) da indústria, segundo características demográficas. SESI, 2025.

Tabela 8. Prevalência (IC95%) de inatividade física no lazer em trabalhadores(as) da indústria, segundo características demográficas. SESI, 2025.

Tabela 9. Prevalência (IC95%) de tempo prolongado de TV em trabalhadores(as) da indústria, segundo características demográficas. SESI, 2025.

Tabela 10. Prevalência (IC95%) de tempo prolongado de tela em trabalhadores(as) da indústria, segundo características demográficas. SESI, 2025.

Tabela 11. Prevalência (IC95%) de elevado nível de estresse em trabalhadores(as) da indústria, segundo características demográficas. SESI, 2025.

Tabela 12. Prevalência (IC95%) de pensamentos negativos e pessimistas persistentes em trabalhadores(as) da indústria, segundo características demográficas. SESI, 2025.

Tabela 13. Prevalência (IC95%) de relacionamentos interpessoais de baixa qualidade em trabalhadores(as) da indústria, segundo características demográficas. SESI, 2025.

Tabela 14. Prevalência (IC95%) de percepção negativa da qualidade do sono em trabalhadores(as) da indústria, segundo características demográficas. SESI, 2025.

Tabela 15. Prevalência (IC95%) de dificuldade de relaxar e usufruir do lazer em trabalhadores(as) da indústria, segundo características demográficas. SESI, 2025.

Tabela 16. Prevalência (IC95%) de insatisfação com as condições de trabalho em trabalhadores(as) da indústria, segundo características demográficas. SESI, 2025.

Tabela 17. Prevalência (IC95%) de obesidade em trabalhadores(as) da indústria, segundo características demográficas. SESI, 2025.

Tabela 18. Prevalência (IC95%) de hipertensão referida em trabalhadores(as) da indústria, segundo características demográficas. SESI, 2025.

Tabela 19. Prevalência (IC95%) de diabetes referido em trabalhadores(as) da indústria, segundo características demográficas. SESI, 2025.

Tabela 20. Prevalência (IC95%) de colesterol alto referido em trabalhadores(as) da indústria, segundo características demográficas. SESI, 2025.

Tabela 21. Prevalência (IC95%) de AVC referido em trabalhadores(as) da indústria, segundo características demográficas. SESI, 2025.

Tabela 22. Prevalência (IC95%) de artrite/reumatismo referido em trabalhadores(as) da ind ústria, segundo características demográficas. SESI, 2025.

Tabela 23. Prevalência (IC95%) de asma ou bronquite asmática referida em trabalhadores(as) da indústria, segundo características demográficas. SESI, 2025.

Tabela 24. Prevalência (IC95%) de depressão referida em trabalhadores(as) da indústria, segundo características demográficas. SESI, 2025.

Tabela 25. Prevalência (IC95%) de câncer referido em trabalhadores(as) da indústria, segundo características demográficas. SESI, 2025.

Tabela 26. Prevalência (IC95%) de problema crônico de coluna referido em trabalhadores(as) da indústria, segundo características demográficas. SESI, 2025.

Tabela 27. Prevalência (IC95%) de baixa frequência de atividades de controle de condições crônicas em trabalhadores(as) da indústria, segundo características demográficas. SESI, 2025.

Tabela 28. Prevalência (IC95%) de atitude negativa para o autocuidado em trabalhadores(as), segundo características demográficas. SESI, 2025.

Tabela 29. Prevalência (IC95%) de percepção de saúde negativa em trabalhadores(as) da ind ústria, segundo características demográficas. SESI, 2025.

Tabela 30. Prevalência (IC95%) de percepção de saúde bucal negativa em trabalhadores(as) da indústria, segundo características demográficas. SESI, 2025.

Tabela 31. Proporção (IC95%) de trabalhadores(as) que referiram que segurança e prevenção de acidentes são importantes para a empresa, segundo características demográ ficas. SESI, 2025.

Tabela 32. Proporção (IC95%) de trabalhadores(as) que referiram percepção de ambiente de trabalho seguro, segundo características demográficas. SESI, 2025.

Tabela 33. Proporção (IC95%) de trabalhadores(as) que referiram que a liderança obedece e encoraja obediência às normas de segurança, segundo características demográficas. SESI, 2025.

Tabela 34. Proporção (IC95%) de trabalhadores(as) que referiram que a empresa prioriza e realiza esforços suficientes para prevenção de acidentes, segundo características demográ ficas. SESI, 2025.

Tabela 35. Proporção (IC95%) de trabalhadores(as) que referiram receber treinamento para emergências e prevenção de acidentes, segundo características demográficas. SESI, 2025.

Tabela 36. Proporção (IC95%) de trabalhadores(as) que referiram comunicação suficiente e adequada sobre prevenção de acidentes, segundo características demográficas. SESI, 2025.

Lista de figuras

Figura 1. Dimensões de saúde e segurança do sistema ASSTI. SESI, 2025.

Figura 2. Fluxograma das etapas de desenvolvimento e validação do instrumento. SESI 2025.

Figura 3. Prevalência de tabagismo em trabalhadores(as) da indústria, segundo região geográfica. As colunas representam as estimativas de prevalência e as barras de erro indicam os intervalos de confiança de 95% (IC95%). SESI, 2025.

Figura 4. Prevalência de consumo episódio pesado de bebidas alcoólicas em trabalhadores(as) da indústria, segundo região geográfica. As colunas representam as estimativas de prevalência e as barras de erro indicam os intervalos de confiança de 95% (IC95%). SESI, 2025.

Figura 5. Prevalência de baixa frequência de consumo de frutas ou hortaliças em trabalhadores(as) da indústria, segundo região geográfica. As colunas representam as estimativas de prevalência e as barras de erros indicam os intervalos de confiança de 95% (IC95%). SESI, 2025.

Figura 6. Prevalência (%) de consumo excessivo de refrigerantes ou sucos artificiais em trabalhadores(as) da indústria, segundo região geográfica. As colunas representam as estimativas de prevalência e as barras de erro indicam os intervalos de confiança de 95% (IC95%). SESI, 2025.

Figura 7. Prevalência de inatividade física no lazer em trabalhadores(as) da indústria, segundo região geográfica. As colunas representam as estimativas de prevalência e as barras de erro indicam os intervalos de confiança de 95% (IC95%). SESI, 2025.

Figura 8. Prevalência de tempo prolongado de TV em trabalhadores(as) da indústria, segundo região geográfica. As colunas representam as estimativas de prevalência e as barras de erro indicam os intervalos de confiança de 95% (IC95%). SESI, 2025.

Figura 9. Prevalência de tempo prolongado de tela em trabalhadores(as) da indústria, segundo região geográfica. As colunas representam as estimativas de prevalência e as barras de erro indicam os intervalos de confiança de 95% (IC95%). SESI, 2025.

Figura 10. Prevalência de elevado nível de estresse em trabalhadores(as) da indústria, segundo região geográfica. As colunas representam as estimativas de prevalência e as barras de erro indicam os intervalos de confiança de 95% (IC95%). SESI, 2025.

Figura 11. Prevalência de pensamentos negativos e pessimistas persistentes em trabalhadores(as) da indústria, segundo região geográfica. As colunas representam as estimativas de prevalência e as barras de erro indicam os intervalos de confiança de 95% (IC95%). SESI, 2025.

Figura 12. Prevalência de relacionamentos interpessoais de baixa qualidade em trabalhadores(as) da indústria, segundo região geográfica. As colunas representam as estimativas de prevalência e as barras de erro indicam os intervalos de confiança de 95% (IC95%). SESI, 2025.

Figura 13. Prevalência de percepção negativa da qualidade do sono em trabalhadores(as) da indústria, segundo região geográfica. As colunas representam as estimativas de prevalência e as barras de erro indicam os intervalos de confiança de 95% (IC95%). SESI, 2025.

Figura 14. Prevalência de dificuldade de relaxar e usufruir do lazer em trabalhadores(as) da indústria, segundo região geográfica. As colunas representam as estimativas de prevalência e as barras de erro indicam os intervalos de confiança de 95% (IC95%). SESI, 2025.

Figura 15. Prevalência de insatisfação com as condições de trabalho em trabalhadores(as) da indústria, segundo região geográfica. As colunas representam as estimativas de prevalência e as barras de erro indicam os intervalos de confiança de 95% (IC95%). SESI, 2025.

Figura 16. Prevalência (%) de obesidade em trabalhadores(as) da indústria, segundo região geográfica. As colunas representam as estimativas de prevalência e as barras de erro indicam os intervalos de confiança de 95% (IC95%). SESI, 2025.

Figura 17. Prevalência de hipertensão referida em trabalhadores(as) da indústria, segundo região geográfica. As colunas representam as estimativas de prevalência e as barras de erro indicam os intervalos de confiança de 95% (IC95%). SESI, 2025.

Figura 18. Prevalência de diabetes referido em trabalhadores(as) da indústria, segundo região geográfica. As colunas representam as estimativas de prevalência e as barras de erro indicam os intervalos de confiança de 95% (IC95%). SESI, 2025.

Figura 19. Prevalência de colesterol alto referido em trabalhadores(as) da indústria, segundo região geográfica. As colunas representam as estimativas de prevalência e as barras de erro indicam os intervalos de confiança de 95% (IC95%). SESI, 2025.

Figura 20. Prevalência de AVC referido em trabalhadores(as) da indústria,segundo região geográfica. As colunas representam as estimativas de prevalência e as barras de erro indicam os intervalos de confiança de 95% (IC95%). SESI, 2025.

Figura 21. Prevalência de artrite/reumatismo referido em trabalhadores(as) da indústria, segundo região geográfica. As colunas representam as estimativas de prevalência e as barras de erro indicam os intervalos de confiança de 95% (IC95%). SESI, 2025.

Figura 22. Prevalência de asma ou bronquite asmática referida em trabalhadores(as) da indústria, segundo região geográfica. As colunas representam as estimativas de prevalência e as barras de erro indicam os intervalos de confiança de 95% (IC95%). SESI, 2025.

Figura 23. Prevalência de depressão referida em trabalhadores(as) da indústria, segundo região geográfica. As colunas representam as estimativas de prevalência e as barras de erro indicam os intervalos de confiança de 95% (IC95%). SESI, 2025.

Figura 24. Prevalência de câncer referido em trabalhadores(as) da indústria, segundo região geográfica. As colunas representam as estimativas de prevalência e as barras de erro indicam os intervalos de confiança de 95% (IC95%). SESI, 2025.

Figura 25. Prevalência de problema crônico de coluna referido em trabalhadores(as) da indústria, segundo região geográfica. As colunas representam as estimativas de prevalência e as barras de erro indicam os intervalos de confiança de 95% (IC95%). SESI, 2025.

Figura 26. Prevalência (%) de trabalhadores(as) com baixa frequência de controle de condições crônicas, segundo região geográfica. As colunas representam as estimativas de prevalência e as barras de erro indicam os intervalos de confiança de 95% (IC95%). SESI, 2025.

Figura 27. Prevalência de atitude negativa para o autocuidado em trabalhadores(as) da indústria, segundo região geográfica. As colunas representam as estimativas de prevalência e as barras de erro indicam os intervalos de confiança de 95% (IC95%). SESI, 2025.

Figura 28. Prevalência de percepção de saúde negativa em trabalhadores(as) da indústria, segundo região geográfica. As colunas representam as estimativas de prevalência e as barras de erro indicam os intervalos de confiança de 95% (IC95%). SESI, 2025.

Figura 29. Prevalência de percepção de saúde bucal negativa em trabalhadores(as) da indústria, segundo região geográfica. As colunas representam as estimativas de prevalência e as barras de erro indicam os intervalos de confiança de 95% (IC95%). SESI, 2025.

Figura 30. Proporção de trabalhadores(as) que consideram que segurança e prevenção de acidentes são importantes para a empresa, segundo região geográfica. As colunas representam as estimativas de prevalência e as barras de erro indicam os intervalos de confiança de 95% (IC95%). SESI, 2025.

Figura 31. Proporção de trabalhadores(as) que referiram percepção de ambiente de trabalho seguro, segundo região geográfica. As colunas representam as estimativas de prevalência e as barras de erro indicam os intervalos de confiança de 95% (IC95%). SESI, 2025.

Figura 32. Proporção de trabalhadores(as) que referiram que a liderança obedece e encoraja obediência às normas de segurança, segundo região geográfica. As colunas representam as estimativas de prevalência e as barras de erro indicam os intervalos de confiança de 95% (IC95%). SESI, 2025.

Figura 33. Proporção de trabalhadores(as) que referiram que a empresa prioriza e realiza esforços suficientes para prevenção de acidentes, segundo região geográfica. As colunas representam as estimativas de prevalência e as barras de erro indicam os intervalos de confiança de 95% (IC95%). SESI, 2025.

Figura 34. Proporção de trabalhadores(as) que referiram receber treinamentos para emergências e prevenção de acidentes, segundo região geográfica. As colunas representam as estimativas de prevalência e as barras de erro indicam os intervalos de confiança de 95% (IC95%). SESI, 2025.

Figura 35. Proporção de trabalhadores(as) que referem comunicação suficiente e adequada sobre prevenção de acidentes, segundo região geográfica. As colunas representam as estimativas de prevalência e as barras de erro indicam os intervalos de confiança de 95% (IC95%). SESI, 2025.

SUMÁRIO

Página

Agradecimentos .....

Apresentação .....

Introdução .....

Aspectos metodológicos .....

Amostragem .....

Inferência de estimativas .....

Coleta de dados .....

Indicadores .....

Tratamento de dados de massa (peso) e estatura (altura) .....

Aspectos éticos .....

Resultados .....

Características demográficas dos trabalhadores do setor industrial .....

Fatores comportamentais .....

Bem-estar psicológico .....

Morbidade .....

Percepção de saúde e autocuidado .....

Cultura de segurança .....

Considerações finais e recomendações .....

Referências .....

AGRADECIMENTOS

A implantação do sistema de Avaliação de Saúde e Segurança em Trabalhadores da Indústria foi um marco para o Serviço Social da Indústria (SESI). A partir dele, o setor industrial passou a contar com uma ferramenta estruturada para avaliação de indicadores capazes de subsidiar o planejamento de programas e intervenções mais efetivos em saúde e segurança. Há, hoje, profissionais em todos os departamentos regionais do SESI capacitados a utilizarem esta ferramenta de avaliação, oferecendo às empresas industriais um atendimento consultivo e especializado de apoio à implementação de ações voltadas à promoção da saúde e à prevenção de acidentes. A estes profissionais, registramos nosso especial agradecimento pela atuação engajada, qualificada e comprometida, que permitiu a coleta dos dados que fundamentam o presente relatório.

O Ministério da Saúde e o SESI, com a mediação do Conselho Nacional do SESI, convergiram esforços para estabelecer um Acordo de Cooperação Técnica (ACT) voltado à promoção de ambientes e processos de trabalho saudáveis. A cooperação foi estruturada em sete eixos de ações intersetoriais, com foco no fortalecimento das estratégias de Promoção da Saúde e Prevenção das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), bem como na ampliação da produção de evidências para subsidiar políticas públicas voltadas à saúde de trabalhadores e trabalhadoras do setor industrial.

No eixo dedicado à Promoção da Saúde e Prevenção das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), as instituições reconheceram o potencial e a relevância dos programas já existentes e pactuaram o desenvolvimento de dois projetos estratégicos: (1) a criação de um sistema de vigilância em saúde do trabalhador e da trabalhadora da indústria; e, (2) a elaboração de um programa de saúde mental voltado a esse público.

Registram-se, também, agradecimentos especiais ao Conselho Nacional do SESI pela liderança na consolidação desta importante iniciativa de cooperação com o Ministério da Saúde. O Relatório Vigindústria constitui um dos resultados desse trabalho conjunto e representa um passo significativo para o fortalecimento da produção de evidências sobre a saúde dos trabalhadores e trabalhadoras do setor industrial. A iniciativa integra, também, um conjunto amplo de ações previstas no Acordo de Cooperação Técnica, cujos desdobramentos resultarão em diversos

produtos e contribuirão para o aprimoramento de políticas e estratégias de promoção da saúde no ambiente de trabalho, gerando benefícios que se estendem não apenas ao setor industrial, mas à sociedade brasileira como um todo.

Equipe de organização e elaboração do Vigindústria

APRESENTAÇÃO

O Serviço Social da Indústria (SESI) entende que estudos e inquéritos de saúde são fundamentais para geração de conhecimentos que possam guiar decisões assertivas em questões relacionadas à saúde e segurança. Foi em face desse entendimento que, no passado, participou de iniciativas pioneiras como o a realização, em 2007, do "Estudo SESI: perfil epidemiológico de fatores de risco para doenças não transmissíveis em trabalhadores da indústria do Brasil"[1] e, em 2009, do estudo intitulado "Estilo de Vida e Hábitos de Lazer dos Trabalhadores das Indústrias Brasileiras"[2].

O sistema de Avaliação de Saúde e Segurança em Trabalhadores da Indústria, também conhecido como ASSTI, permitiu a acumulação de dados de saúde e segurança que são utilizados para realização de atendimentos consultivos às empresas do setor. Após agregação desses dados em nível nacional, é possível a realização de estudos e o monitoramento da frequência e a distribuição dos principais determinantes das doenças crônicas não transmissíveis. Além disso, é possível focalizar em indicadores da cultura de segurança, dimensão essencial para análise da situação de saúde neste subgrupo de trabalhadores, os industriários.

Nessa primeira publicação, prioriza-se uma análise descritiva, de modo a permitir a identificação da frequência e distribuição de diversos indicadores de saúde e segurança. Com a continuidade da utilização do sistema ASSTI será possível analisar a tendência temporal dos indicadores em cada uma das dimensões investigadas. Buscar-se-á, também, o aperfeiçoamento contínuo dessa iniciativa de monitoramento, de modo a produzir informações e conhecimento estratégico para o setor indústria.

Neste relatório, a apresentação dos resultados está organizada em seis seções: características demográficas, fatores comportamentais, bem-estar psicológico, morbidade referida, percepção de saúde e autocuidado e, por fim, indicadores de cultura de segurança. A estrutura do texto, inicia com a apresentação da definição operacional de cada indicador e, em seguida, apresenta as estimativas de frequência na população, acompanhadas dos respectivos intervalos de confiança de 95% (IC95%). As análises realizadas são de natureza descritiva e consideram o efeito de conglomeração decorrente do processo de seleção amostral, mediante a aplicação de ponderações. Esse procedimento pode resultar em intervalos de confiança mais amplos. Assim, os

resultados devem ser interpretados considerando as estimativas pontuais e a precisão expressa pelos IC95%, sem a realização de inferência estatística formal para a comparação entre grupos.

Os resultados são apresentados segundo diferentes características da população estudada, incluindo sexo biológico, escolaridade, faixa etária, situação conjugal, número de filhos, acesso a plano de saúde e tempo de trabalho na empresa. Também são consideradas as regiões geográficas brasileiras e o porte das empresas, agrupadas em micro e pequenas empresas e médias e grandes empresas. Essa organização permite observar a distribuição dos indicadores entre os diferentes grupos e contextos investigados.

Espera-se que os leitores possam encontrar neste relatório informações úteis que permitam a reflexão sobre os indicadores apresentados e contribuam para a tomada de decisão orientada por dados. O conteúdo deste relatório pode ser amplamente divulgado e utilizado, desde que citada a fonte. Boa leitura!!!

INTRODUÇÃO

O setor industrial absorve uma parcela importante dos trabalhadores brasileiros, sendo fundamental para a economia e o desenvolvimento do país. Dados da Confederação Nacional da Indústria (CNI) de 2024 apontam que este setor empregou 11,9 milhões de trabalhadores formais, correspondendo a 20,6% do emprego formal da economia brasileira[3].

Nas últimas décadas, o Brasil vem experimentando um declínio na taxa de acidentes de trabalho fatais e não fatais, resultado de um amplo e contínuo investimento em normas regulamentadoras e na área de saúde ocupacional[4-5]. Paralelamente, tem-se observado também redução da taxa de mortalidade por causas evitáveis, acompanhando tendência observada também em outros países das Américas. Apesar disso, as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) continuam sendo a principal causa de mortalidade e de incapacidade tanto no Brasil como no mundo[6]. Trata-se de um grupo de enfermidades que é a principal causa de aposentadoria por invalidez.

Considerando a importância do setor industrial, tanto na geração de empregos quanto no crescimento econômico, a presença de fatores de risco para doenças crônicas não transmissíveis em industriários é um importante desafio sanitário. A exposição dos trabalhadores a fatores como o tabagismo e o consumo excessivo de álcool, além de baixos níveis de atividade física e hábitos alimentares não saudáveis, está associada a piores condições de saúde, podendo também afetar a produtividade dos trabalhadores[7].

Diante deste desafio, o Serviço Social da Indústria (SESI) implantou, em 2018, um serviço pioneiro de Avaliação da Saúde e Segurança em Trabalhadores da Indústria, também conhecido como sistema ASSTI[8]. Esse sistema permite coletar dados de diversos indicadores de saúde, gerando informação para apoiar uma estratégia de decisão guiada por dados. Por meio da utilização desse sistema, profissionais do SESI são capazes de oferecer às indústrias um conjunto de informações estratégicas que lhes permite definir ações de prevenção e promoção da saúde que podem ser oferecidas aos trabalhadores, maximizando a aplicação de recursos.

A integração dos dados gerados pela utilização do ASSTI pode ser útil ao monitoramento, em escala nacional, de diversos indicadores de saúde. Por essa razão, propôs-se a realização desse estudo que utiliza dados coletados de julho a dezembro de 2025, em 825 empresas, a fim de

descrever estimativas sobre frequência e distribuição demográfica de fatores de saúde e segurança em trabalhadores do setor industrial brasileiro. Trata-se, portanto, de um esforço setorial para ampliar as ações de vigilância em saúde, oferecendo dados sobre a exposição de industriários a fatores comportamentais de risco para DCNT, além de indicadores de estresse psicossocial, morbidade, percepção de saúde e autocuidado, e cultura de segurança.

ASPECTOS METODOLÓGICOS

Os resultados apresentados neste relatório são frutos de um estudo transversal realizado com o objetivo de estimar a frequência e descrever a distribuição de indicadores de saúde e segurança em trabalhadores do setor industrial brasileiro. O planejamento do estudo previu a coleta de dados em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, de modo a permitir uma análise abrangente desses indicadores de saúde e segurança. Os resultados focalizam em seis das sete dimensões do Sistema de Avaliação em Saúde e Segurança do Trabalhador da Indústria - ASSTI (SESI, 2023), conforme ilustrado na Figura 1, a saber: (1) fatores demográficos; (2) fatores comportamentais; (3) bem-estar mental; (4) morbidade; (5) percepção de saúde e autocuidado; e, (6) cultura de segurança. Não foram analisados, os fatores de redução da produtividade por não estarem alinhados ao propósito do presente estudo.



Figura 1. Dimensões de saúde e segurança do sistema ASSTI. SESI, 2025.

Fonte: SESI (2023)[8].

Amostragem

Para o desenvolvimento deste estudo foi definido um plano amostral considerando uma base de dados sobre empresas contribuintes e não contribuintes do SESI em todo o Brasil. Essa base de dados foi elaborada pela Gerência de Arrecadação e Fiscalização da Confederação Nacional da Indústria (CNI), abrangendo dados extraídos dos Termos de Cooperação Técnica e Financeira (TCTF)

firmados com empresas do setor industrial, assim como dados extraídos diretamente do eSocial. Esse plano foi elaborado de modo que se obtivesse uma amostra aleatória por conglomerados (empresas), representativa e suficientemente precisa do perfil dos trabalhadores em cada uma das regiões brasileiras, não sendo viável logisticamente, neste primeiro inquérito, realizar amostragem que permitisse a desagregação das análises por Unidades da Federação (UFs). No planejamento da amostra probabilística, os tamanhos amostrais foram definidos de modo a permitir estimativas da frequência dos indicadores com nível de confiança de 95% e erro máximo de até dois pontos percentuais, inclusive nas desagregações por fatores demográficos e região geográfica. Erros máximos de até três pontos percentuais foram previstos para estimativas específicas para algumas categorias das variáveis faixa etária (≥60 anos), situação conjugal (viúvo/a, desquitado/a ou divorciado/a) e número de filhos (4 ou mais filhos/as).

No processo de seleção das unidades amostrais, essa abordagem se mostrou especialmente desafiadora em face do quantitativo de empresas que estavam baixadas, sem funcionamento ou que tinham um número muito reduzido de trabalhadores (<10). Por isso, paralelamente, decidiu-se pela coleta de dados em empresas que voluntariamente demandaram serviços de saúde e segurança ao SESI, numa amostragem por conveniência. Essa estratégia, sabe-se, pode concorrer para viés de seleção, comprometendo a representatividade das estimativas realizadas. A fim de verificar a possível presença de viés de seleção, recorreu-se à observação das características demográficas dos participantes provenientes da amostra aleatória e daqueles recrutados pela estratégia de amostragem por conveniência (Tabela 1). Essa análise mostrou que as distribuições das características demográficas avaliadas foram, em geral, próximas entre as duas estratégias de recrutamento, embora tenham sido observadas diferenças pontuais em algumas categorias. Diante desses resultados, optou-se pela combinação das amostras aleatória e por conveniência, com o objetivo de ampliar o tamanho amostral e a precisão das estimativas apresentadas neste relatório. Considerando a inclusão de participantes provenientes de amostragem por conveniência, as estimativas devem ser interpretadas à luz das características do processo de recrutamento e das estratégias de ponderação adotadas nas análises. Os dados foram coletados no período de julho a dezembro de 2025.

Tabela 1. Distribuição das características demográficas dos participantes segundo a estratégia de amostragem.

Variável	Categoria	Amostra aleatória	Amostra por

demográfica		% (IC95%) (n= 3.910)	conveniência % (IC95%) (n= 54.042)
Sexo biológico	Masculino	62.7 (61.2-64.2)	63.7 (63.3-64.1)
	Feminino	37.3 (35.8-38.8)	36.3 (35.9-36.7)
Faixa etária (anos)	<30	30.0 (28.5–31.4)	33.6 (33.2-34.0)
	30-39	30.5 (29.0–31.9)	30.3 (29.9-30.7)
	40-59	37.0 (35.5–38.5)	33.5 (33.1-33.9)
	≥60	2.6 (2.1–3.1)	2.6 (2.4-2.7)
Situação conjugal	Solteiro(a)	36.9 (35.4-38.4)	37.3 (36.9-37.6)
	Casado(a) ou vivendo com parceiro(a)	58.7 (57.2-60.2)	58.2 (57.8-58.6)
	Viúvo(a), desquitado(a) ou divorciado(a)	4.5 (3.8-5.1)	4.5 (4.4-4.7)
Escolaridade	Ensino fundamental incompleto	10.8 (9.8-11.8)	10.1 (9.8-10.3)
	Ensino fundamental completo	14.0 (12.9-15.1)	12.4 (12.2-12.7)
	Ensino médio ou técnico completo	39.6 (38.1-41.1)	39.6 (39.2-40.0)
	Ensino superior incompleto	15.7 (14.6-16.9)	15.6 (15.3-15.9)
	Ensino superior completo	19.9 (18.6-21.1)	22.3 (21.9-22.6)
Número de filhos	Nenhum	35.4 (34.0-36.9)	37.7 (37.3-38.1)
	1 filho(a)	26.7 (25.4-28.1)	26.6 (26.2-26.9)
	2 a 3 filhos(as)	31.8 (30.4-33.2)	31.0 (30.6-31.4)
	4 ou mais filhos(as)	6.0 (5.3-6.8)	4.7 (4.6-4.9)
Acesso a plano de saúde	Não	47.2 (45.6-48.7)	46.3 (45.9-46.7)
	Sim	52.8 (51.3-54.4)	53.7 (53.3-54.1)
Tempo de trabalho na empresa	Menos de 1 ano	30.2 (28.8-31.6)	28.8 (28.4-29.1)
	Entre 1 e 5 anos	40.7 (39.2-42.2)	40.5 (40.1-40.9)
	Entre 5 e 10 anos	13.1 (12.0-14.1)	12.5 (12.3-12.8)
	Mais de 10 anos	16.0 (14.9-17.1)	18.2 (17.9-18.5)

Fonte: próprio autor.

Instrumento de coleta de dados

Para o desenvolvimento desse estudo, foi empregado um questionário administrado via *chatbot*, ferramenta que simula uma conversa humana por texto para a coleta de dados de interesse. A utilização de recursos de tecnologia da informação para administração de questionários tem se ampliado e constitui uma estratégia com potencial de aplicação em inquéritos epidemiológicos[9].

O *chatbot* foi embarcado numa plataforma digital que permitia o preenchimento do questionário tanto online quanto offline. No caso do preenchimento offline, este foi realizado em tablets que, mais tarde, foram conectados à Internet para envio dos dados para um servidor. A administração do questionário seguiu procedimentos padronizados e previamente testados, os quais se encontravam detalhadamente descritos em caderno técnico disponível para todos os envolvidos no trabalho de campo[8]. O questionário permitiu, ainda, o salto automático de questões não

aplicáveis em face de respostas anteriores, a crítica imediata de respostas não válidas e a cronometragem da duração da entrevista, além de propiciar a alimentação direta e contínua no banco de dados do sistema.

A construção do instrumento iniciou com a realização de três grupos focais[10], reunindo nos dois primeiros profissionais do SESI e, no último, pesquisadores com expertise na construção de instrumentos de medida e estudos relacionados à saúde do trabalhador. O objetivo desses grupos focais foi discutir sobre a aplicabilidade do instrumento, indicadores necessários ao planejamento e monitoramento das intervenções, periodicidade da administração dos instrumentos, entre outras questões. Considerando-se os elementos reunidos, partiu-se, então, para a construção da matriz analítica do instrumento[11] e, por fim, para a formatação do questionário que foi submetido à testagem em painel de especialistas (juízes) e estudo piloto seguindo o fluxograma apresentado na Figura 2.

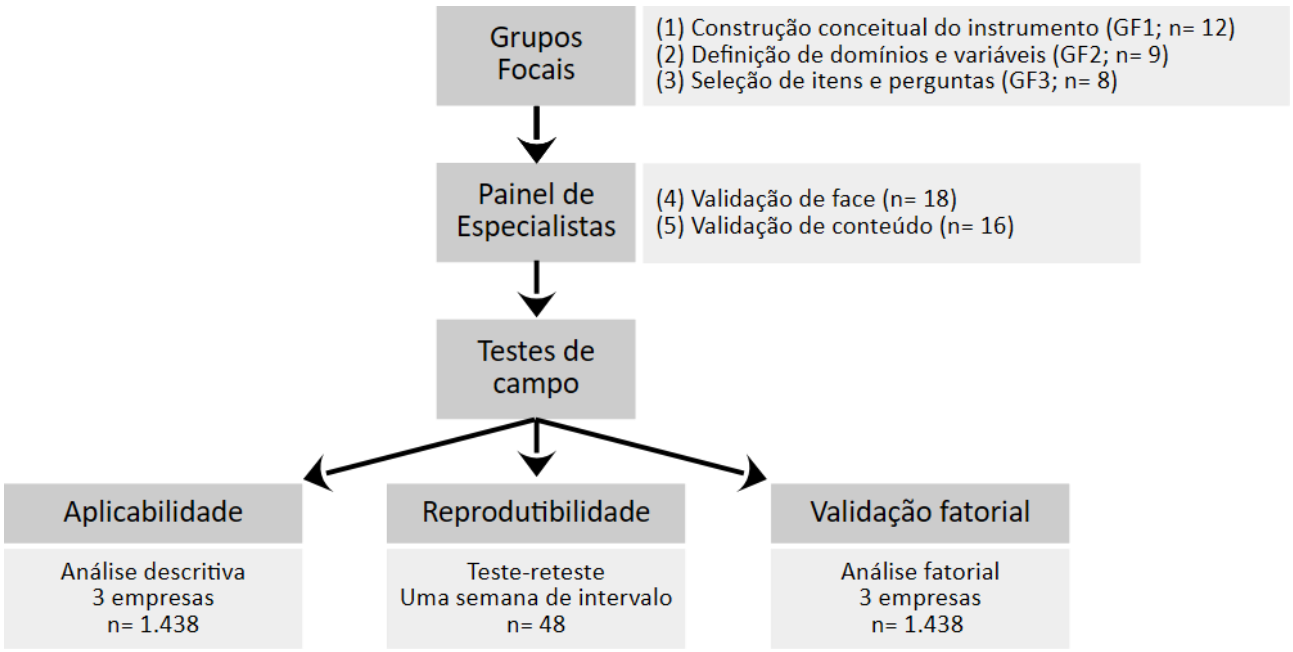


Figura 2. Fluxograma das etapas de desenvolvimento e validação do instrumento. SESI 2025.

Fonte: próprio autor.

Na consulta ao painel de especialistas, procedeu-se à análise de indicadores de validade de face e conteúdo segundo orientações dispostas na literatura[12-15]. Na etapa de validade de face foi determinada tanto a TCC (Taxa de Concordância do Comitê) quanto a pertinência das perguntas formuladas para cada item da matriz analítica, observando-se que todos os itens apresentaram TCC superior a 80%. Na etapa de validade de conteúdo foi determinado o IVC (Índice de Validade

de Conteúdo) para relevância e para clareza, sendo que somente itens com IVC superior a 80% foram mantidos na versão final do instrumento. Nas duas etapas, o comitê de especialistas teve espaço no documento de avaliação para discorrer sobre cada domínio, apresentando sugestões e observações para aprimoramento da versão final do instrumento.

No estudo piloto, procedeu-se à verificação da aplicabilidade do questionário já implantado em tecnologia de preenchimento via chatbot, avaliação da reprodutibilidade de medidas teste-reteste (uma semana de intervalo) e validação fatorial[16]. Para verificação da reprodutibilidade, adotou-se cálculo do PABAK (prevalence and bias adjusted Kappa)[17], sendo que todos os valores foram superiores a 0,7, aceitáveis para instrumentos autorreferidos[18].

A adequação da matriz de correlação para análise fatorial foi verificada pelo índice de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) e pelo teste de esfericidade de Bartlett. A estrutura dimensional do instrumento foi inicialmente investigada por meio da Análise Fatorial Exploratória (AFE), utilizando matriz de correlações policóricas, método de extração dos fatores principais (Principal Axis Factoring) e rotação oblíqua Promax, considerando a possibilidade de correlação entre os fatores. O número de fatores (dimensões) foi definido com base na estrutura teórica do instrumento, complementado pela inspeção dos autovalores e do gráfico de sedimentação (scree plot). Sem considerar os fatores demográficos, a estrutura teórica do instrumento foi composta por seis fatores (dimensões), a qual foi avaliada por meio de Análise Fatorial Confirmatória (AFC), utilizando o estimador Weighted Least Squares Mean and Variance Adjusted (WLSMV). O modelo apresentou Comparative Fit Index (CFI)= 0,973, Tucker-Lewis Index (TLI)= 0,971, Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)= 0,060 (IC95%: 0,058–0,063) e Standardized Root Mean Square Residual (SRMR)= 0,130. Embora alguns poucos indicadores tenham apresentado cargas fatoriais reduzidas ou não significativas, foi realizada uma tentativa de reespecificação do modelo por meio da exclusão dessas variáveis. Entretanto, essa estratégia resultou em piora dos índices globais de ajuste, com redução dos valores de CFI e TLI e aumento dos valores de RMSEA e SRMR em relação ao modelo original. Dessa forma, optou-se por manter a estrutura inicialmente proposta, uma vez que apresentou melhor desempenho global e maior aderência aos dados, preservando também a fundamentação teórica do instrumento.

A consistência interna e a validade convergente dos fatores foram avaliadas por meio da confiabilidade composta (CR) e da variância média extraída (AVE). Os fatores de cultura de

segurança (CR = 0,975; AVE = 0,783), morbidade referida (CR = 0,902; AVE = 0,472) e fatores de redução da produtividade (CR = 0,863; AVE = 0,581) apresentaram os melhores indicadores de consistência interna, sendo que os fatores de cultura de segurança e os fatores de redução da produtividade também apresentaram evidências satisfatórias de validade convergente (AVE > 0,50). O fator bem-estar mental apresentou confiabilidade composta satisfatória (CR = 0,705), embora a variância média extraída tenha permanecido abaixo do valor recomendado (AVE = 0,293). Em contrapartida, os fatores comportamentais (CR = 0,502; AVE = 0,208) e os fatores relacionados à percepção de saúde e autocuidado (CR = 0,486; AVE = 0,284) apresentaram valores reduzidos de confiabilidade composta e validade convergente, indicando menor homogeneidade entre seus indicadores. Esses resultados podem ser explicados pela natureza multidimensional e pela heterogeneidade dos componentes desses construtos, que reúnem comportamentos, percepções e características conceitualmente distintas e que, portanto, não necessariamente apresentam elevada consistência interna ou elevada convergência entre seus indicadores. Apesar disso, optou-se por manter a estrutura fatorial proposta, considerando conjuntamente os indicadores de ajuste do modelo e a coerência teórica dos fatores avaliados.

Coleta de dados

Os dados foram coletados no período de julho a dezembro de 2025, sendo este processo realizado por equipe de profissionais de saúde designada pelo Departamento Regional do SESI em cada estado brasileiro. Os dados foram coletados de forma anonimizada (sem identificação do trabalhador), garantindo-se que mesmo após a aceitação da empresa em permitir a realização do estudo, cada trabalhador pudesse declinar de colaborar, independentemente da justificativa eventualmente apresentada. Nas empresas participantes, a equipe de pesquisa foi orientada a convidar todos os trabalhadores elegíveis. Nas empresas de médio e grande porte, buscou-se contemplar trabalhadores dos diferentes setores incluindo administração, produção, logística, bem como dos diferentes turnos de trabalho.

Definição operacional de indicadores

A definição operacional dos indicadores que foram analisados nesse estudo está apresentada, em destaque, no capítulo de resultados, no início de cada seção. A operacionalização das variáveis de interesse foi realizada de modo a expressar condutas ou fatores de risco à saúde, exceto no caso dos indicadores de cultura de segurança, cujas prevalências denotam aspectos positivos desse constructo.

Tratamento dos dados de massa (peso) e estatura (altura) corporal

As informações sobre massa corporal e estatura foram autorreferidas pelos participantes. As variáveis de massa corporal e estatura foram submetidas a procedimentos de padronização e controle de qualidade dos dados. Inicialmente, realizou-se a verificação de consistência das unidades de medida, sendo valores de estatura informados entre 120 e 230 interpretados como registros em centímetros e convertidos para metros. Após a padronização das unidades, foram aplicados critérios conservadores de plausibilidade biológica para adultos, considerando-se válidos valores de estatura entre 1,20 e 2,30 metros e de massa corporal entre 30 e 300 quilogramas. Registros fora dessas faixas, bem como valores inconsistentes, foram tratados como ausentes, sem substituição por valores estimados. A partir dos valores válidos de massa e estatura corporal, valores de IMC fora da faixa de plausibilidade (inferiores a 10 ou superiores a 80 kg/m²) também foram considerados inconsistentes e tratados como ausentes. A consistência das transformações foi avaliada com base na verificação da distribuição dos dados e na aplicação dos critérios de plausibilidade, garantindo a adequação das unidades e a remoção de registros inconsistentes. As referências técnicas para os critérios de plausibilidade biológica (ou valores biologicamente implausíveis, BIV) para medidas antropométricas estão baseados, predominantemente, nas normas da Organização Mundial da Saúde[19].

Análise de dados

As análises estatísticas foram realizadas considerando os indicadores como variáveis binárias, apresentando-se o número de respondentes e prevalências ponderadas com respectivos intervalos de confiança de 95%. As análises consideraram a estimação da prevalência para a amostra total e segundo características demográficas, região geográfica e porte da empresa.

Inicialmente, a estratégia de ponderação considerou o número de respondentes por unidade amostral (empresa), ajustando-se a precisão das estimativas pelo tamanho amostral efetivo de Kish. O peso atribuído a cada participante foi calculado como o inverso do número de respondentes de cada conglomerado, adotando-se essa estratégia a fim de corrigir o efeito de conglomeração decorrente da estratégia amostral adotada. Esse fator de ponderação foi denominado como “w_cluster”. Além disso, a distribuição da amostra por região geográfica era diferente do estimado para população de trabalhadores do setor industrial segundo dados da Relação Anual de Informações Sociais do Ministério do Trabalho e Emprego (Tabela 2). Por essa razão, recorreu-se também ao cálculo de pesos amostrais segundo região geográfica, mediante

cálculo da razão entre a proporção da população e a proporção da amostra em cada região. Esse fator de ponderação foi denominado como “w_região”. Em seguida, procedeu-se ao cálculo do peso combinado resultante da multiplicação dos dois fatores de ponderação (w_cluster*w_região) e, posteriormente, ao cálculo do peso combinado normalizado (=peso combinado*[tamanho da amostra/soma dos pesos combinados]). O peso combinado normalizado foi então atribuído a cada trabalhador que participou do estudo, como estratégia para ponderação das estimativas apresentadas neste relatório.

As diferenças observadas entre as categorias foram examinadas de forma descritiva, considerando as estimativas pontuais e a amplitude dos respectivos intervalos de confiança, sem a realização de testes de hipótese. Para a estimativa da prevalência de artrite ou reumatismo na região Norte, realizou-se uma análise de sensibilidade motivada pela identificação de elevada concentração dos pesos e consequente redução do tamanho amostral efetivo. Nessa análise, os pesos foram recalculados no nível da empresa e os valores superiores ao percentil 95 foram substituídos pelo valor correspondente a esse percentil, reduzindo a influência de observações com pesos extremos. A estimativa obtida com esse procedimento foi utilizada na apresentação do resultado da região Norte. Esse ajuste foi aplicado exclusivamente a essa estimativa, permanecendo os pesos originais nas demais regiões e análises. As análises foram executadas no Databricks utilizando Python e PySpark, e as bibliotecas pandas, NumPy, Matplotlib e Seaborn.

Aspectos éticos

O consentimento livre e esclarecido foi obtido de cada trabalhador após leitura do termo. Essa manifestação de concordância voluntária em participar do estudo foi registrada eletronicamente quando o trabalhador respondia afirmativamente a essa pergunta no próprio *chatbot*. O protocolo para realização desse estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com seres humanos do Complexo Hospitalar HUOC/PROCAPE (CAAE: 70116523.3.0000.5192; Parecer Nº 6.163.495).

RESULTADOS

Características demográficas dos trabalhadores do setor industrial

No período de julho a dezembro de 2025 foram entrevistados 57.952 trabalhadores vinculados a 825 empresas do setor industrial, distribuídas por porte e regiões geográficas, conforme apresentado na Tabela 2.

Tabela 2. Distribuição da amostra por porte de empresa e por região geográfica. SESI, Brasil, 2025.

Variável demográfica	Categoria	Empresas	Trabalhadores
		n (%)	n (%)
Porte da empresa	Microempresa	146 (17,7%)	3.132 (5,4%)
	Empresa de Pequeno Porte	144 (17,5%)	3.699 (6,4%)
	Médio e Grande Porte	535 (64,8%)	51.121 (88,2%)
Região geográfica	Norte	110 (13,3%)	4.995 (8,6%)
	Nordeste	282 (34,2%)	17.946 (31,0%)
	Centro-oeste	143 (17,3%)	8.981 (15,5%)
	Sudeste	93 (11,3%)	9.228 (15,9%)
	Sul	197 (23,9%)	16.802 (29,0%)

Fonte: próprio autor.

Conforme mencionado na seção “Aspectos Metodológicos”, segundo dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) do Ministério do Trabalho e Emprego, relativos ao ano de 2023, estima-se que a proporção de trabalhadores formais no setor industrial estava distribuída por região geográfica do seguinte modo: Norte (4,2%), Nordeste (13,9%), Centro-oeste (7,1%), Sudeste (48,8%) e Sul (26%). Em comparação com essa distribuição, observa-se na amostra sub-representação de trabalhadores da região Sudeste e sobre-representação das demais regiões geográficas, razão pela qual as análises foram ponderadas conforme descrito na seção de procedimentos metodológicos a fim de corrigir essa distorção e evitar estimativas enviesadas dos indicadores.

Como apresentado na Tabela 3, entre os trabalhadores participantes do estudo, a força de trabalho no setor industrial é majoritariamente constituída por homens (63,7%) e pessoas jovens (63,9% abaixo de 40 anos), com estrutura familiar caracterizada por pessoas casadas (58,2%) e que têm filhos (62,3%). Destaca-se, ainda, a elevada proporção de trabalhadores que têm, pelo menos, o ensino médio ou técnico completo (77,5%), perfil que difere do observado na população brasileira, em que a proporção dos que alcançaram esse nível de escolaridade é de somente 54,1%[20]. Quanto

ao tempo de trabalho na empresa, 69,3% estavam empregados há até cinco anos.. Pouco mais da metade dos trabalhadores participantes do estudo (53,7%) referiu ter acesso a plano de saúde, proporção superior à observada na população brasileira (24,5%)[21].

Tabela 3. Características demográficas dos participantes (n= 57.952) e respectivas estimativas ponderadas. SESI, Brasil, 2025.

Variável demográfica	Categoria	% (IC95%)
Sexo biológico	Masculino	63,7 (63,3-64,1)
	Feminino	36,3 (35,9-36,7)
Faixa etária (anos)	<30	33,6 (33,2-34,0)
	30-39	30,3 (29,9-30,7)
	40-59	33,5 (33,1-33,9)
	≥60	2,6 (2,4-2,7)
Situação conjugal	Solteiro(a)	37,3 (36,9-37,6)
	Casado(a) ou vivendo com parceiro(a)	58,2 (57,8-58,6)
	Viúvo(a), desquitado(a) ou divorciado(a)	4,5 (4,4-4,7)
Escolaridade	Ensino fundamental incompleto	10,1 (9,8-10,3)
	Ensino fundamental completo	12,4 (12,2-12,7)
	Ensino médio ou técnico completo	39,6 (39,2-40,0)
	Ensino superior incompleto	15,6 (15,3-15,9)
	Ensino superior completo	22,3 (21,9-22,6)
Número de filhos	Nenhum	37,7 (37,3-38,1)
	1 filho(a)	26,6 (26,2-26,9)
	2 a 3 filhos(as)	31,0 (30,6-31,4)
	4 ou mais filhos(as)	4,7 (4,6-4,9)
Acesso a plano de saúde	Não	46,3 (45,9-46,7)
	Sim	53,7 (53,3-54,1)
Tempo de trabalho na empresa	Menos de 1 ano	28,8 (28,4-29,1)
	Entre 1 e 5 anos	40,5 (40,1-40,9)
	Entre 5 e 10 anos	12,5 (12,3-12,8)
	Mais de 10 anos	18,2 (17,9-18,5)

Fonte: próprio autor.

Fatores comportamentais de risco à saúde

[Inserir uma página com ilustração adequada a essa dimensão]

Tabagismo

> Considerou-se “tabagismo” quando o(a) trabalhador(a) referiu fumar, independentemente do tempo, da regularidade (ocasional/regular) e da intensidade (quantidade de cigarros) de exposição a esta conduta de risco à saúde.

A prevalência de tabagismo foi de 6,5% (IC95%: 6,0-7,1). Entre os homens, a prevalência foi de 8,3% enquanto entre as mulheres foi de 3,9%. Segundo a situação conjugal, a menor estimativa foi observada entre trabalhadores casados(as) ou pessoas que viviam com parceiros(as). Em relação à escolaridade, observou-se redução progressiva da prevalência de tabagismo com o aumento do nível de escolaridade, variando de 13,3% entre trabalhadores com ensino fundamental incompleto a 3,2% entre aqueles com ensino superior completo. Os resultados segundo as demais características demográficas estão apresentados na Tabela 4.

Tabela 4. Prevalência (IC95%) de **tabagismo** em trabalhadores(as) da indústria, segundo características demográficas. SESI, 2025.

Variável demográfica	Categoria	% (IC95%)
Sexo biológico	Masculino	**8,3** (7,7-9,0)
	Feminino	**3,9** (3,1-4,8)
Faixa etária (anos)	<30	**7,1** (6,3-8,1)
	30-39	**5,9** (4,9-7,0)
	40-59	**6,5** (5,7-7,3)
	≥60	**9,4** (7,1-12,5)
Situação conjugal	Solteiro(a)	**7,6** (6,7-8,6)
	Casado(a) ou vivendo com parceiro(a)	**5,7** (5,0-6,4)
	Viúvo(a), desquitado(a) ou divorciado(a)	**8,4** (6,3-11,0)
Escolaridade	Ensino fundamental incompleto	**13,3** (11,4-15,4)
	Ensino fundamental completo	**11,2** (9,7-12,9)
	Ensino médio ou técnico completo	**6,5** (5,6-7,5)
	Ensino superior incompleto	**5,6** (4,3-7,1)
	Ensino superior completo	**3,2** (2,5-4,0)
Número de filhos	Nenhum	**5,5** (4,8-6,3)
	1 filho(a)	**6,1** (5,2-7,1)
	2 a 3 filhos(as)	**7,5** (6,4-8,8)
	4 ou mais filhos(as)	**11,2** (9,3-13,4)
Acesso a plano de saúde	Não	**7,9** (7,2-8,7)
	Sim	**5,5** (4,8-6,3)
Tempo de trabalho na empresa	Menos de 1 ano	**8,5** (7,6-9,5)
	Entre 1 e 5 anos	**6,0** (5,3-6,9)
	Entre 5 e 10 anos	**7,0** (5,2-9,5)
	Mais de 10 anos	**4,3** (3,6-5,2)

Fonte: próprio autor.

De modo geral, as prevalências de tabagismo apresentaram pequena variação entre as regiões geográficas, com maior valor observado na região Sul (8,9%) e menores valores nas regiões Nordeste e Sudeste (Figura 3). Em relação ao porte das empresas, as prevalências observadas foram de 6,9% (IC95%: 5,9-8,1) entre trabalhadores de micro e pequenas empresas e de 6,4% (IC95%: 5,8-7,0) entre aqueles vinculados a empresas de médio e grande porte.

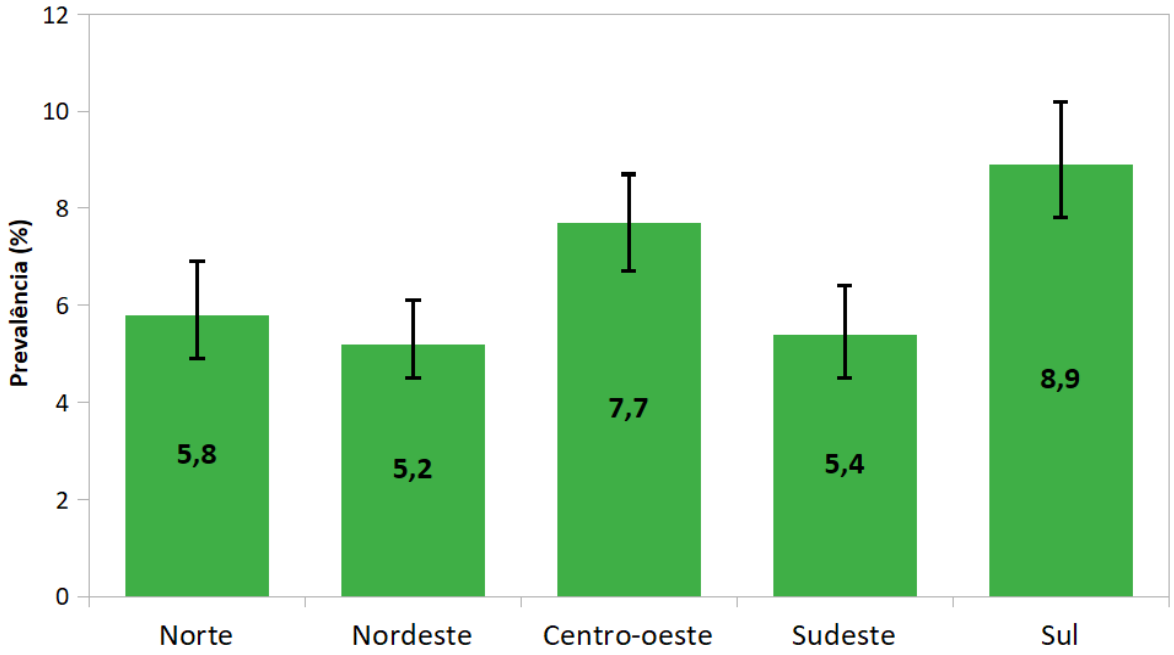


Figura 3. Prevalência de **tabagismo** em trabalhadores(as) da indústria, segundo região geográfica. As colunas representam as estimativas de prevalência e as barras de erro indicam os intervalos de confiança de 95% (IC95%). SESI, 2025.

Fonte: próprio autor.

Consumo episódico pesado de bebidas alcoólicas

> Considerou-se consumo episódico pesado de bebidas alcoólicas quando o(a) trabalhador(a) referiu que, nos últimos 30 dias, ingeriu cinco ou mais doses (para homens) ou quatro ou mais doses (para mulheres) de bebidas alcoólicas numa mesma ocasião.

Os inquéritos realizados pelo Ministério da Saúde (MS) monitoram, desde 2006, a prevalência do consumo episódico pesado de bebidas alcoólicas. Em 2024, o MS afirmou que não há consumo seguro de bebidas alcoólicas, conforme apontado em Nota Técnica[22]. O documento também apresenta uma síntese das evidências acerca da relação entre consumo de bebidas alcoólicas e as

doenças crônicas não transmissíveis, bem como com as causas externas (violências e acidentes) e doenças transmissíveis. Há duas formas de caracterizar o consumo pesado em inquéritos de saúde, o consumo excessivo regular e o consumo excessivo ocasional, sendo que esta última forma é mais comumente observada em trabalhadores do setor industrial[23], além de ter maior nexo causal com as chamadas causas externas (acidentes e violência)[24].

A prevalência de consumo episódico pesado de bebidas alcoólicas foi de 34,2% (IC95%: 32,4-36,0), sendo de 37,4% entre os homens e de 29,5% entre as mulheres. As estimativas segundo faixa etária, situação conjugal, escolaridade, número de filhos, acesso a plano de saúde e tempo de trabalho na empresa estão apresentadas na Tabela 5.

Tabela 5. Prevalência (IC95%) de **consumo episódico pesado de bebidas alcoólicas** em trabalhadores(as) da indústria, segundo características demográficas. SESI, 2025.

Variável demográfica	Categoria	% (IC95%)
Sexo biológico	Masculino	**37,4** (35,5-39,3)
	Feminino	**29,5** (26,3-33,0)
Faixa etária (anos)	<30	**34,5** (31,6-37,5)
	30-39	**33,4** (30,2-36,8)
	40-59	**34,7** (31,7-37,8)
	≥60	**33,1** (28,4-38,2)
Situação conjugal	Solteiro(a)	**35,4** (32,4-38,6)
	Casado(a) ou vivendo com parceiro(a)	**33,2** (31,0-35,5)
	Viúvo(a), desquitado(a) ou divorciado(a)	**36,7** (32,0-41,7)
Escolaridade	Ensino fundamental incompleto	**32,7** (29,5-36,2)
	Ensino fundamental completo	**38,8** (35,0-42,7)
	Ensino médio ou técnico completo	**35,4** (32,9-37,9)
	Ensino superior incompleto	**37,0** (31,6-42,7)
	Ensino superior completo	**29,5** (25,7-33,7)
Número de filhos	Nenhum	**33,8** (30,8-37,0)
	1 filho(a)	**33,4** (30,3-36,6)
	2 a 3 filhos(as)	**35,1** (31,9-38,5)
	4 ou mais filhos(as)	**35,6** (31,7-39,6)
Acesso a plano de saúde	Não	**33,0** (31,0-35,1)
	Sim	**35,0** (32,4-37,7)
Tempo de trabalho na empresa	Menos de 1 ano	**32,5** (29,8-35,2)
	Entre 1 e 5 anos	**35,0** (32,0-38,0)
	Entre 5 e 10 anos	**39,4** (33,5-45,6)
	Mais de 10 anos	**31,1** (28,0-34,3)

Fonte: próprio autor.

As estimativas de consumo episódico pesado apresentaram variação entre as regiões geográficas, com maior valor observado na região Centro-Oeste e menor na região Sul (Figura 4). Segundo o porte da empresa, a prevalência foi de 37,3% (IC95%: 33,6-41,1) entre trabalhadores de micro e pequenas empresas e de 33,2% (IC95%: 31,3-35,3) entre aqueles de empresas de médio e grande porte.

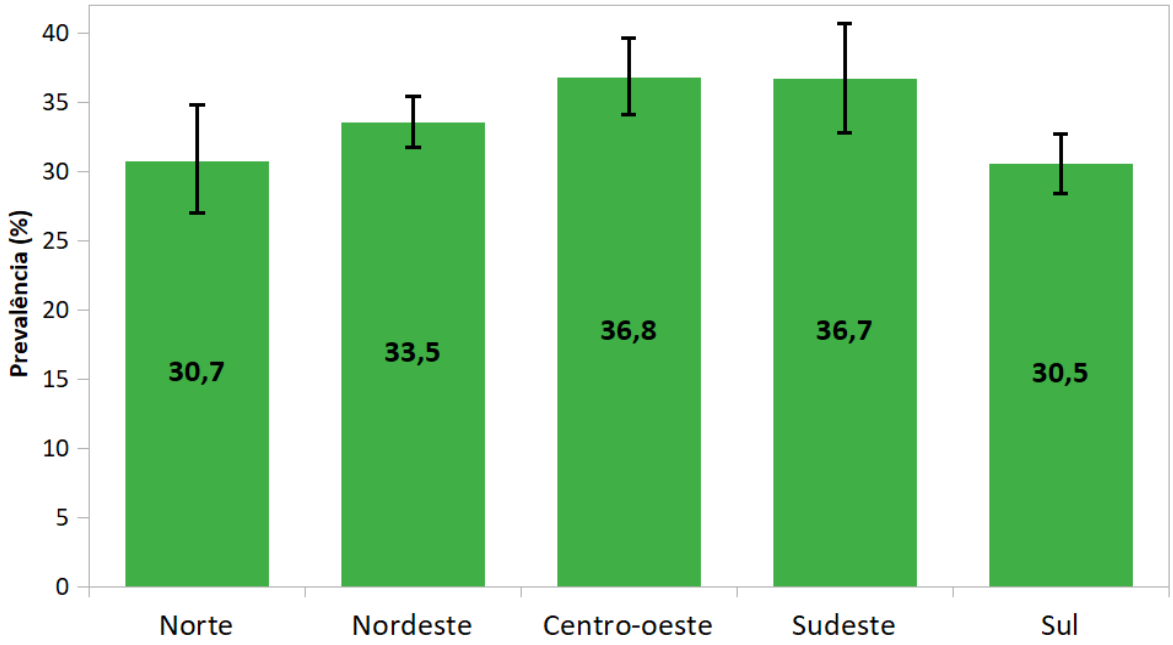


Figura 4. Prevalência de **consumo episódio pesado de bebidas alcoólicas** em trabalhadores(as) da indústria, segundo região geográfica. As colunas representam as estimativas de prevalência e as barras de erro indicam os intervalos de confiança de 95% (IC95%). SESI, 2025.

Fonte: próprio autor.

Baixa frequência de consumo de frutas ou hortaliças

> Considerou-se baixa frequência de consumo de frutas ou hortaliças quando o(a) trabalhador(a) referiu que numa semana normal fazia consumo de um destes dois grupos de alimentos com frequência inferior a 4 a 6 vezes por semana.

Frutas e hortaliças são subgrupos alimentares que devem estar presentes na alimentação diária de todas as pessoas[15-16]. Neste inquérito, 71,2% (IC95%: 69,5-72,9) dos(as) trabalhadores(as) referiram frequência de consumo de frutas e/ou hortaliças inferior a 4 a 6 vezes por semana. A prevalência foi de 75,0% entre os homens (frente aos 65,6% entre as mulheres) e de 76,7% entre trabalhadores sem acesso a plano de saúde (frente aos 67,2% entre aqueles com acesso).

Observou-se, redução das estimativas de prevalência com o aumento da faixa etária, da escolaridade e do tempo de trabalho na empresa. (Tabela 6).

Tabela 6. Prevalência (IC95%) de **baixa frequência de consumo de frutas ou hortaliças** em trabalhadores(as) da indústria, segundo características demográficas. SESI, 2025.

Variável demográfica	Categoria	% (IC95%)
Sexo biológico	Masculino	**75,0** (73,3-76,7)
	Feminino	**65,6** (62,3-68,9)
Faixa etária (anos)	<30	**78,1** (76,3-79,7)
	30-39	**70,6** (67,1-73,8)
	40-59	**66,5** (63,3-69,6)
	≥60	**61,2** (56,4-65,9)
Situação conjugal	Solteiro(a)	**71,3** (68,2-74,2)
	Casado(a) ou vivendo com parceiro(a)	**71,2** (69,0-73,3)
	Viúvo(a), desquitado(a) ou divorciado(a)	**70,1** (65,9-74,1)
Escolaridade	Ensino fundamental incompleto	**78,1** (75,5-80,6)
	Ensino fundamental completo	**79,0** (76,5-81,2)
	Ensino médio ou técnico completo	**74,4** (72,0-76,7)
	Ensino superior incompleto	**70,3** (65,4-74,8)
	Ensino superior completo	**62,2** (57,8-66,4)
Número de filhos	Nenhum	**72,7** (70,1-75,2)
	1 filho(a)	**71,8** (68,6-74,9)
	2 a 3 filhos(as)	**68,6** (65,1-71,9)
	4 ou mais filhos(as)	**72,3** (68,2-76,1)
Acesso a plano de saúde	Não	**76,7** (74,1-77,2)
	Sim	**67,2** (64,6-69,8)
Tempo de trabalho na empresa	Menos de 1 ano	**77,1** (74,9-79,2)
	Entre 1 e 5 anos	**73,7** (71,2-76,0)
	Entre 5 e 10 anos	**68,5** (62,8-73,8)
	Mais de 10 anos	**58,8** (54,2-63,3)

Fonte: próprio autor.

De modo geral, as estimativas de baixa frequência de consumo de frutas ou hortaliças foram elevadas em todas as regiões geográficas (Figura 5). Segundo o porte da empresa, a prevalência foi de 71,0% (IC95%: 66,8-74,8) entre trabalhadores vinculados a empresas de menor porte e de 71,3% (IC95%: 69,4-73,1) entre aqueles vinculados a empresas de maior porte.

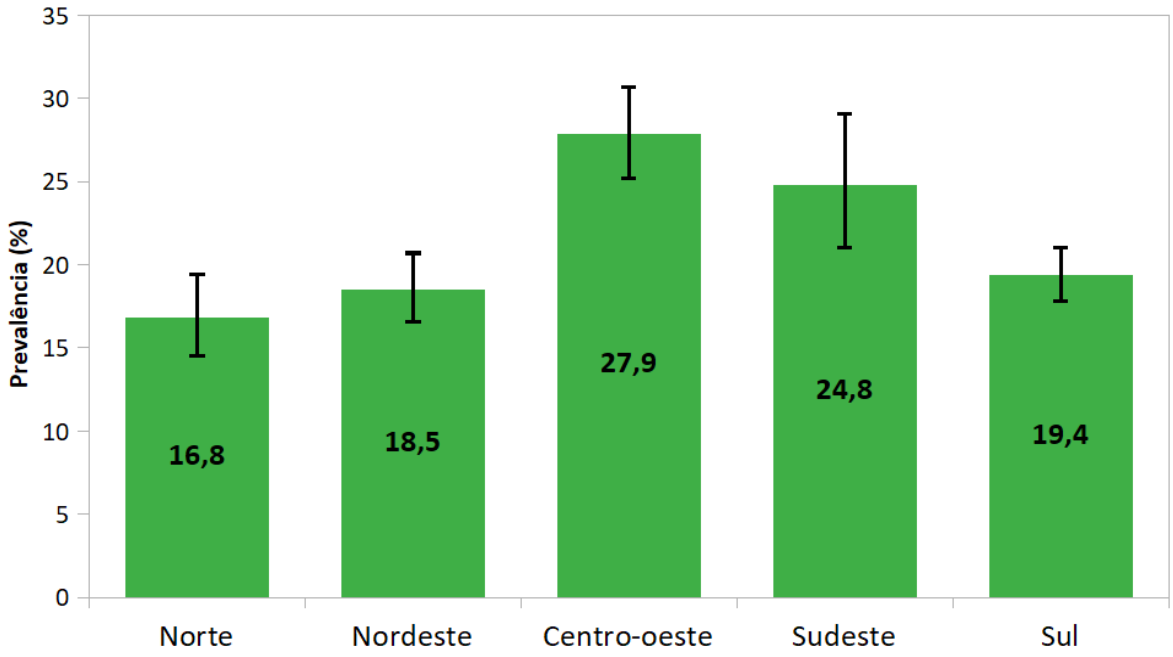


Figura 5. Prevalência de **baixa frequência de consumo de frutas ou hortaliças** em trabalhadores(as) da indústria, segundo região geográfica. As colunas representam as estimativas de prevalência e as barras de erros indicam os intervalos de confiança de 95% (IC95%). SESI, 2025. Fonte: próprio autor.

Elevada frequência de consumo de refrigerantes ou sucos artificiais

> Considerou-se elevada frequência de consumo de refrigerantes ou sucos artificiais quando o(a) trabalhador(a) referiu que, numa semana normal, consome essas bebidas, pelo menos, 4 a 6 vezes por semana.

Refrigerantes e bebidas artificiais devem ser evitados, não podendo estar presentes na alimentação diária das pessoas[25-26]. Além disso, a substituição por bebidas adoçadas artificialmente ou por refrigerantes "zero" ou "diet" não parece reduzir o efeito deletério desse hábito em relação à saúde[27-28].

Entre os(as) trabalhadores(as) do setor industrial participantes deste estudo, a prevalência de consumo frequente de refrigerantes ou sucos artificiais foi de 22,2% (IC95%: 20,4-24,0). As maiores estimativas foram observadas entre trabalhadores com menos de 30 anos (27,4%) e entre aqueles com ensino superior incompleto (24,4%). Em relação ao tempo de trabalho na empresa, as estimativas variaram de 25,7% entre trabalhadores com menos de um ano de vínculo a 14,6% entre aqueles com mais de dez anos (Tabela 7). As prevalências apresentaram variação entre as regiões geográficas, com menores estimativas nas regiões Norte e Nordeste e maiores nas regiões

Centro-Oeste e Sudeste (Figura 6). Segundo o porte da empresa, a prevalência foi de 21,9% (IC95%: 18,8-25,4) entre trabalhadores vinculados a empresas de menor porte e de 22,2% (IC95%: 20,2-24,4) entre aqueles vinculados a empresas de maior porte.

Tabela 7. Prevalência (IC95%) de **consumo excessivo de refrigerantes ou sucos artificiais** em trabalhadores(as) da indústria, segundo características demográficas. SESI, 2025.

Variável demográfica	Categoria	% (IC95%)
Sexo biológico	Masculino	**22,6** (20,8-24,6)
	Feminino	**21,5** (18,3-25,1)
Faixa etária (anos)	<30	**27,4** (24,8-30,2)
	30-39	**24,2** (20,5-28,3)
	40-59	**15,8** (13,6-18,3)
	≥60	**17,1** (13,9-20,8)
Situação conjugal	Solteiro(a)	**24,4** (21,3-27,8)
	Casado(a) ou vivendo com parceiro(a)	**20,9** (18,8-23,2)
	Viúvo(a), desquitado(a) ou divorciado(a)	**19,4** (15,8-23,4)
Escolaridade	Ensino fundamental incompleto	**20,5** (17,9-23,5)
	Ensino fundamental completo	**20,5** (18,2-23,0)
	Ensino médio ou técnico completo	**24,3** (21,7-27,2)
	Ensino superior incompleto	**24,4** (20,0-29,3)
	Ensino superior completo	**19,0** (15,0-23,8)
Número de filhos	Nenhum	**25,5** (22,4-28,8)
	1 filho(a)	**23,0** (19,2-27,3)
	2 a 3 filhos(as)	**17,4** (15,7-19,2)
	4 ou mais filhos(as)	**21,1** (17,8-24,9)
Acesso a plano de saúde	Não	**21,6** (19,3-24,0)
	Sim	**22,6** (20,1-25,3)
Tempo de trabalho na empresa	Menos de 1 ano	**25,7** (22,5-29,1)
	Entre 1 e 5 anos	**24,4** (21,3-27,8)
	Entre 5 e 10 anos	**18,4** (15,5-21,7)
	Mais de 10 anos	**14,6** (12,2-17,3)

Fonte: próprio autor.

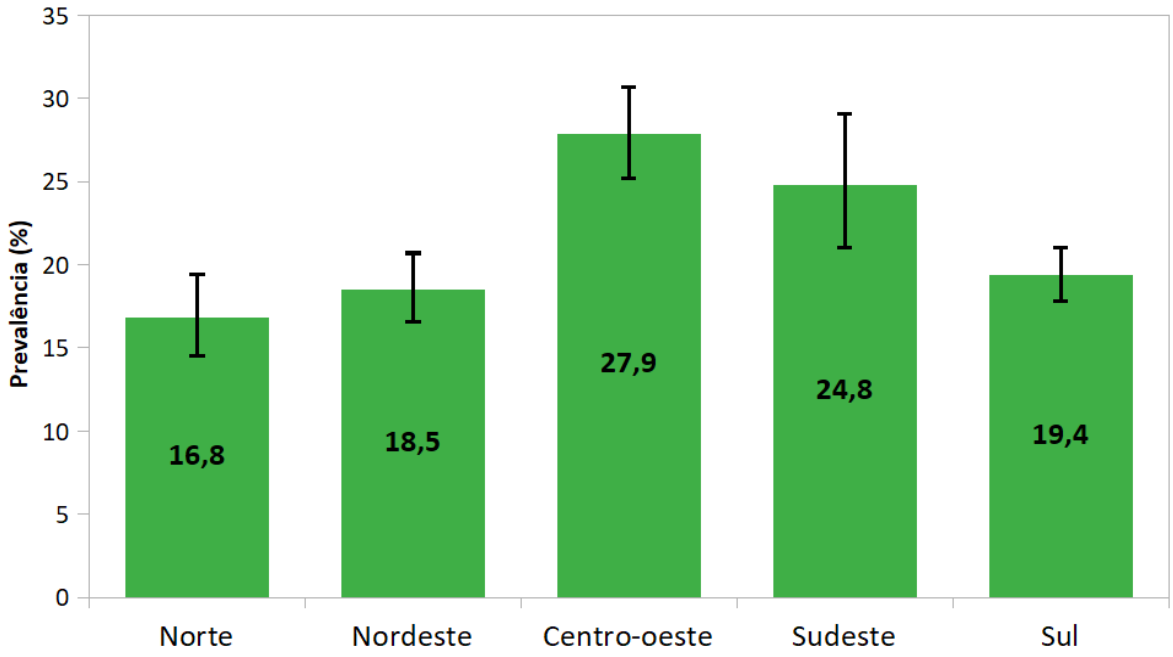


Figura 6. Prevalência (%) de **consumo excessivo de refrigerantes ou sucos artificiais** em trabalhadores(as) da indústria, segundo região geográfica. As colunas representam as estimativas de prevalência e as barras de erro indicam os intervalos de confiança de 95% (IC95%). SESI, 2025. Fonte: próprio autor.

Inatividade física no lazer

> Considerou-se inatividade física no lazer quando o(a) trabalhador(a) referiu que não realiza regularmente atividades físicas no lazer, tais como esportes, exercícios físicos, danças ou artes marciais.

A prática de atividades físicas constitui fator de proteção para diversas doenças crônicas não transmissíveis, além de estar associada à qualidade de vida em pessoas de todas as idades[29]. A prevalência de inatividade física no lazer foi de 44,3% (IC95%: 42,4-46,1), sendo de 49,4% entre as mulheres e de 40,7% entre os homens. As estimativas foram menores entre trabalhadores com níveis mais elevados de escolaridade e aumentaram conforme o número de filhos, variando de 42,3% entre aqueles sem filhos a 52,8% entre os que tinham quatro ou mais filhos (Tabela 8).

Segundo a região geográfica, a menor prevalência de inatividade física no lazer foi observada na região Nordeste (39,9%) e a maior na região Norte (54,7%), correspondendo a uma diferença aproximada de 15 pontos percentuais (Figura 7). Segundo o porte da empresa, a prevalência foi de 49,6% (IC95%: 46,0-53,3) entre trabalhadores de micro e pequenas empresas e de 42,6% (IC95%: 40,5-44,8) entre aqueles vinculados a empresas de médio e grande porte.

Tabela 8. Prevalência (IC95%) de **inatividade física no lazer** em trabalhadores(as) da indústria, segundo características demográficas. SESI, 2025.

Variável demográfica	Categoria	% (IC95%)
Sexo biológico	Masculino	**40,7** (38,7-42,7)
	Feminino	**49,4** (46,0-50,9)
Faixa etária (anos)	<30	**41,1** (38,4-43,9)
	30-39	**46,4** (42,6-50,1)
	40-59	**44,5** (41,5-47,7)
	≥60	**47,5** (42,6-52,5)
Situação conjugal	Solteiro(a)	**42,6** (39,4-45,8)
	Casado(a) ou vivendo com parceiro(a)	**45,6** (43,2-48,1)
	Viúvo(a), desquitado(a) ou divorciado(a)	**39,7** (35,0-44,7)
Escolaridade	Ensino fundamental incompleto	**60,0** (55,6-64,2)
	Ensino fundamental completo	**52,0** (47,6-56,4)
	Ensino médio ou técnico completo	**44,4** (41,9-47,0)
	Ensino superior incompleto	**36,8** (32,4-41,5)
	Ensino superior completo	**40,5** (35,8-45,3)
Número de filhos	Nenhum	**42,3** (39,1-45,5)
	1 filho(a)	**43,4** (39,9-47,0)
	2 a 3 filhos(as)	**46,5** (43,1-49,9)
	4 ou mais filhos(as)	**52,8** (48,3-57,2)
Acesso a plano de saúde	Não	**49,7** (47,4-52,1)
	Sim	**40,3** (37,6-43,0)
Tempo de trabalho na empresa	Menos de 1 ano	**47,8** (44,5-51,1)
	Entre 1 e 5 anos	**43,1** (40,1-46,0)
	Entre 5 e 10 anos	**40,3** (34,9-46,0)
	Mais de 10 anos	**44,8** (40,6-49,1)

Fonte: próprio autor.

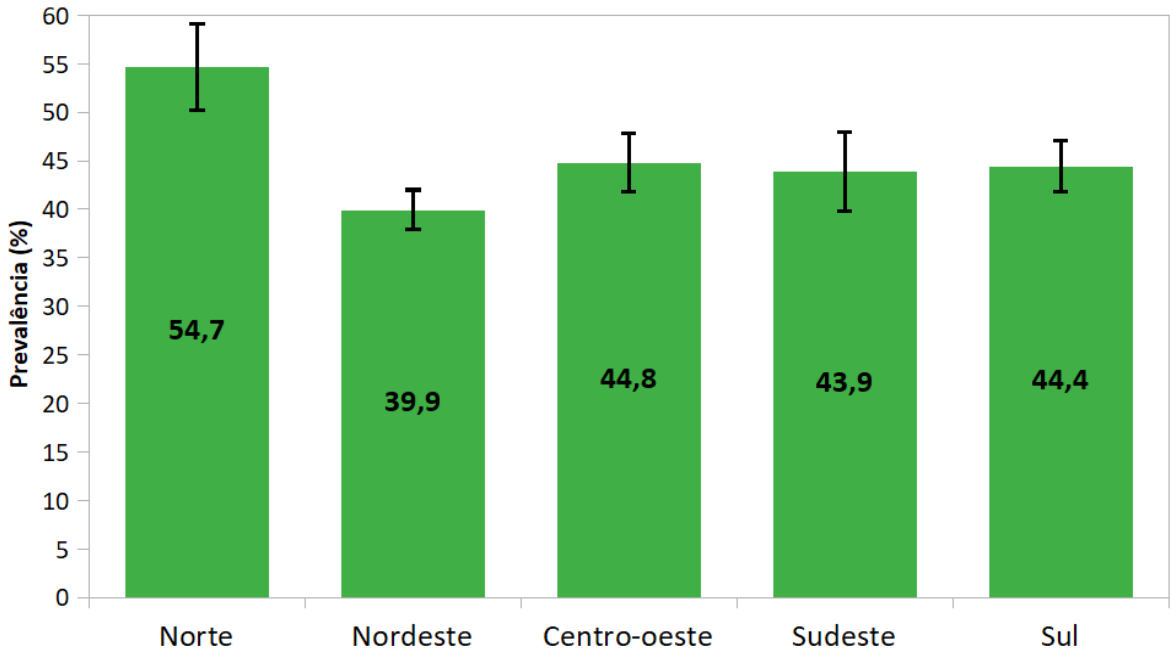


Figura 7. Prevalência de **inatividade física no lazer** em trabalhadores(as) da indústria, segundo região geográfica. As colunas representam as estimativas de prevalência e as barras de erro indicam os intervalos de confiança de 95% (IC95%). SESI, 2025.

Fonte: próprio autor.

Tempo prolongado de TV

> Considerou-se tempo prolongado de TV quando o(a) trabalhador(a) referiu que assistiu, em média, três ou mais horas de TV por dia.

O tempo de TV é um marcador que, apesar do maior acesso a outros tipos de tela, continua sendo importante no monitoramento do comportamento sedentário, especialmente em populações adultas[30-31]. Não há consenso em relação a um ponto de corte preciso que possa diferenciar níveis seguros de exposição, mas assistir a três ou mais horas de TV por dia é considerado indicador de elevada exposição a comportamento sedentário.

Entre os(as) trabalhadores(as) da indústria, a prevalência de tempo prolongado de TV foi de 8,1% (IC95%: 6,8-9,6). Segundo a situação conjugal, a maior estimativa foi observada entre trabalhadores viúvos, desquitados ou divorciados (12,3%). Os resultados segundo as demais características demográficas estão apresentados na Tabela 9. Entre as regiões geográficas, a maior prevalência foi observada no Sudeste (10,8%) (Figura 8). Segundo o porte da empresa, a prevalência foi de 8,4% (IC95%: 5,7-12,2) entre trabalhadores vinculados a empresas de menor porte e de 8,0% (IC95%: 6,6-9,7) entre aqueles vinculados a empresas de maior porte.

Tabela 9. Prevalência (IC95%) de **tempo prolongado de TV** em trabalhadores(as) da indústria, segundo características demográficas. SESI, 2025.

Variável demográfica	Categoria	% (IC95%)
Sexo biológico	Masculino	**8,5** (7,1-10,0)
	Feminino	**7,6** (5,3-10,7)
Faixa etária (anos)	<30	**7,1** (6,1-8,3)
	30-39	**7,6** (5,6-10,3)
	40-59	**9,4** (6,7-13,1)
	≥60	**9,1** (6,8-12,1)
Situação conjugal	Solteiro(a)	**7,7** (5,9-10,1)
	Casado(a) ou vivendo com parceiro(a)	**8,1** (6,3-10,2)
	Viúvo(a), desquitado(a) ou divorciado(a)	**12,3** (7,8-19,0)
Escolaridade	Ensino fundamental incompleto	**8,2** (5,9-11,3)
	Ensino fundamental completo	**8,1** (6,9-9,4)
	Ensino médio ou técnico completo	**8,3** (6,6-10,5)
	Ensino superior incompleto	**8,2** (4,7-13,8)
	Ensino superior completo	**7,8** (5,1-11,7)
Número de filhos	Nenhum	**8,6** (6,6-11,0)
	1 filho(a)	**7,6** (5,2-10,8)
	2 a 3 filhos(as)	**7,9** (5,7-10,9)
	4 ou mais filhos(as)	**8,9** (7,0-11,2)
Acesso a plano de saúde	Não	**6,6** (5,8-7,4)
	Sim	**9,2** (7,2-11,8)
Tempo de trabalho na empresa	Menos de 1 ano	**6,3** (5,3-7,6)
	Entre 1 e 5 anos	**8,4** (6,3-11,2)
	Entre 5 e 10 anos	**6,8** (5,6-8,2)
	Mais de 10 anos	**10,8** (7,0-16,3)

Fonte: próprio autor.

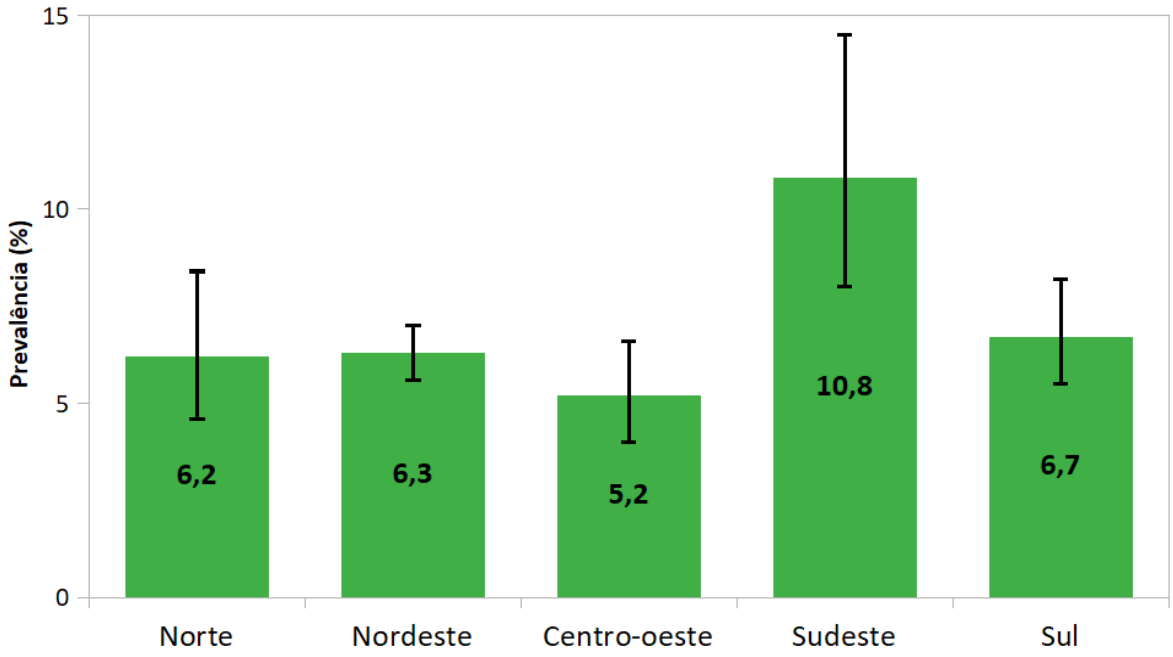


Figura 8. Prevalência de **tempo prolongado de TV** em trabalhadores(as) da indústria, segundo região geográfica. As colunas representam as estimativas de prevalência e as barras de erro indicam os intervalos de confiança de 95% (IC95%). SESI, 2025.

Fonte: próprio autor.

Tempo prolongado de tela

> Considerou-se tempo prolongado de tela quando o(a) trabalhador(a) referiu que passou, em média, três ou mais horas por dia usando o computador, tablet ou celular para participar de redes sociais, para ver filmes ou para se distrair com jogos.

O tempo de tela é, também, um importante indicador de comportamento sedentário e considera a exposição a diversos dispositivos eletrônicos de uso comum atualmente (computador, celular, tablet). Trata-se de comportamento de risco que está associado a diversos eventos de saúde[30-31].

Nesta amostra, a prevalência de tempo prolongado de tela foi de 33,9% (IC95%: 32,0-35,8), sendo de 40,5% entre as mulheres e de 29,3% entre os homens. Observou-se redução das estimativas com o aumento da faixa etária, variando de 48,4% entre trabalhadores com menos de 30 anos a 14,1% entre aqueles com 60 anos ou mais. Segundo a situação conjugal, a prevalência foi de 42,2% entre trabalhadores solteiros e de 28,7% entre casados ou que viviam com parceiro(a). Em relação à escolaridade, a maior estimativa foi observada entre trabalhadores com ensino superior incompleto (48,2%) (Tabela 10).

A prevalência de tempo prolongado de tela foi de 45,1% entre trabalhadores sem filhos, com redução das estimativas conforme o aumento do número de filhos, chegando a 19,5% entre aqueles com quatro ou mais filhos. Entre os trabalhadores com acesso a plano de saúde, a prevalência foi de 37,1%, frente a 29,4% entre aqueles sem acesso. Segundo a região geográfica, a maior estimativa foi observada no Sudeste (Figura 9). Em relação ao porte da empresa, as prevalências foram de 31,9% (IC95%: 28,1-36,0) entre trabalhadores de empresas de menor porte e de 34,4% (IC95%: 32,3-36,7) entre aqueles de empresas de maior porte.

Tabela 10. Prevalência (IC95%) de **tempo prolongado de tela** em trabalhadores(as) da indústria, segundo características demográficas. SESI, 2025.

Variável demográfica	Categoria	% (IC95%)
Sexo biológico	Masculino	**29,3** (27,6-31,1)
	Feminino	**40,5** (36,8-44,3)
Faixa etária (anos)	<30	**48,4** (45,7-51,2)
	30-39	**31,7** (28,3-35,4)
	40-59	**24,6** (21,0-28,7)
	≥60	**14,1** (11,4-17,4)
Situação conjugal	Solteiro(a)	**42,2** (39,1-45,4)
	Casado(a) ou vivendo com parceiro(a)	**28,7** (26,2-31,3)
	Viúvo(a), desquitado(a) ou divorciado(a)	**31,7** (25,7-38,4)
Escolaridade	Ensino fundamental incompleto	**16,7** (13,7-20,0)
	Ensino fundamental completo	**24,3** (21,5-27,3)
	Ensino médio ou técnico completo	**30,8** (28,6-33,1)
	Ensino superior incompleto	**48,2** (43,2-53,3)
	Ensino superior completo	**38,7** (34,1-43,4)
Número de filhos	Nenhum	**45,1** (42,1-48,2)
	1 filho(a)	**29,7** (26,2-33,5)
	2 a 3 filhos(as)	**25,2** (21,6-29,1)
	4 ou mais filhos(as)	**19,5** (16,8-22,4)
Acesso a plano de saúde	Não	**29,4** (27,5-31,3)
	Sim	**37,1** (34,3-40,1)
Tempo de trabalho na empresa	Menos de 1 ano	**35,0** (32,4-37,8)
	Entre 1 e 5 anos	**34,3** (31,3-37,4)
	Entre 5 e 10 anos	**33,6** (27,5-40,2)
	Mais de 10 anos	**31,4** (26,6-36,6)

Fonte: próprio autor.

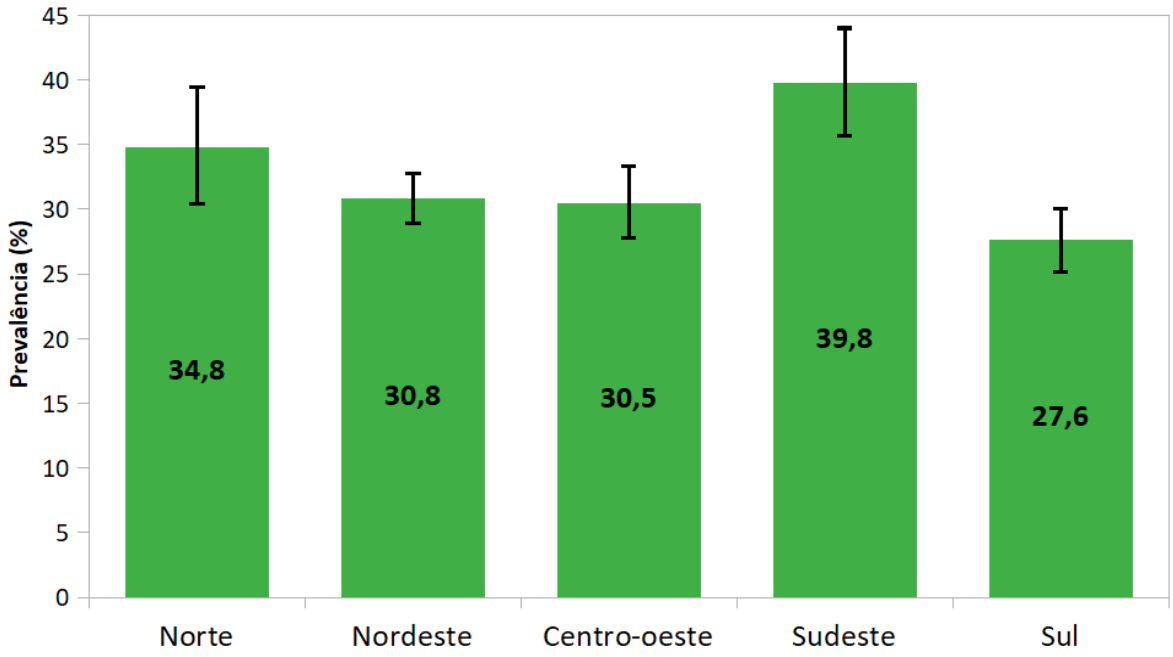


Figura 9. Prevalência de **tempo prolongado de tela** em trabalhadores(as) da indústria, segundo região geográfica. As colunas representam as estimativas de prevalência e as barras de erro indicam os intervalos de confiança de 95% (IC95%). SESI, 2025.

Fonte: próprio autor.

Bem-estar psicológico

[Inserir uma página com ilustração adequada a essa dimensão]

Elevado nível de estresse

> Considerou-se elevado nível de estresse quando o(a) trabalhador(a) referiu que estava “quase sempre estressado, enfrentando problemas com frequência” ou “sempre estressado, com dificuldade para enfrentar a vida diária”.

A exposição a elevado nível de estresse é fator de risco para transtornos mentais comuns, suicídio e outros agravos à saúde, inclusive distúrbios cardiovasculares[32-34]. A prevalência de elevado nível de estresse foi de 20,3% (IC95%: 18,7-22,0), sendo de 26,2% entre as mulheres e 16,2% entre os homens. Segundo a faixa etária, as estimativas variaram de 21,0% entre trabalhadores com menos de 30 anos a 14,0% entre aqueles com 60 anos ou mais. Em relação à escolaridade, as maiores prevalências foram observadas entre trabalhadores com ensino superior incompleto (26,3%) e superior completo (23,2%) (Tabela 11).

Entre as regiões geográficas, as menores estimativas foram observadas no Norte e Nordeste (aproximadamente 17%) e a maior no Centro-Oeste (22,3%) (Figura 10). Segundo o porte da empresa, a prevalência foi de 20,9% (IC95%: 17,8-24,4) entre trabalhadores vinculados a empresas de menor porte e de 20,1% (IC95%: 18,3-22,0) entre aqueles vinculados a empresas de maior porte.

Tabela 11. Prevalência (IC95%) de **elevado nível de estresse** em trabalhadores(as) da indústria, segundo características demográficas. SESI, 2025.

Variável demográfica	Categoria	% (IC95%)
Sexo biológico	Masculino	**16,2** (14,4-18,2)
	Feminino	**26,2** (23,4-29,3)
Faixa etária (anos)	<30	**21,0** (19,5-22,7)
	30-39	**20,5** (17,5-23,8)
	40-59	**19,8** (16,7-23,3)
	≥60	**14,0** (10,9-17,7)
Situação conjugal	Solteiro(a)	**21,0** (18,4-23,9)
	Casado(a) ou vivendo com parceiro(a)	**19,5** (17,5-21,7)
	Viúvo(a), desquitado(a) ou divorciado(a)	**24,8** (19,7-30,7)
Escolaridade	Ensino fundamental incompleto	**15,2** (12,9-17,8)
	Ensino fundamental completo	**15,4** (13,0-18,2)
	Ensino médio ou técnico completo	**18,1** (15,6-20,9)
	Ensino superior incompleto	**26,3** (22,0-31,2)
	Ensino superior completo	**23,2** (19,8-27,1)
Número de filhos	Nenhum	**19,6** (17,4-22,0)
	1 filho(a)	**21,2** (17,8-25,1)

	2 a 3 filhos(as) 4 ou mais filhos(as)	**20,5** (17,6-23,6) **19,2** (15,3-23,8)
Acesso a plano de saúde	Não Sim	**18,2** (16,8-19,7) **21,8** (19,3-24,5)
Tempo de trabalho na empresa	Menos de 1 ano Entre 1 e 5 anos Entre 5 e 10 anos Mais de 10 anos	**16,3** (14,8-17,9) **22,6** (19,8-25,6) **17,7** (15,0-20,9) **22,4** (18,1-27,3)

Fonte: próprio autor.

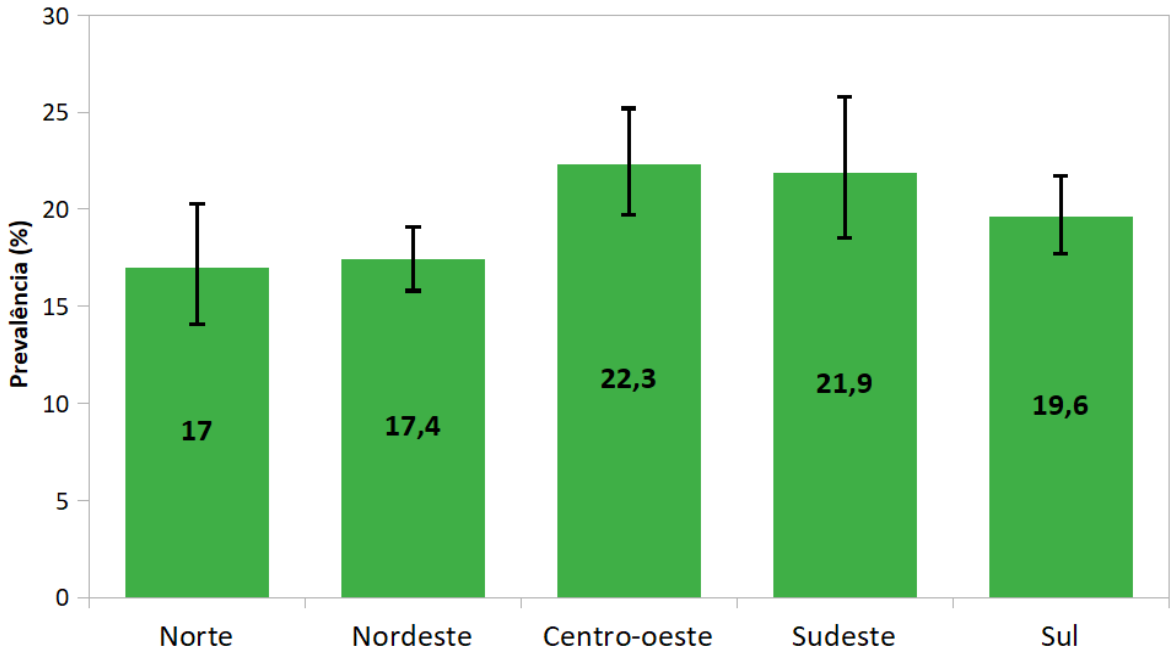


Figura 10. Prevalência de **elevado nível de estresse** em trabalhadores(as) da indústria, segundo região geográfica. As colunas representam as estimativas de prevalência e as barras de erro indicam os intervalos de confiança de 95% (IC95%). SESI, 2025.

Fonte: próprio autor.

Pensamentos negativos e pessimistas persistentes

> Considerou-se caso de pensamentos negativos e pessimistas persistentes quando o(a) trabalhador(a) referiu que “na maior parte das vezes” ou “sempre” pensam de forma negativa ou pessimista em relação ao futuro.

Pensamentos negativos e pessimistas persistentes podem estar associados à ocorrência de depressão e ansiedade e à maior manifestação de sintomas entre pessoas com esses transtornos[35].

A prevalência de trabalhadores(as) que referiram pensamentos negativos e pessimistas persistentes foi de 7,5% (IC95%: 6,4-8,7), sendo de 9,0% entre as mulheres e de 6,4% entre os homens. Segundo a faixa etária, a maior estimativa foi observada entre trabalhadores com menos de 30 anos (9,5%) e a menor entre aqueles com 60 anos ou mais (5,3%). Em relação à situação conjugal, as prevalências foram de 8,6% entre solteiros, 6,5% entre casados ou que viviam com parceiro(a) e 12,0% entre viúvos, desquitados ou divorciados (Tabela 12).

As prevalências de trabalhadores(as) expostos(as) a pensamentos negativos e pessimistas segundo região geográfica estão apresentadas na Figura 11. Em relação ao porte da empresa, a prevalência foi de 9,1% (IC95%: 6,3-12,9) entre trabalhadores vinculados a empresas de menor porte e de 7,0% (IC95%: 6,0-8,1) entre aqueles vinculados a empresas de maior porte.

Tabela 12. Prevalência (IC95%) de **pensamentos negativos e pessimistas persistentes em** trabalhadores(as) da indústria, segundo características demográficas. SESI, 2025.

Variável demográfica	Categoria	% (IC95%)
Sexo biológico	Masculino	**6,4** (5,8–7,0)
	Feminino	**9,0** (6,8–12,0)
Faixa etária (anos)	<30	**9,5** (8,5–10,5)
	30-39	**5,7** (4,8-6,9)
	40-59	**7,7** (5,1-11,3)
	≥60	**5,3** (3,7-7,6)
Situação conjugal	Solteiro(a)	**8,6** (7,6-9,6)
	Casado(a) ou vivendo com parceiro(a)	**6,5** (4,9-8,5)
	Viúvo(a), desquitado(a) ou divorciado(a)	**12,0** (7,6-18,6)
Escolaridade	Ensino fundamental incompleto	**7,6** (6,4-9,1)
	Ensino fundamental completo	**7,5** (6,4-8,8)
	Ensino médio ou técnico completo	**7,7** (5,8-10,0)
	Ensino superior incompleto	**7,8** (6,5-9,5)
	Ensino superior completo	**6,9** (4,5-10,4)
Número de filhos	Nenhum	**7,9** (7,0-8,9)
	1 filho(a)	**7,5** (5,2-10,9)
	2 a 3 filhos(as)	**6,9** (4,8-9,8)
	4 ou mais filhos(as)	**7,3** (5,9-8,9)
Acesso a plano de saúde	Não	**7,2** (6,5-8,0)
	Sim	**7,7** (6,0-9,8)
Tempo de trabalho na empresa	Menos de 1 ano	**7,6** (6,6-8,7)
	Entre 1 e 5 anos	**7,6** (5,9-9,6)
	Entre 5 e 10 anos	**6,5** (4,8-8,8)
	Mais de 10 anos	**7,7** (4,6-12,7)

Fonte: próprio autor.

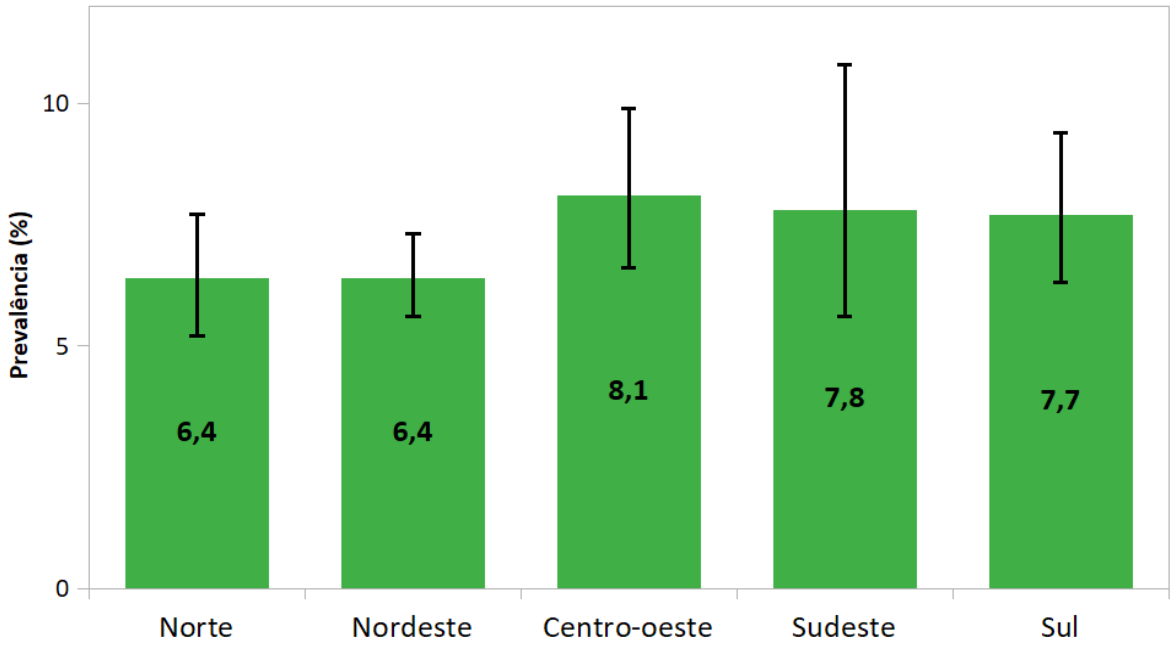


Figura 11. Prevalência de **pensamentos negativos e pessimistas persistentes** em trabalhadores(as) da indústria, segundo região geográfica. As colunas representam as estimativas de prevalência e as barras de erro indicam os intervalos de confiança de 95% (IC95%). SESI, 2025.

Fonte: próprio autor.

Relacionamentos interpessoais de baixa qualidade

> Considerou-se caso de relacionamentos interpessoais de baixa qualidade quando o(a) trabalhador(a) classificou como "regular" ou "ruim" a qualidade dos relacionamentos que mantém com outras pessoas (amigos, colegas de trabalho e chefes).

Relações interpessoais são consideradas fundamentais para a saúde mental, havendo evidências de que relacionamentos interpessoais conflituosos estão diretamente associados a sofrimento psíquico[36]. Sintomas depressivos e de ansiedade também tendem a se exacerbar em contextos nos quais os relacionamentos interpessoais não são saudáveis[36].

A prevalência de relacionamentos interpessoais de baixa qualidade em trabalhadores(as) da indústria foi de 12,4% (IC95%: 11,0-13,8). Segundo a faixa etária, observou-se redução das estimativas com o aumento da idade, variando de 13,5% entre trabalhadores com menos de 30 anos a 8,5% entre aqueles com 60 anos ou mais. Em relação à escolaridade, as prevalências variaram de 14,7% entre trabalhadores com ensino superior incompleto a 10,1% entre aqueles com ensino fundamental incompleto, sem um padrão crescente ou decrescente entre as categorias (Tabela 13).

Entre as regiões geográficas, as prevalências estimadas variaram de 12,1% a 13,7% (Figura 12). Quanto ao porte da empresa, a prevalência foi de 14,8% (IC95%: 11,7-18,4) entre trabalhadores vinculados a micro e pequenas empresas e de 11,7% (IC95%: 10,2-13,3) entre aqueles vinculados a empresas de médio e grande porte.

Tabela 13. Prevalência (IC95%) de **relacionamentos interpessoais de baixa qualidade** em trabalhadores(as) da indústria, segundo características demográficas. SESI, 2025.

Variável demográfica	Categoria	% (IC95%)
Sexo biológico	Masculino	**11,5** (10,1-13,0)
	Feminino	**13,7** (11,2-16,7)
Faixa etária (anos)	<30	**13,5** (12,1-15,0)
	30-39	**12,6** (10,3-15,4)
	40-59	**11,4** (8,7-14,7)
	≥60	**8,5** (6,0-12,0)
Situação conjugal	Solteiro(a)	**13,3** (11,3-15,7)
	Casado(a) ou vivendo com parceiro(a)	**11,7** (9,9-13,8)
	Viúvo(a), desquitado(a) ou divorciado(a)	**13,5** (10,7-16,9)
Escolaridade	Ensino fundamental incompleto	**10,1** (8,7-11,7)
	Ensino fundamental completo	**14,6** (12,3-17,1)
	Ensino médio ou técnico completo	**12,9** (10,9-15,2)
	Ensino superior incompleto	**14,7** (10,7-19,8)
	Ensino superior completo	**10,2** (7,8-11,5)
Número de filhos	Nenhum	**13,0** (11,5-14,5)
	1 filho(a)	**12,8** (10,9-14,7)
	2 a 3 filhos(as)	**12,2** (10,7-13,7)
	4 ou mais filhos(as)	**10,2** (7,5-13,7)
Acesso a plano de saúde	Não	**12,5** (11,3-13,7)
	Sim	**12,3** (10,2-14,8)
Tempo de trabalho na empresa	Menos de 1 ano	**9,8** (8,7-11,1)
	Entre 1 e 5 anos	**14,2** (11,8-16,8)
	Entre 5 e 10 anos	**10,7** (8,6-13,3)
	Mais de 10 anos	**13,1** (9,4-18,0)

Fonte: próprio autor.

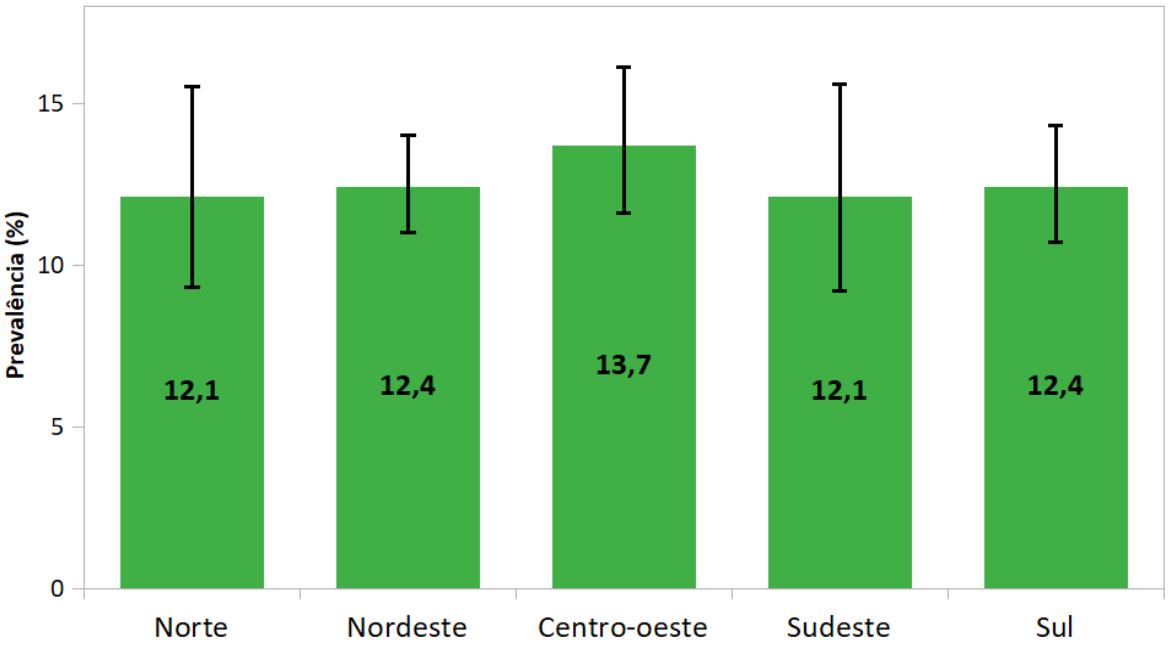


Figura 12. Prevalência de **relacionamentos interpessoais de baixa qualidade** em trabalhadores(as) da indústria, segundo região geográfica. As colunas representam as estimativas de prevalência e as barras de erro indicam os intervalos de confiança de 95% (IC95%). SESI, 2025.

Fonte: próprio autor.

Percepção negativa da qualidade do sono

> Considerou-se percepção negativa da qualidade do sono quando o(a) trabalhador(a) referiu que “raramente” ou “nunca” dorme bem.

A percepção negativa da qualidade do sono é um indicador de saúde que tem forte associação com diversos marcadores inflamatórios, especialmente entre pessoas mais velhas[37]. Má qualidade do sono está associado a percepção de saúde negativa, menos energia e pior funcionamento cognitivo. Há mais de uma década foi estabelecida a possível ligação entre sono de má qualidade e ideação suicida[38].

Nessa amostra, a proporção de trabalhadores(as) que referiu percepção negativa da qualidade do sono foi de 16,5% (IC95%: 15,0-18,1), sendo de 14,5% entre os homens e de 19,4% entre as mulheres. Observou-se redução das estimativas com o aumento da faixa etária, variando de 20,0% entre trabalhadores com menos de 30 anos a 12,3% entre aqueles com 60 anos ou mais. Em relação ao tempo de trabalho na empresa, as prevalências variaram de 18,5% entre trabalhadores com menos de um ano de vínculo a 13,2% entre aqueles com mais de dez anos (Tabela 14).

As estimativas segundo região geográfica estão apresentadas na Figura 13. Segundo o porte da empresa, a prevalência foi de 17,7% (IC95%: 14,6-21,3) entre trabalhadores vinculados a empresas de menor porte e de 16,2% (IC95%: 14,5-18,0) entre aqueles vinculados a empresas de maior porte.

Tabela 14. Prevalência (IC95%) de **percepção negativa da qualidade do sono** em trabalhadores(as) da indústria, segundo características demográficas. SESI, 2025.

Variável demográfica	Categoria	% (IC95%)
Sexo biológico	Masculino	**14,5** (13,4-15,8)
	Feminino	**19,4** (16,2-23,0)
Faixa etária (anos)	<30	**20,0** (17,4-22,9)
	30-39	**16,0** (13,3-19,1)
	40-59	**14,3** (11,9-17,0)
	≥60	**12,3** (9,5-15,9)
Situação conjugal	Solteiro(a)	**17,3** (15,5-19,3)
	Casado(a) ou vivendo com parceiro(a)	**16,1** (13,9-18,6)
	Viúvo(a), desquitado(a) ou divorciado(a)	**14,9** (11,6-18,9)
Escolaridade	Ensino fundamental incompleto	**23,0** (18,2-28,6)
	Ensino fundamental completo	**15,4** (13,4-17,5)
	Ensino médio ou técnico completo	**15,4** (13,8-17,2)
	Ensino superior incompleto	**16,3** (14,0-18,8)
	Ensino superior completo	**16,5** (12,4-21,7)
Número de filhos	Nenhum	**17,0** (14,6-19,6)
	1 filho(a)	**16,9** (14,0-20,4)
	2 a 3 filhos(as)	**15,7** (13,0-18,7)
	4 ou mais filhos(as)	**15,9** (13,5-18,6)
Acesso a plano de saúde	Não	**18,0** (16,0-20,3)
	Sim	**15,4** (13,3-17,8)
Tempo de trabalho na empresa	Menos de 1 ano	**18,5** (16,3-21,0)
	Entre 1 e 5 anos	**15,9** (13,8-18,3)
	Entre 5 e 10 anos	**19,1** (13,1-27,0)
	Mais de 10 anos	**13,2** (10,5-16,5)

Fonte: próprio autor.

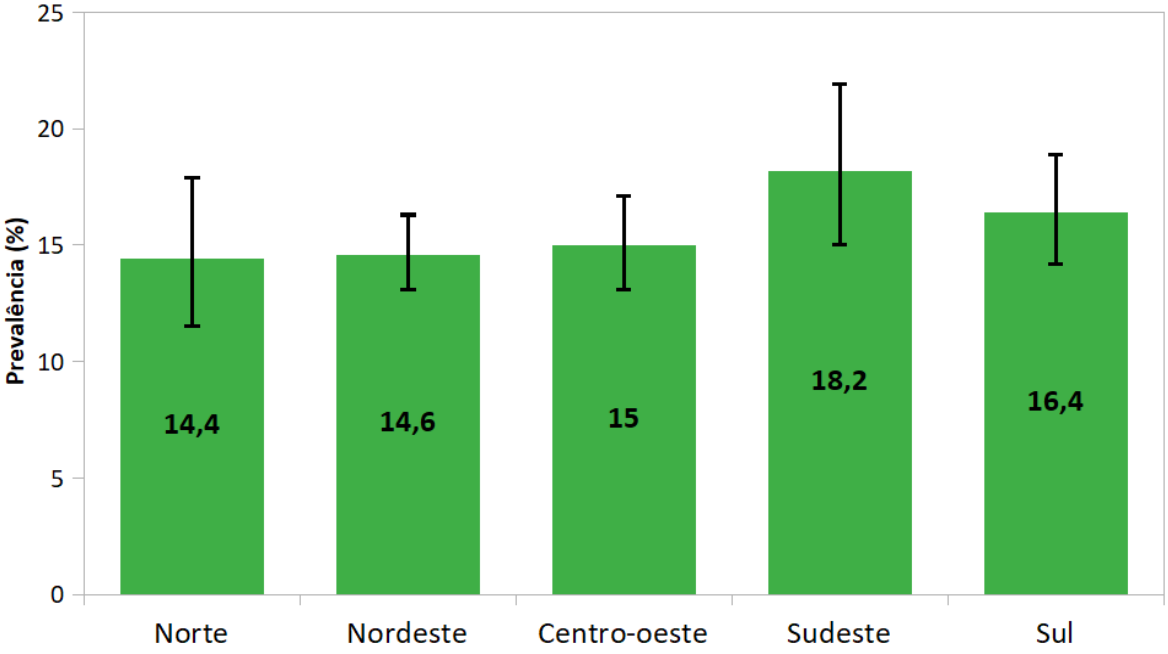


Figura 13. Prevalência de **percepção negativa da qualidade do sono** em trabalhadores(as) da indústria, segundo região geográfica. As colunas representam as estimativas de prevalência e as barras de erro indicam os intervalos de confiança de 95% (IC95%). SESI, 2025.

Fonte: próprio autor.

Dificuldade de relaxar e usufruir do lazer

> Considerou-se dificuldade de relaxar e usufruir do lazer quando o(a) trabalhador(a) referiu que “nunca” ou “raramente” são capazes de relaxar e aproveitar o seu tempo de lazer.

Existe um crescente corpo de conhecimentos que esclarece os mecanismos pelos quais o envolvimento em atividades de lazer pode derivar inúmeros benefícios para saúde[39]. O engajamento em atividades voluntárias e prazerosas, realizadas no tempo livre do trabalho, como hobbies, artes, voluntariado, participação em grupos comunitários e esportes, dentre outras, podem reduzir a mortalidade precoce, sintomas depressivos e melhorar a qualidade de vida[40-42].

A prevalência de dificuldade de relaxar e usufruir do lazer foi de 18,7% (IC95%: 17,0-20,5), sendo de 23,4% entre as mulheres e de 15,4% entre os homens. Segundo a faixa etária, a maior estimativa foi observada entre trabalhadores com menos de 30 anos (20,9%). Em relação à escolaridade, a prevalência variou de 25,7% entre trabalhadores com ensino fundamental incompleto a 15,6% entre aqueles com ensino superior completo. Observou-se, ainda, aumento das estimativas conforme o número de filhos, de 17,5% entre trabalhadores sem filhos para 21,8%

entre aqueles com quatro ou mais filhos. Trabalhadores sem acesso a plano de saúde apresentaram prevalência de 21,2%, frente a 16,8% entre aqueles com acesso. Em relação ao tempo de trabalho na empresa, observou-se redução das estimativas conforme o tempo de vínculo, de 21,3% entre trabalhadores com menos de um ano para 15,4% entre aqueles com mais de dez anos (Tabela 15).

As estimativas segundo região geográfica estão apresentadas na Figura 14. Segundo o porte da empresa, a prevalência foi de 20,2% (IC95%: 16,4-24,6) entre trabalhadores vinculados a empresas de menor porte e de 18,2% (IC95%: 16,4-20,2) entre aqueles vinculados a empresas de maior porte.

Tabela 15. Prevalência (IC95%) de **dificuldade de relaxar e usufruir do lazer** em trabalhadores(as) da indústria, segundo características demográficas. SESI, 2025.

Variável demográfica	Categoria	% (IC95%)
Sexo biológico	Masculino	**15,4** (14,3-16,7)
	Feminino	**23,4** (19,8-27,4)
Faixa etária (anos)	<30	**20,9** (18,3-23,8)
	30-39	**19,0** (15,6-22,8)
	40-59	**16,6** (14,2-19,4)
	≥60	**14,9** (11,1-19,8)
Situação conjugal	Solteiro(a)	**18,0** (15,7-20,6)
	Casado(a) ou vivendo com parceiro(a)	**19,0** (16,6-21,7)
	Viúvo(a), desquitado(a) ou divorciado(a)	**19,1** (15,4-23,6)
Escolaridade	Ensino fundamental incompleto	**25,7** (20,9-31,1)
	Ensino fundamental completo	**18,3** (16,0-21,0)
	Ensino médio ou técnico completo	**16,6** (15,0-18,4)
	Ensino superior incompleto	**16,9** (14,7-19,4)
	Ensino superior completo	**20,4** (15,6-26,3)
Número de filhos	Nenhum	**17,5** (14,8-20,5)
	1 filho(a)	**19,6** (16,1-23,7)
	2 a 3 filhos(as)	**18,9** (16,2-22,0)
	4 ou mais filhos(as)	**21,8** (18,1-26,1)
Acesso a plano de saúde	Não	**21,2** (18,8-23,8)
	Sim	**16,8** (14,6-19,4)
Tempo de trabalho na empresa	Menos de 1 ano	**21,3** (18,3-24,7)
	Entre 1 e 5 anos	**18,7** (16,2-21,6)
	Entre 5 e 10 anos	**17,7** (13,0-23,8)
	Mais de 10 anos	**15,4** (11,7-20,0)

Fonte: próprio autor.

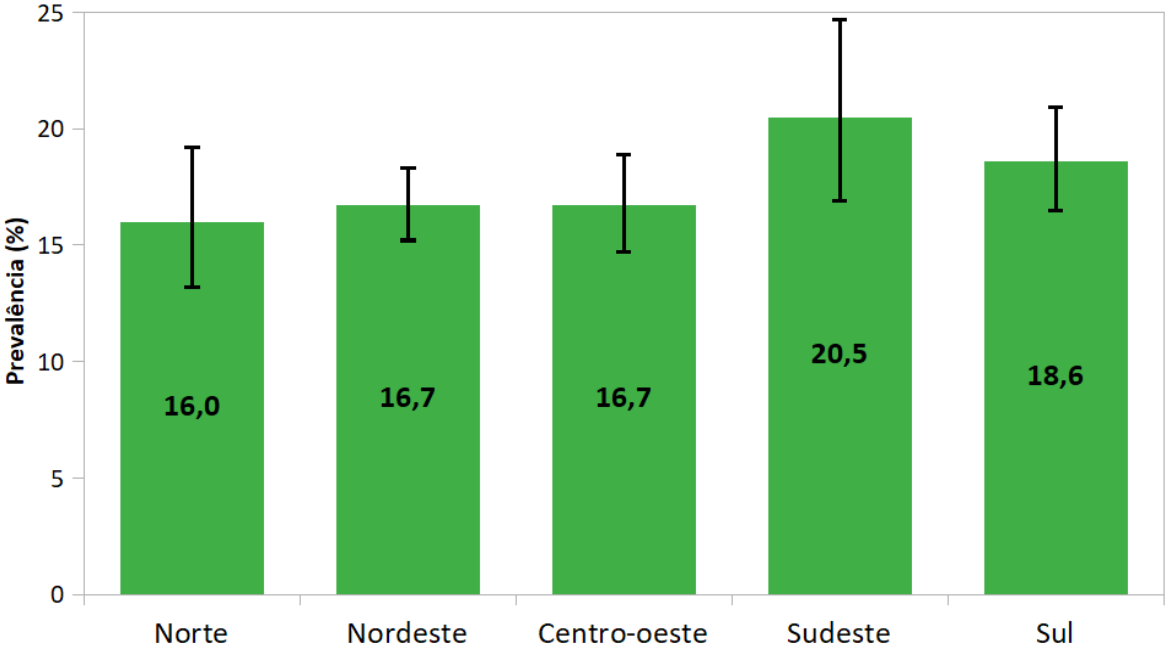


Figura 14. Prevalência de **dificuldade de relaxar e usufruir do lazer** em trabalhadores(as) da indústria, segundo região geográfica. As colunas representam as estimativas de prevalência e as barras de erro indicam os intervalos de confiança de 95% (IC95%). SESI, 2025.

Fonte: próprio autor.

Insatisfação com as condições de trabalho

> Considerou-se insatisfação com as condições de trabalho quando o(a) trabalhador(a) referiu estar "insatisfeito" ou "muito insatisfeito" com as condições laborais oferecidas pela empresa na qual ele(a) trabalha.

Condições de trabalho são influenciadas por diversos fatores (jornada de trabalho, tempo de descanso, flexibilidade no horário de trabalho, remuneração, condições ambientais, fatores ergonômicos e riscos, dentre outros). Empresas que oferecem programas de qualidade de vida visando melhorar as condições de trabalho conseguem construir um ciclo virtuoso de satisfação, envolvendo funcionários e clientes que pode ter repercussão no desempenho da organização[43]. Funcionários satisfeitos com as condições de trabalho também tendem a apresentar maior nível e percepção de bem-estar[44]. Por outro lado, más condições de trabalho afetam negativamente a qualidade da alimentação, do sono e das relações interpessoais, afetando a saúde física e mental dos trabalhadores[45].

Aproximadamente 8,1% (IC95%: 7,4-8,8) dos(as) trabalhadores(as) referiram insatisfação com as condições de trabalho. As estimativas variaram de 7,9% entre as mulheres a 8,2% entre os

homens. Em relação à escolaridade, as maiores prevalências foram observadas entre trabalhadores com ensino superior incompleto (9,6%), enquanto a menor foi observada entre aqueles com ensino fundamental completo (5,2%) (Tabela 16).

As estimativas segundo região geográfica estão apresentadas na Figura 15, com menores valores observados nas regiões Norte e Nordeste. Segundo o porte da empresa, a prevalência foi de 7,6% (IC95%: 6,5-9,0) entre trabalhadores vinculados a empresas de menor porte e de 8,2% (IC95%: 7,4-9,1) entre aqueles vinculados a empresas de maior porte.

Tabela 16. Prevalência (IC95%) de **insatisfação com as condições de trabalho** em trabalhadores(as) da indústria, segundo características demográficas. SESI, 2025.

Variável demográfica	Categoria	% (IC95%)
Sexo biológico	Masculino	**8,2** (7,3-9,2)
	Feminino	**7,9** (6,9-9,0)
Faixa etária (anos)	<30	**9,2** (8,2-10,2)
	30-39	**7,5** (6,4-8,7)
	40-59	**7,9** (6,5-9,5)
	≥60	**5,9** (4,3-8,1)
Situação conjugal	Solteiro(a)	**8,1** (7,2-9,2)
	Casado(a) ou vivendo com parceiro(a)	**8,1** (7,1-9,2)
	Viúvo(a), desquitado(a) ou divorciado(a)	**7,5** (5,8-9,6)
Escolaridade	Ensino fundamental incompleto	**6,2** (4,8-7,9)
	Ensino fundamental completo	**5,2** (4,4-6,1)
	Ensino médio ou técnico completo	**7,8** (6,7-9,1)
	Ensino superior incompleto	**9,6** (8,0-11,4)
	Ensino superior completo	**9,3** (7,7-11,1)
Número de filhos	Nenhum	**8,9** (7,8-10,1)
	1 filho(a)	**8,1** (6,8-9,5)
	2 a 3 filhos(as)	**7,2** (5,9-8,8)
	4 ou mais filhos(as)	**7,3** (5,9-8,9)
Acesso a plano de saúde	Não	**7,5** (6,7-8,4)
	Sim	**8,5** (7,5-9,6)
Tempo de trabalho na empresa	Menos de 1 ano	**6,9** (5,9-8,1)
	Entre 1 e 5 anos	**9,1** (7,8-10,5)
	Entre 5 e 10 anos	**7,8** (6,4-9,6)
	Mais de 10 anos	**7,7** (6,4-9,2)

Fonte: próprio autor.

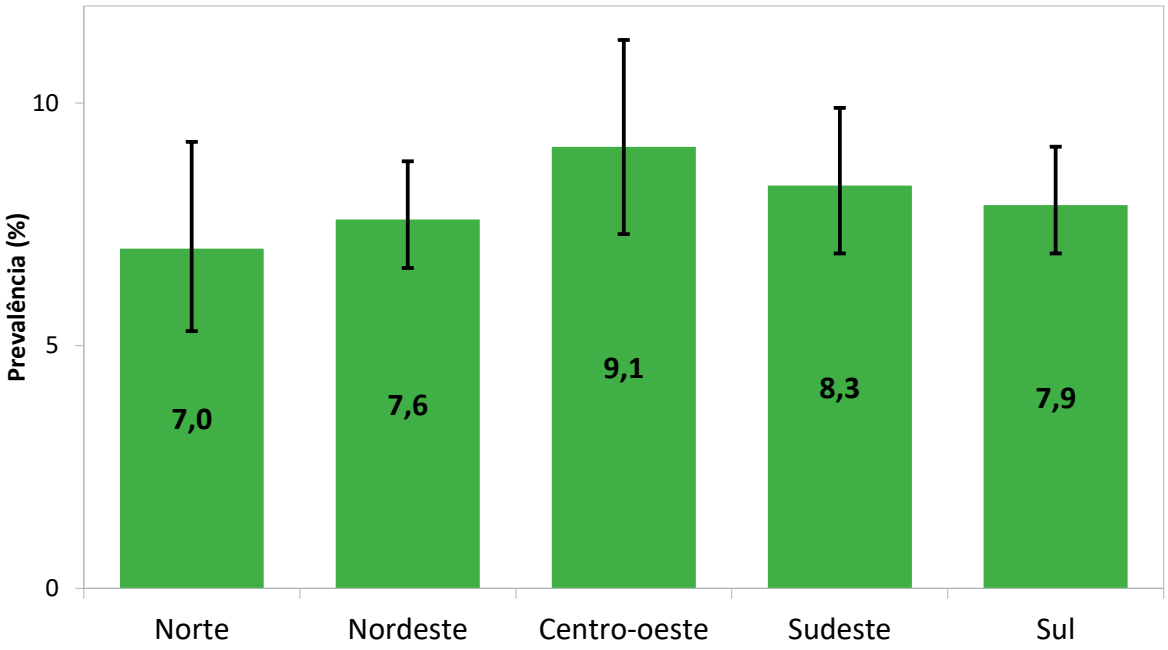


Figura 15. Prevalência de **insatisfação com as condições de trabalho** em trabalhadores(as) da indústria, segundo região geográfica. As colunas representam as estimativas de prevalência e as barras de erro indicam os intervalos de confiança de 95% (IC95%). SESI, 2025.

Fonte: próprio autor.

Morbidade

[Inserir uma página com ilustração adequada a essa dimensão]

Obesidade

Considerou-se obesidade quando o(a) trabalhador(a) apresentou índice de massa corporal (IMC) igual ou superior a 30 kg/m², independentemente do sexo.

A obesidade é uma enfermidade crônica inflamatória de etiologia multifatorial, considerada um problema global de saúde pública. Transtornos mentais, redução da qualidade de vida, diabetes, doenças cardiovasculares, acidentes vasculares cerebrais e alguns tipos de câncer são as principais consequências da obesidade[46-48].

Entre os(as) trabalhadores(as) do setor industrial a prevalência de obesidade foi de 22,7 (IC95%: 21,4-24,1), sendo de 21,5% entre os homens e de 24,5% entre as mulheres. Segundo a faixa etária, a maior estimativa foi observada entre trabalhadores de 40 a 59 anos (25,3%). Em relação ao número de filhos, observou-se aumento progressivo das estimativas, de 20,2% entre trabalhadores sem filhos para 34,1% entre aqueles com quatro ou mais filhos (Tabela 17).

Segundo a região geográfica, a maior estimativa de prevalência de obesidade foi observada na região Sul e as menores nas regiões Norte e Nordeste (Figura 16). Em relação ao porte da empresa, a prevalência foi de 24,2% (IC95%: 21,1-27,6) entre trabalhadores vinculados a micro e pequenas empresas e de 22,3% (IC95%: 20,9-23,7) entre aqueles vinculados a empresas de médio e grande porte.

Tabela 17. Prevalência (IC95%) de **obesidade** em trabalhadores(as) da indústria, segundo características demográficas. SESI, 2025.

Variável demográfica	Categoria	% (IC95%)
Sexo biológico	Masculino	**21,5** (20,2-22,9)
	Feminino	**24,5** (22,0-27,2)
Faixa etária (anos)	<30	**21,1** (18,4-24,1)
	30-39	**22,0** (19,9-24,2)
	40-59	**25,3** (23,2-27,6)
	≥60	**15,7** (12,9-18,9)
Situação conjugal	Solteiro(a)	**19,9** (17,9-22,1)
	Casado(a) ou vivendo com parceiro(a)	**24,4** (22,6-26,2)
	Viúvo(a), desquitado(a) ou divorciado(a)	**24,9** (20,1-30,5)
Escolaridade	Ensino fundamental incompleto	**29,2** (24,8-34,1)
	Ensino fundamental completo	**25,2** (22,1-28,6)
	Ensino médio ou técnico completo	**19,9** (18,6-21,3)
	Ensino superior incompleto	**21,5** (18,7-24,6)

	Ensino superior completo	**24,3** (20,8-28,0)
Número de filhos	Nenhum 1 filho(a) 2 a 3 filhos(as) 4 ou mais filhos(as)	**20,2** (17,8-22,8) **22,9** (20,6-25,3) **24,4** (22,4-26,6) **34,1** (29,7-38,8)
Acesso a plano de saúde	Não Sim	**24,4** (22,3-26,7) **21,5** (19,9-23,1)
Tempo de trabalho na empresa	Menos de 1 ano Entre 1 e 5 anos Entre 5 e 10 anos Mais de 10 anos	**23,0** (20,7-25,4) **23,3** (21,0-25,7) **21,4** (18,3-24,9) **22,0** (19,8-24,5)

Fonte: próprio autor.

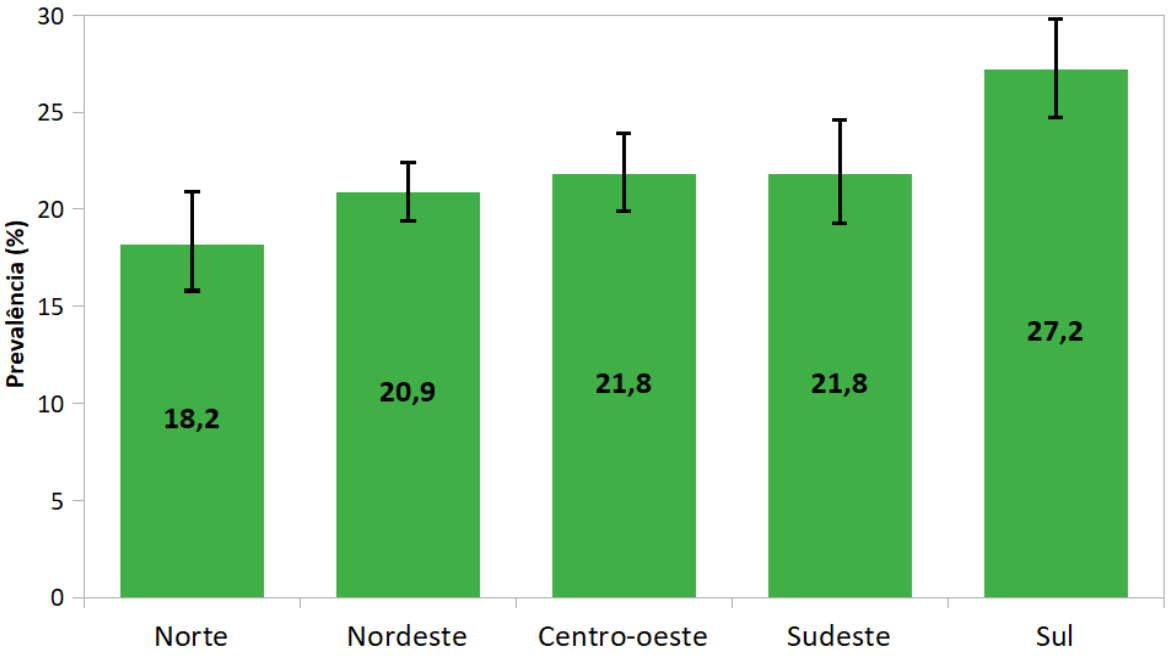


Figura 16. Prevalência (%) de **obesidade** em trabalhadores(as) da indústria, segundo região geográfica. As colunas representam as estimativas de prevalência e as barras de erro indicam os intervalos de confiança de 95% (IC95%). SESI, 2025.

Fonte: próprio autor.

Hipertensão referida

Considerou-se hipertensão arterial referida quando o(a) trabalhador(a) relatou ter recebido diagnóstico de hipertensão por médico ou profissional de saúde.

Hipertensão é uma enfermidade crônica que aumenta o risco de acidente vascular cerebral e de desenvolvimento de outras doenças cardiovasculares[49]. Trabalhadores(as) hipertensos(as)

apresentam maior custo com assistência médico-hospitalar, maior absenteísmo, comprometimento da capacidade de concentração para resolução de tarefas, além de queda na produtividade e na qualidade de vida[50].

A prevalência de hipertensão referida foi de 16,2% (IC95%: 14,8-17,7), sendo de 15,2% entre os homens e de 17,7% entre as mulheres. Como esperado, observou-se aumento das estimativas com a idade, de 7,7% entre trabalhadores com menos de 30 anos para 45,2% entre aqueles com 60 anos ou mais. As estimativas também aumentaram conforme o número de filhos, de 9,5% entre trabalhadores sem filhos para 25,9% entre aqueles com quatro ou mais filhos e, conforme o tempo de trabalho na empresa, de 11,4% entre aqueles com menos de um ano de vínculo para 23,9% entre os que trabalhavam na empresa há mais de dez anos (Tabela 18).

Segundo a região geográfica, a menor estimativa de prevalência de hipertensão referida foi observada na região Norte (Figura 17). Em relação ao porte da empresa, a prevalência foi de 15,8% (IC95%: 12,9-19,2) entre trabalhadores vinculados a empresas de menor porte e de 16,3% (IC95%: 14,8-18,0) entre aqueles vinculados a empresas de maior porte.

Tabela 18. Prevalência (IC95%) de **hipertensão referida** em trabalhadores(as) da indústria**,** segundo características demográficas. SESI, 2025.

Variável demográfica	Categoria	% (IC95%)
Sexo biológico	Masculino	**15,2** (14,2-16,3)
	Feminino	**17,7** (14,8-21,1)
Faixa etária (anos)	<30	**7,7** (5,6-10,6)
	30-39	**11,9** (9,7-14,6)
	40-59	**26,4** (23,8-29,1)
	≥60	**45,2** (40,5-50,1)
Situação conjugal	Solteiro(a)	**9,9** (8,7-11,2)
	Casado(a) ou vivendo com parceiro(a)	**19,6** (17,4-21,9)
	Viúvo(a), desquitado(a) ou divorciado(a)	**26,0** (22,0-30,3)
Escolaridade	Ensino fundamental incompleto	**22,4** (20,0-24,9)
	Ensino fundamental completo	**18,7** (16,4-21,3)
	Ensino médio ou técnico completo	**15,1** (13,0-17,4)
	Ensino superior incompleto	**10,3** (8,8-12,0)
	Ensino superior completo	**18,4** (14,7-22,7)
Número de filhos	Nenhum	**9,5** (7,6-11,8)
	1 filho(a)	**17,6** (14,2-21,5)
	2 a 3 filhos(as)	**22,3** (20,2-24,5)
	4 ou mais filhos(as)	**25,9** (22,8-29,2)
Acesso a plano de saúde	Não	**15,6** (13,8-17,6)

	Sim	**16,7** (14,7-18,8)
Tempo de trabalho na empresa	Menos de 1 ano	**11,4** (10,0-12,9)
	Entre 1 e 5 anos	**15,7** (13,0-18,9)
	Entre 5 e 10 anos	**16,8** (14,1-19,8)
	Mais de 10 anos	**23,9** (21,2-26,8)

Fonte: próprio autor.

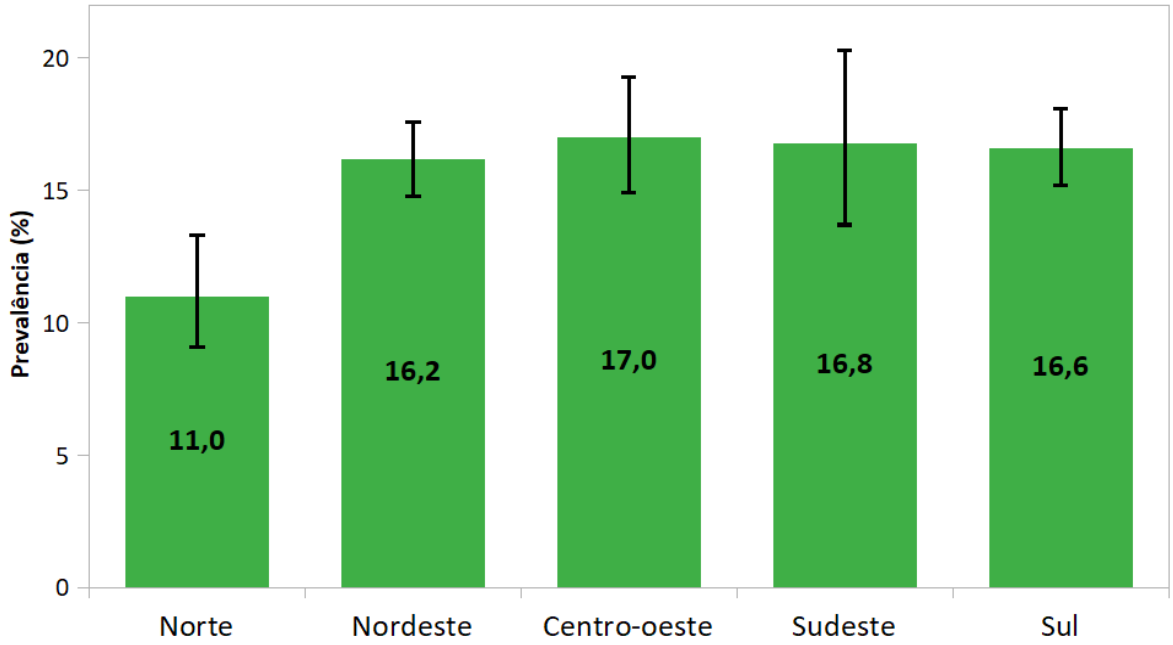


Figura 17. Prevalência de **hipertensão referida** em trabalhadores(as) da indústria, segundo região geográfica. As colunas representam as estimativas de prevalência e as barras de erro indicam os intervalos de confiança de 95% (IC95%). SESI, 2025.

Fonte: próprio autor.

Diabetes referido

Considerou-se diabetes referido quando o(a) trabalhador(a) relatou ter sido informado(a), por médico ou outro profissional de saúde, de que tinha diabetes.

Estima-se que, em todo o mundo, existem aproximadamente 450 milhões de diabéticos, sendo que um milhão de pessoas morrem devido às complicações relacionadas a esta doença[51]. Pessoas obesas, fisicamente inativas e que apresentam hábitos alimentares inadequados apresentam maior risco de serem acometidas por esta doença[52]. Pessoas com diabetes param de trabalhar mais cedo em consequência de incapacidades e limitações impostas pela doença[53], além de apresentarem índices de produtividade mais baixo[54-55]. Há evidências obtidas tanto em países desenvolvidos quanto em desenvolvimento que o diabetes é uma condição crônica com grande

impacto em incapacidade e redução de produtividade, com repercussões econômicas importantes[56-57].

A prevalência de diabetes referido foi de 5,7% (IC95%: 4,7-6,9), sendo de 4,3% entre os homens e de 7,6% entre as mulheres. Observou-se aumento da prevalência com a idade, de 3,5% entre trabalhadores com menos de 30 anos para 22% entre aqueles com 60 anos ou mais. As estimativas também aumentaram conforme o número de filhos, de 5,0% entre trabalhadores sem filhos para 9,8% entre aqueles com quatro ou mais filhos. Segundo a situação conjugal, as prevalências foram de 4,2% entre solteiros, 6,4% entre casados ou que viviam com parceiro(a) e 9,2% entre viúvos, desquitados ou divorciados (Tabela 19).

As estimativas segundo região geográfica estão apresentadas na Figura 18. Em relação ao porte da empresa, a prevalência de diabetes referido foi de 6,6% (IC95%: 4,1-10,6) entre trabalhadores vinculados a empresas de menor porte e de 5,4% (IC95%: 4,4-6,5) entre aqueles vinculados a empresas de maior porte.

Tabela 19. Prevalência (IC95%) de **diabetes referido** em trabalhadores(as) da indústria, segundo características demográficas. SESI, 2025.

Variável demográfica	Categoria	% (IC95%)
Sexo biológico	Masculino	**4,3** (3,9-4,7)
	Feminino	**7,6** (5,4-10,7)
Faixa etária (anos)	<30	**3,5** (1,8-7,0)
	30-39	**4,2** (2,5-7,0)
	40-59	**8,1** (7,1-9,2)
	≥60	**22,0** (17,3-27,5)
Situação conjugal	Solteiro(a)	**4,2** (2,6-6,6)
	Casado(a) ou vivendo com parceiro(a)	**6,4** (5,1-7,9)
	Viúvo(a), desquitado(a) ou divorciado(a)	**9,2** (7,2-11,5)
Escolaridade	Ensino fundamental incompleto	**8,8** (7,3-10,5)
	Ensino fundamental completo	**5,8** (4,9-7,0)
	Ensino médio ou técnico completo	**4,6** (3,9-5,4)
	Ensino superior incompleto	**3,5** (2,8-4,3)
	Ensino superior completo	**7,3** (4,3-12,1)
Número de filhos	Nenhum	**5,0** (2,9-8,4)
	1 filho(a)	**4,4** (3,7-5,2)
	2 a 3 filhos(as)	**7,1** (6,0-8,5)
	4 ou mais filhos(as)	**9,8** (7,9-12,1)
Acesso a plano de saúde	Não	**6,1** (4,2-9,0)
	Sim	**5,3** (4,6-6,1)

Tempo de trabalho na empresa	Menos de 1 ano	**5,6** (3,4-9,1)
	Entre 1 e 5 anos	**5,1** (3,6-7,3)
	Entre 5 e 10 anos	**6,2** (4,5-8,4)
	Mais de 10 anos	**6,6** (5,6-7,7)

Fonte: próprio autor.

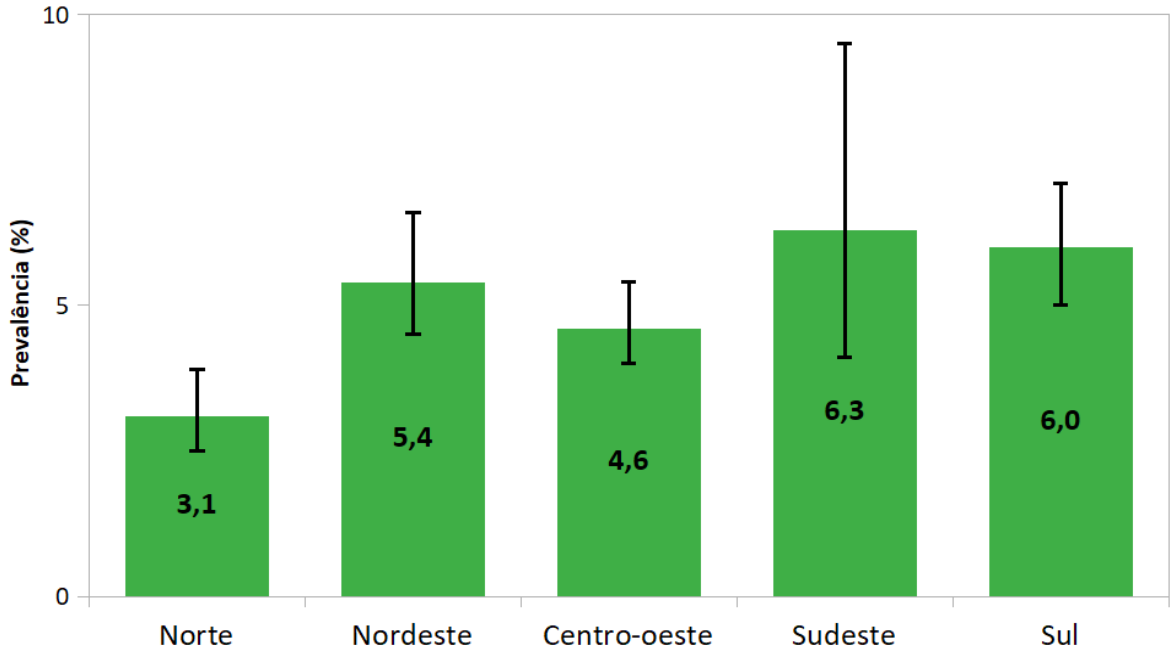


Figura 18. Prevalência de **diabetes referido** em trabalhadores(as) da indústria, segundo região geográfica. As colunas representam as estimativas de prevalência e as barras de erro indicam os intervalos de confiança de 95% (IC95%). SESI, 2025.

Fonte: próprio autor.

Colesterol alto

Considerou-se colesterol alto referido quando o(a) trabalhador(a) relatou ter sido informado(a), por médico ou outro profissional de saúde, de que apresentava colesterol alto.

Parte do colesterol é sintetizado no fígado e a outra parte é absorvida dos alimentos consumidos, notadamente aqueles de origem animal (ovos, carnes gordurosas e queijos, dentre outros). Colesterol alto aumenta o risco de doença coronária e acidente vascular cerebral, que são duas das principais causas de morte no mundo[58]. Pessoas com colesterol alto se ausentam mais do trabalho tanto na comparação com aqueles que apresentam colesterol normal quanto em relação àqueles que tem o colesterol sob controle[59]. Além de tratamento medicamentoso, mudanças no estilo de

vida também podem auxiliar no controle dos níveis de colesterol, com destaque para prática de atividades físicas, reeducação alimentar e controle do peso corporal[60-62].

A prevalência de colesterol alto referido foi de 17,1% (IC95%: 15,7-18,6), sendo de 14,7% entre os homens e de 20,5% entre as mulheres. Observou-se aumento das estimativas com a idade, de 11,2% entre trabalhadores com menos de 30 anos para 31,3% entre aqueles com 60 anos ou mais. Segundo a situação conjugal, as prevalências foram de 11,9% entre solteiros, 19,7% entre casados ou que viviam com parceiro(a) e 25,8% entre viúvos, desquitados ou divorciados. Em relação ao tempo de trabalho na empresa, observou-se aumento das estimativas conforme o tempo de vínculo, de 12,8% entre trabalhadores com menos de um ano para 24,4% entre aqueles com mais de dez anos (Tabela 20).

As estimativas segundo região geográfica estão apresentadas na Figura 19. Em relação ao porte da empresa, a prevalência de colesterol alto referido foi de 16,7% (IC95%: 13,6-20,2) entre trabalhadores vinculados a empresas de menor porte e de 17,2% (IC95%: 15,6-18,9) entre aqueles vinculados a empresas de maior porte.

Tabela 20. Prevalência (IC95%) de **colesterol alto referido** em trabalhadores(as) da indústria, segundo características demográficas. SESI, 2025.

Variável demográfica	Categoria	% (IC95%)
Sexo biológico	Masculino	**14,7** (13,7-15,9)
	Feminino	**20,5** (17,5-23,8)
Faixa etária (anos)	<30	**11,2** (9,0-14,0)
	30-39	**14,3** (12,0-17,0)
	40-59	**24,2** (21,6-27,0)
	≥60	**31,3** (27,3-35,7)
Situação conjugal	Solteiro(a)	**11,9** (10,5-13,5)
	Casado(a) ou vivendo com parceiro(a)	**19,7** (17,6-22,1)
	Viúvo(a), desquitado(a) ou divorciado(a)	**25,8** (20,8-31,6)
Escolaridade	Ensino fundamental incompleto	**14,0** (12,0-16,2)
	Ensino fundamental completo	**13,6** (11,4-16,1)
	Ensino médio ou técnico completo	**13,6** (12,3-14,9)
	Ensino superior incompleto	**13,9** (11,9-16,1)
	Ensino superior completo	**26,0** (21,8-30,8)
Número de filhos	Nenhum	**15,2** (13,0-17,6)
	1 filho(a)	**16,4** (13,8-19,4)
	2 a 3 filhos(as)	**19,9** (17,2-22,9)
	4 ou mais filhos(as)	**18,1** (15,2-21,4)
Acesso a plano de saúde	Não	**14,1** (12,3-16,1)

	Sim	**19,2** (17,2-21,4)
Tempo de trabalho na empresa	Menos de 1 ano	**12,8** (11,2-14,7)
	Entre 1 e 5 anos	**15,6** (13,2-18,3)
	Entre 5 e 10 anos	**20,1** (15,2-26,0)
	Mais de 10 anos	**24,4** (21,6-27,4)

Fonte: próprio autor.

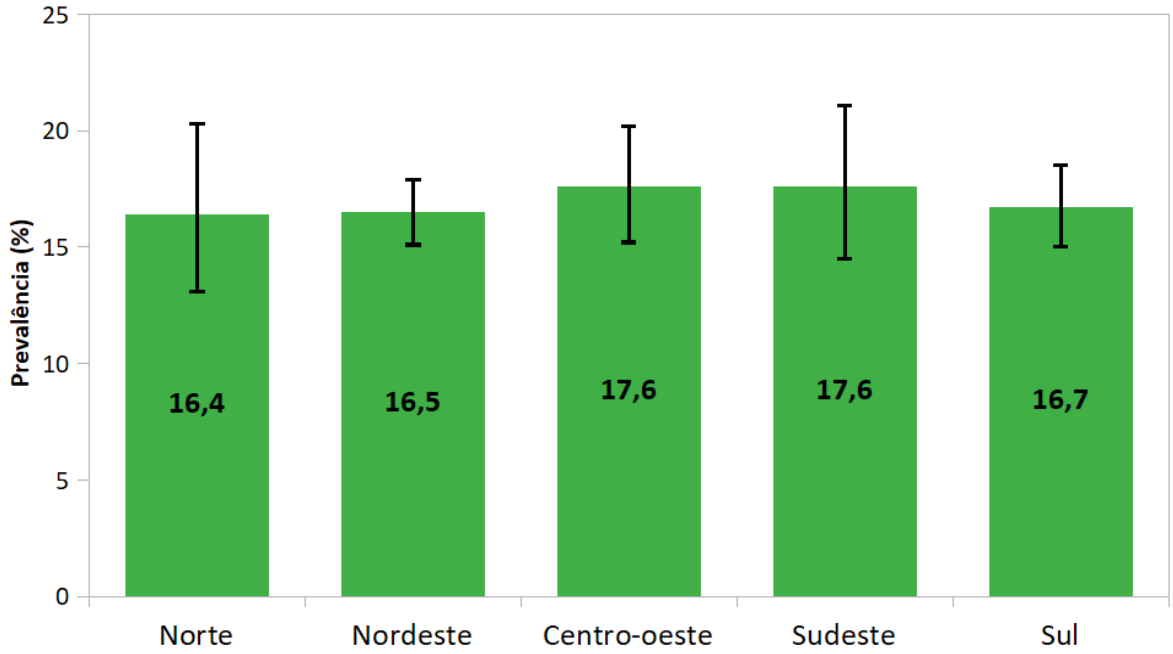


Figura 19. Prevalência de **colesterol alto referido** em trabalhadores(as) da indústria, segundo região geográfica. As colunas representam as estimativas de prevalência e as barras de erro indicam os intervalos de confiança de 95% (IC95%). SESI, 2025.

Fonte: próprio autor.

Acidente vascular cerebral

> Considerou-se AVC referido quando o(a) trabalhador(a) relatou ter sido informado(a), por médico ou outro profissional de saúde, de que teve acidente vascular cerebral (AVC) ou derrame.

O acidente vascular cerebral (AVC) é a segunda principal causa de incapacidade e morte no mundo, com maior carga de adoecimento em países de baixa e média renda, sendo que em 2016 foram registrados aproximadamente 13,7 milhões de novos casos de AVC[63]. Hipertensão, colesterol alto, doenças coronarianas, diabetes, obesidade e anemia falciforme elevam o risco de AVC, principalmente em pessoas com idade mais avançada. Fatores psicossociais como o estresse também são apontados como causas potenciais de AVC, havendo evidências de que pessoas expostas e elevado nível de estresse apresentam chance 22% superior de sofrerem AVC[64]. O AVC é

uma condição que exige elevado custo anual de tratamento, variando de aproximadamente 60 mil dólares nos Estados Unidos a pouco mais de 40 mil na Espanha[65]. Trata-se, portanto, de uma condição que impõe elevado custo social e econômico para as pessoas acometidas e para a sociedade, razão pela qual a prevenção e a redução na incidência deste agravo deve ser uma prioridade. É importante destacar, ainda, que o absenteísmo e o presenteísmo são maiores em trabalhadores que sofreram AVC, independente da presença de comorbidades[66].

A proporção de trabalhadores(as) que referiu AVC ou derrame foi de 1,4% (IC95%: 0,8-2,4), sendo de 0,9% entre os homens e de 2,0% entre as mulheres. Segundo a faixa etária, as estimativas variaram de 1,7% entre trabalhadores com menos de 30 anos a 2,9% entre aqueles com 60 anos ou mais. Em relação ao número de filhos, as prevalências variaram de 1,0% entre trabalhadores com um único filho a 1,8% entre aqueles com quatro ou mais filhos (Tabela 21).

As estimativas segundo região geográfica estão apresentadas na Figura 20. Em relação ao porte da empresa, a prevalência de AVC referido foi de 2,6% (IC95%: 0,8-8,5) entre trabalhadores vinculados a empresas de menor porte e de 1,0% (IC95%: 0,7-1,3) entre aqueles vinculados a empresas de maior porte.

Tabela 21. Prevalência (IC95%) de **AVC referido** em trabalhadores(as) da indústria, segundo características demográficas. SESI, 2025.

Variável demográfica	Categoria	% (IC95%)
Sexo biológico	Masculino	**0,9** (0,7-1,1)
	Feminino	**2,0** (0,8-5,1)
Faixa etária (anos)	<30	**1,7** (0,4-7,1)
	30-39	**1,1** (0,6-2,1)
	40-59	**1,2** (1,0-1,5)
	≥60	**2,9** (2,0-4,0)
Situação conjugal	Solteiro(a)	**0,7** (0,5-0,9)
	Casado(a) ou vivendo com parceiro(a)	**1,8** (0,9-3,7)
	Viúvo(a), desquitado(a) ou divorciado(a)	**1,4** (0,8-2,4)
Escolaridade	Ensino fundamental incompleto	**1,3** (1,0-1,8)
	Ensino fundamental completo	**1,2** (0,9-1,5)
	Ensino médio ou técnico completo	**1,0** (0,6-1,8)
	Ensino superior incompleto	**0,6** (0,4-1,1)
	Ensino superior completo	**2,3** (0,7-7,2)
Número de filhos	Nenhum	**1,5** (0,4-5,2)
	1 filho(a)	**1,0** (0,6-1,6)
	2 a 3 filhos(as)	**1,4** (0,8-2,4)

	4 ou mais filhos(as)	**1,8** (1,2-2,6)
Acesso a plano de saúde	Não Sim	**1,7** (0,6-4,6) **1,1** (0,7-1,7)
Tempo de trabalho na empresa	Menos de 1 ano Entre 1 e 5 anos Entre 5 e 10 anos Mais de 10 anos	**0,7** (0,5-0,9) **1,8** (0,6-4,7) **1,9** (0,8-4,6) **1,0** (0,7-1,3)

Fonte: próprio autor.

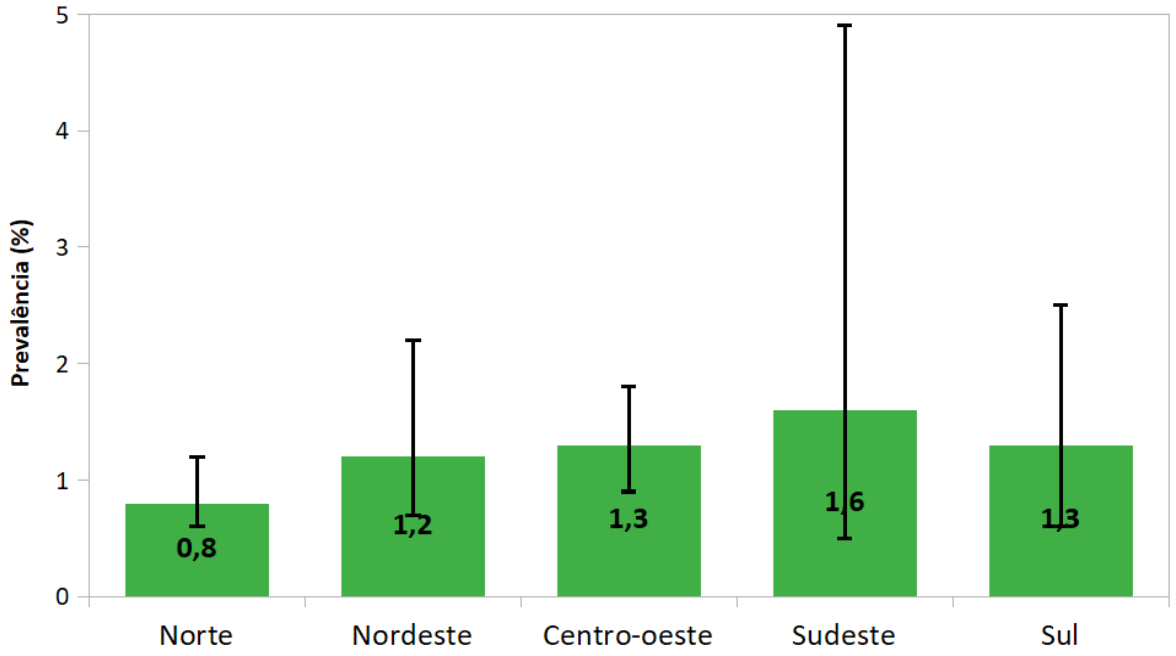


Figura 20. Prevalência de **AVC referido** em trabalhadores(as) da indústria,segundo região geográfica. As colunas representam as estimativas de prevalência e as barras de erro indicam os intervalos de confiança de 95% (IC95%). SESI, 2025.

Fonte: próprio autor.

Artrite ou reumatismo

Considerou-se artrite ou reumatismo referido quando o(a) trabalhador(a) relatou ter sido informado(a), por médico ou outro profissional de saúde, de que tinha artrite ou reumatismo.

Artrite ou reumatismo referido são indicadores frequentemente analisados em inquéritos de saúde[67-68]. Artrite é a inflamação de qualquer articulação no corpo, enquanto a artrite reumatoide é uma doença crônica autoimune sistêmica, caracterizada pela inflamação frequente das articulações que pode provocar deformidades[69-70]. De modo geral, além de prevalência relativamente elevada na população economicamente ativa (~8%), a artrite é uma condição

associada a elevado percentual de incapacidade, principalmente na população de menor escolaridade. Estima-se que aproximadamente 17% dos adultos que referem “artrite/reumatismo” apresentam grau de limitação intenso ou muito intenso[71]. Somente para ilustrar, essa prevalência de limitação é bem superior aos 7% observado entre adultos com diabetes ou aos 5% observado entre hipertensos. Além disso, há também evidências de que o aumento na prevalência dessa enfermidade está ocorrendo de modo desigual na população, com maior velocidade entre os adultos menos escolarizados[72], como os trabalhadores de chão de fábrica.

A proporção de trabalhadores(as) que referiu artrite/reumatismo foi de 4,3% (IC95%: 3,6-5,0), sendo de 2,3% entre os homens e de 7,2% entre as mulheres. Segundo a faixa etária, a prevalência foi de 2,5% entre trabalhadores com menos de 30 anos, variando entre 4,3% e 8,6% nas demais faixas etárias. Em relação ao tempo de trabalho na empresa, observou-se aumento das estimativas conforme o tempo de vínculo, de 2,2% entre trabalhadores com menos de um ano para 8,9% entre aqueles com mais de dez anos. A prevalência foi de 3,7% entre trabalhadores sem acesso a plano de saúde e de 4,8% entre aqueles com acesso (Tabela 22).

As estimativas segundo região geográfica estão apresentadas na Figura 21. Em relação ao porte da empresa, a prevalência de artrite/reumatismo referido foi de 5,2% (IC95%: 3,6-6,8) entre trabalhadores vinculados a empresas de menor porte e de 4,0% (IC95%: 3,2-4,9) entre aqueles vinculados a empresas de maior porte.

Tabela 22. Prevalência (IC95%) de **artrite/reumatismo referido** em trabalhadores(as) da indústria, segundo características demográficas. SESI, 2025.

Variável demográfica	Categoria	% (IC95%)
Sexo biológico	Masculino	**2,3** (1,7-2,9)
	Feminino	**7,2** (5,4-9,1)
Faixa etária (anos)	<30	**2,5** (1,7-3,4)
	30-39	**4,3** (2,8-5,8)
	40-59	**5,6** (4,2-7,0)
	≥60	**8,6** (5,9-11,4)
Situação conjugal	Solteiro(a)	**3,8** (2,6-5,0)
	Casado(a) ou vivendo com parceiro(a)	**4,5** (3,5-5,5)
	Viúvo(a), desquitado(a) ou divorciado(a)	**5,8** (3,3-8,3)
Escolaridade	Ensino fundamental incompleto	**4,7** (2,8-6,6)
	Ensino fundamental completo	**3,4** (1,8-5,0)
	Ensino médio ou técnico completo	**3,2** (2,3-4,0)
	Ensino superior incompleto	**2,3** (0,9-3,8)

	Ensino superior completo	**7,4** (5,0-9,8)
Número de filhos	Nenhum 1 filho(a) 2 a 3 filhos(as) 4 ou mais filhos(as)	**4,6** (3,3-5,8) **3,2** (2,0-4,5) **4,8** (3,3-6,2) **5,2** (3,3-7,1)
Acesso a plano de saúde	Não Sim	**3,7** (2,8-4,5) **4,8** (3,6-5,9)
Tempo de trabalho na empresa	Menos de 1 ano Entre 1 e 5 anos Entre 5 e 10 anos Mais de 10 anos	**2,2** (1,3-3,2) **3,5** (2,4-4,6) **4,8** (2,3-7,2) **8,9** (6,6-11,2)

Fonte: próprio autor.

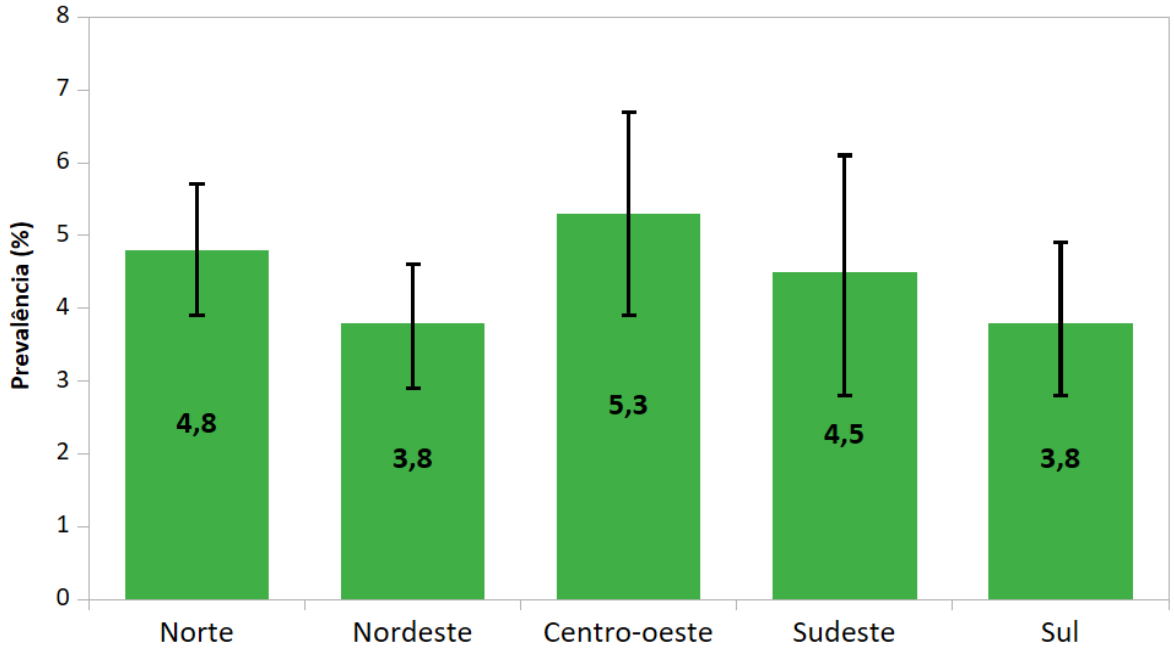


Figura 21. Prevalência de **artrite/reumatismo referido** em trabalhadores(as) da indústria, segundo região geográfica. As colunas representam as estimativas de prevalência e as barras de erro indicam os intervalos de confiança de 95% (IC95%). SESI, 2025.

Fonte: próprio autor.

Asma ou bronquite asmática

> Considerou-se asma ou bronquite asmática referida quando o(a) trabalhador(a) relatou ter sido informado(a), por médico ou outro profissional de saúde, de que tinha asma ou bronquite asmática..

Cerca de 20 milhões de brasileiros têm asma, uma doença crônica que impacta negativamente o cotidiano e a saúde das pessoas[73-74]. A asma pode também ter um maior risco de exacerbação na

presença de outras condições crônicas como os transtornos de ansiedade e doenças como a obesidade, a artrite reumatoide e história de acidente vascular cerebral[75]. A asma é uma condição que implica maior utilização de serviços médico-hospitalares (consultas e internações) e também maior custo com medicamentos prescritos para controle das crises[76].

A prevalência de asma referida foi de 8,5% (IC95%: 7,3-9,7), sendo de 6,8% entre os homens e de 10,8% entre as mulheres. Segundo a faixa etária, a maior estimativa foi observada entre trabalhadores com menos de 30 anos (12,2%), enquanto entre aqueles com 60 anos ou mais foi de 5,2%. Em relação à escolaridade, as estimativas variaram de 4,5% entre trabalhadores com ensino fundamental incompleto a 9,8% entre aqueles com ensino superior completo. A prevalência foi de 7,6% entre trabalhadores sem acesso a plano de saúde e de 9,1% entre aqueles com acesso (Tabela 23).

Segundo a região geográfica, a maior estimativa foi observada na região Sudeste e as menores nas regiões Norte e Nordeste (Figura 22). Em relação ao porte da empresa, a prevalência de asma ou bronquite asmática referida foi de 8,9% (IC95%: 6,2-12,6) entre trabalhadores vinculados a empresas de menor porte e de 8,3% (IC95%: 7,2-9,6) entre aqueles vinculados a empresas de maior porte.

Tabela 23. Prevalência (IC95%) de **asma ou bronquite asmática referida** em trabalhadores(as) da indústria, segundo características demográficas. SESI, 2025.

Variável demográfica	Categoria	% (IC95%)
Sexo biológico	Masculino	**6,8** (6,1-7,7)
	Feminino	**10,8** (8,5-13,7)
Faixa etária (anos)	<30	**12,2** (9,3-15,9)
	30-39	**7,1** (6,0-8,3)
	40-59	**6,9** (5,5-8,5)
	≥60	**5,2** (3,8-7,0)
Situação conjugal	Solteiro(a)	**8,8** (6,9-11,0)
	Casado(a) ou vivendo com parceiro(a)	**8,2** (6,8-9,8)
	Viúvo(a), desquitado(a) ou divorciado(a)	**10,0** (5,8-16,7)
Escolaridade	Ensino fundamental incompleto	**4,5** (3,7-5,4)
	Ensino fundamental completo	**6,5** (5,1-8,2)
	Ensino médio ou técnico completo	**7,7** (6,5-9,1)
	Ensino superior incompleto	**11,5** (7,8-16,5)
	Ensino superior completo	**9,8** (7,3-13,1)
Número de filhos	Nenhum	**10,9** (8,6-13,9)
	1 filho(a)	**6,5** (5,6-7,6)

	2 a 3 filhos(as) 4 ou mais filhos(as)	**7,2** (5,8-8,9) **7,4** (5,0-10,8)
Acesso a plano de saúde	Não Sim	**7,6** (6,0-9,7) **9,1** (7,6-10,7)
Tempo de trabalho na empresa	Menos de 1 ano Entre 1 e 5 anos Entre 5 e 10 anos Mais de 10 anos	**8,0** (7,1-9,0) **10,0** (7,7-12,9) **7,0** (5,3-9,3) **6,7** (5,7-7,8)

Fonte: próprio autor.

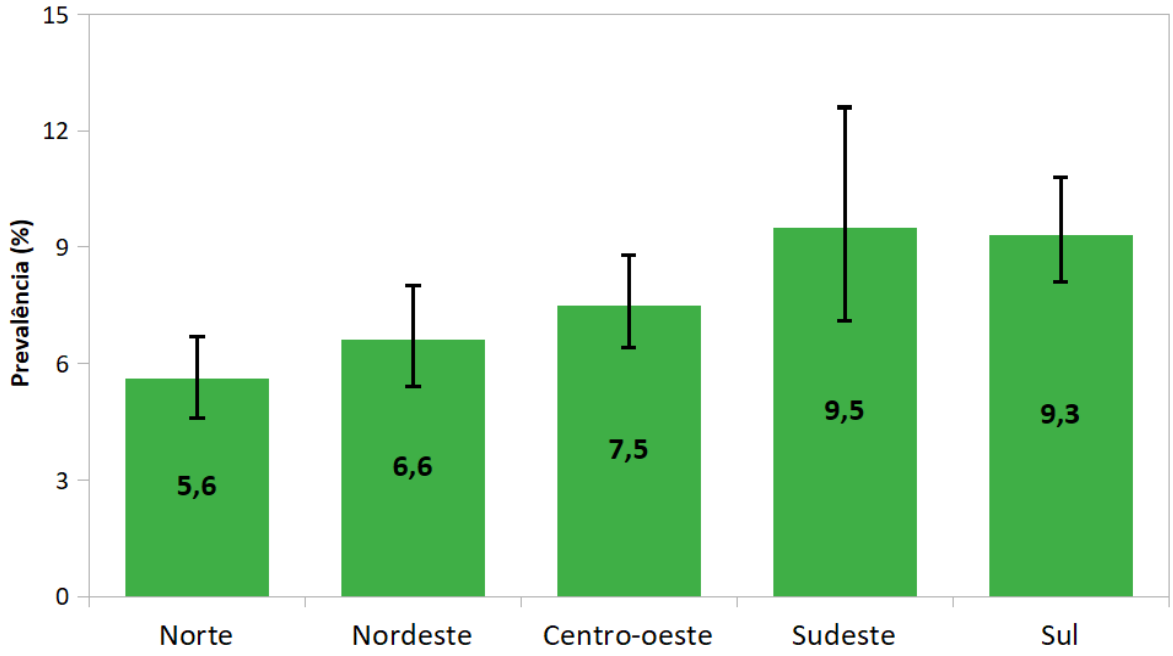


Figura 22. Prevalência de **asma ou bronquite asmática referida** em trabalhadores(as) da indústria, segundo região geográfica. As colunas representam as estimativas de prevalência e as barras de erro indicam os intervalos de confiança de 95% (IC95%). SESI, 2025.

Fonte: próprio autor.

Depressão

Considerou-se depressão referida quando o(a) trabalhador(a) relatou ter sido informado(a), por médico ou profissional de saúde mental, de que tinha depressão.

A prevalência de depressão varia consideravelmente entre os países, mas é considerada um transtorno relativamente comum, estimando-se que uma em cada cinco pessoas experimentará um episódio depressivo importante ao longo da vida[77]. Trata-se de uma condição cuja incidência tem tendência crescente de elevação em todo o mundo, sendo que o número de casos incidentes

aumentou aproximadamente 50% entre 1990 e 2017[78]. Nas duas últimas décadas foram realizados estudos abrangentes e bem delineados que indicam que depressão afeta a produtividade, impactando negativamente a economia das empresas e dos países[79-80]. No Brasil, aproximadamente 30% dos trabalhadores brasileiros relataram faltar ao trabalho ao menos um dia devido a sintomas depressivos[71]. Além disso, a previdência social registrou, em 2016, o afastamento de 75,3 mil trabalhadores por causa de quadros depressivos, resultando em 206 bilhões de reais em perdas[81].

A prevalência de depressão referida foi de 11,8% (IC95%: 10,4-13,3), sendo de 5,9% entre os homens e de 20,4% entre as mulheres. As estimativas apresentaram pouca variação segundo a faixa etária. Em relação à escolaridade, observou-se aumento das prevalências, de 6,9% entre trabalhadores com ensino fundamental incompleto para 16,6% entre aqueles com ensino superior completo. Segundo a situação conjugal, a maior estimativa foi observada entre trabalhadores viúvos, desquitados ou divorciados (15,4%) (Tabela 24).

Segundo a região geográfica, as menores estimativas foram observadas nas regiões Norte e Nordeste e a maior na região Sul (Figura 23). Em relação ao porte da empresa, a prevalência de depressão referida foi de 13,0% (IC95%: 10,2-16,5) entre trabalhadores vinculados a empresas de menor porte e de 11,4% (IC95%: 9,8-13,2) entre aqueles vinculados a empresas de maior porte.

Tabela 24. Prevalência (IC95%) de **depressão referida** em trabalhadores(as) da indústria, segundo características demográficas. SESI, 2025.

Variável demográfica	Categoria	% (IC95%)
Sexo biológico	Masculino	**5,9** (5,4-6,4)
	Feminino	**20,4** (17,2-23,9)
Faixa etária (anos)	<30	**14,2** (11,2-17,7)
	30-39	**11,6** (9,0-14,9)
	40-59	**10,0** (8,8-11,4)
	≥60	**7,8** (6,0-10,1)
Situação conjugal	Solteiro(a)	**13,0** (10,5-16,0)
	Casado(a) ou vivendo com parceiro(a)	**10,7** (9,0-12,7)
	Viúvo(a), desquitado(a) ou divorciado(a)	**15,4** (12,8-18,3)
Escolaridade	Ensino fundamental incompleto	**6,9** (6,0-8,0)
	Ensino fundamental completo	**8,4** (7,0-10,1)
	Ensino médio ou técnico completo	**8,8** (7,9-9,8)
	Ensino superior incompleto	**15,1** (11,3-19,9)
	Ensino superior completo	**16,6** (12,7-21,5)

Número de filhos	Nenhum 1 filho(a) 2 a 3 filhos(as) 4 ou mais filhos(as)	**13,6** (10,8-17,0) **11,8** (9,3-14,9) **9,6** (8,4-11,1) **10,0** (7,7-12,8)
Acesso a plano de saúde	Não Sim	**11,5** (9,4-14,1) **11,9** (10,1-14,0)
Tempo de trabalho na empresa	Menos de 1 ano Entre 1 e 5 anos Entre 5 e 10 anos Mais de 10 anos	**12,4** (9,9-15,4) **13,1** (10,5-16,2) **9,0** (7,1-11,4) **9,7** (8,3-11,3)

Fonte: próprio autor.

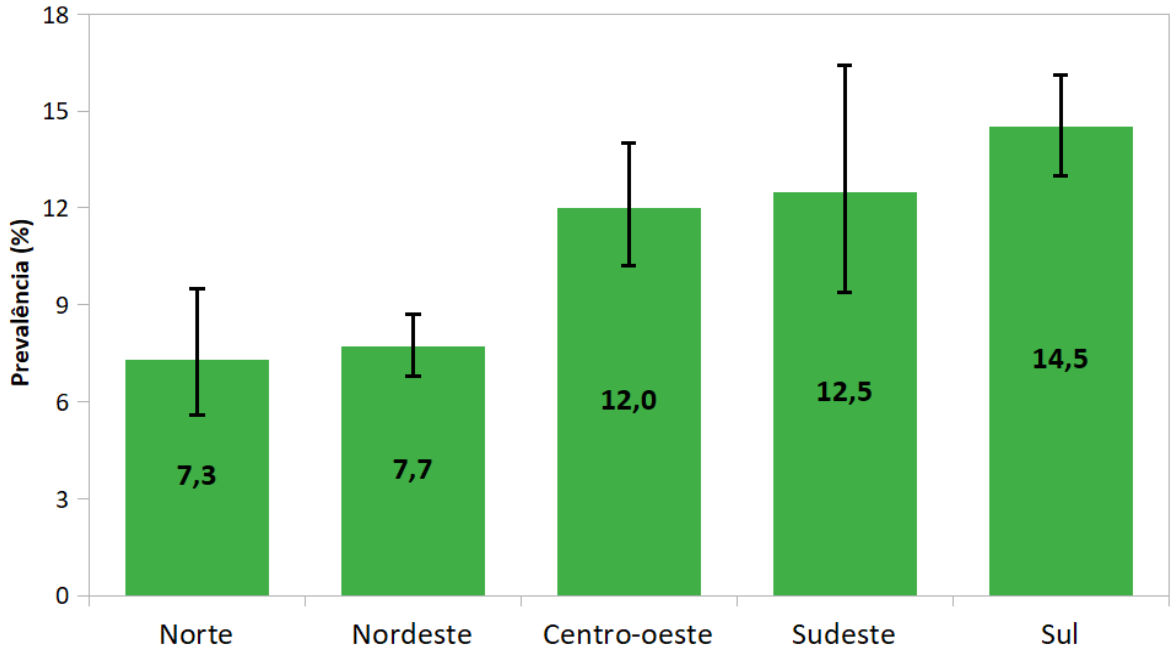


Figura 23. Prevalência de **depressão referida** em trabalhadores(as) da indústria, segundo região geográfica. As colunas representam as estimativas de prevalência e as barras de erro indicam os intervalos de confiança de 95% (IC95%). SESI, 2025.

Fonte: próprio autor.

Câncer

> Considerou-se câncer referido quando o(a) trabalhador(a) relatou ter sido informado(a), por médico ou outro profissional de saúde, de diagnóstico atual ou passado de algum tipo de câncer.

Em 2020, foram registrados aproximadamente 19,3 milhões de novos casos de câncer em todo o mundo e 10 milhões de mortes no mesmo ano por este tipo de doença. No Brasil, há uma tendência de diminuição na taxa de incidência de neoplasias, mas essa ainda é alta[82]. Os cânceres

provocam incapacidade e morte prematura e representam importante fonte de perda de produtividade para a sociedade e para as organizações. Um estudo realizado com dados de 31 países europeus, do ano de 2018, revelou uma redução de produtividade calculada em aproximadamente 105 bilhões de euros[83]. Além disso, o câncer é uma enfermidade que está associada à incapacidade e, usualmente, acentuada redução da qualidade de vida[84].

A prevalência de câncer referido, considerando diagnóstico atual ou passado, foi de 1,6% (IC95%: 1,0-2,6), sendo de 0,7% entre os homens e de 2,9% entre as mulheres. Observou-se aumento das estimativas com a idade, de 1,7% entre trabalhadores com menos de 30 anos para 4,8% entre aqueles com 60 anos ou mais (Tabela 25).

As estimativas segundo região geográfica estão apresentadas na Figura 24. Em relação ao porte da empresa, a prevalência de câncer referido foi de 2,9% (IC95%: 0,9-8,4) entre trabalhadores vinculados a empresas de menor porte e de 1,2% (IC95%: 0,9-1,6) entre aqueles vinculados a empresas de maior porte.

Tabela 25. Prevalência (IC95%) de **câncer referido** em trabalhadores(as) da indústria, segundo características demográficas. SESI, 2025.

Variável demográfica	Categoria	% (IC95%)
Sexo biológico	Masculino	**0,7** (0,6-0,9)
	Feminino	**2,9** (1,5-5,5)
Faixa etária (anos)	<30	**1,7** (0,4-7,2)
	30-39	**1,0** (0,5-2,0)
	40-59	**1,9** (1,4-2,5)
	≥60	**4,8** (3,6-6,5)
Situação conjugal	Solteiro(a)	**0,8** (0,5-1,3)
	Casado(a) ou vivendo com parceiro(a)	**2,0** (1,1-3,9)
	Viúvo(a), desquitado(a) ou divorciado(a)	**2,1** (1,5-2,9)
Escolaridade	Ensino fundamental incompleto	**1,3** (1,0-1,8)
	Ensino fundamental completo	**0,8** (0,5-1,1)
	Ensino médio ou técnico completo	**1,2** (0,7-2,1)
	Ensino superior incompleto	**0,9** (0,6-1,3)
	Ensino superior completo	**2,9** (1,1-7,3)
Número de filhos	Nenhum	**1,8** (0,6-5,1)
	1 filho(a)	**1,5** (0,9-2,3)
	2 a 3 filhos(as)	**1,4** (0,9-2,4)
	4 ou mais filhos(as)	**1,2** (0,8-1,9)
Acesso a plano de saúde	Não	**1,6** (0,6-4,6)
	Sim	**1,5** (1,1-2,2)

Tempo de trabalho na empresa	Menos de 1 ano	**0,6** (0,4-0,8)
	Entre 1 e 5 anos	**1,9** (0,8-4,7)
	Entre 5 e 10 anos	**2,5** (1,2-5,2)
	Mais de 10 anos	**1,6** (1,3-2,0)

Fonte: próprio autor.

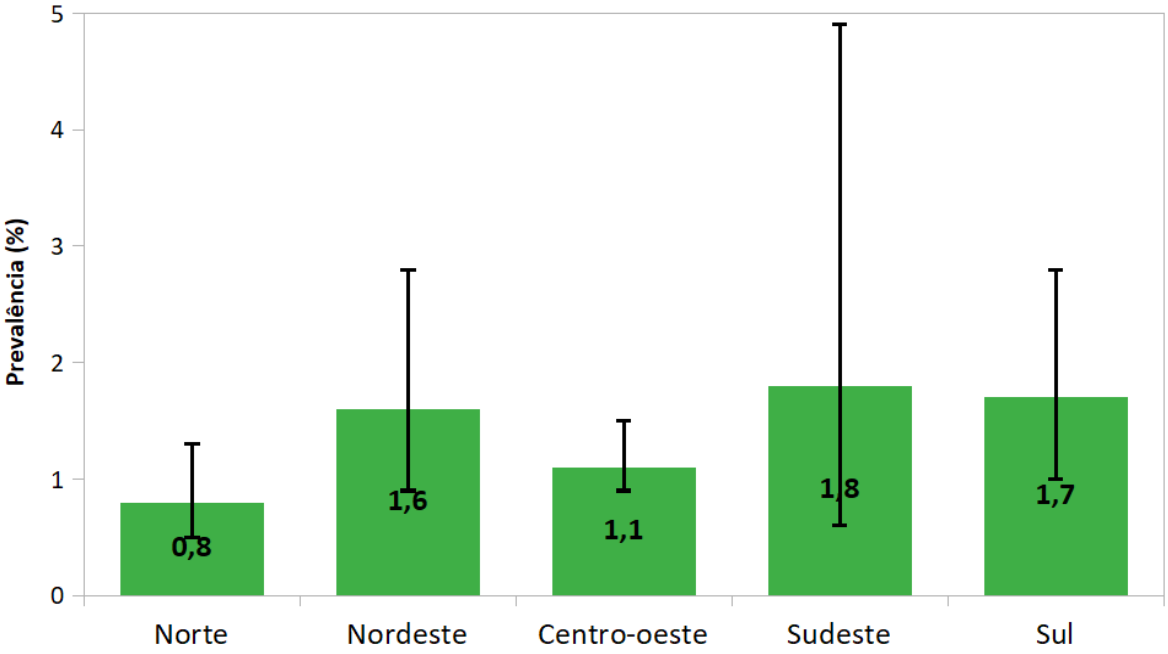


Figura 24. Prevalência de **câncer referido** em trabalhadores(as) da indústria, segundo região geográfica. As colunas representam as estimativas de prevalência e as barras de erro indicam os intervalos de confiança de 95% (IC95%). SESI, 2025.

Fonte: próprio autor.

Problema crônico de coluna

> Considerou-se problema crônico de coluna quando o(a) trabalhador(a) referiu apresentar algum problema crônico de coluna, como dor crônica nas costas ou no pescoço, lombalgia, dor ciática, problemas nas vértebras ou discos intervertebrais.

Os problemas crônicos de coluna incluem variadas afecções, a exemplo das cervicalgias, dores torácicas e ciáticas, transtornos dos discos intervertebrais, espondiloses, radiculopatias e dores lombares[85]. Estima-se que um em cada cinco adultos tem problemas crônicos de coluna e que tais condições permanecem por longo período de vida das pessoas acometidas, gerando incapacidade e redução da qualidade de vida[86]. São condições que mesmo quando de baixa gravidade tem potencial para impactar negativamente a funcionalidade e o bem-estar, aumentando a utilização

de serviços médico-hospitalares[87]. A prevalência de problema crônico de coluna no Brasil é estimada em 18,5%, sendo maior entre mulheres do que entre homens e as pessoas acometidas tendem a apresentar pior percepção de saúde e maior severidade das limitações em idades mais avançadas[88].

Nesse estudo, a prevalência de problema crônico de coluna referido foi de 19,3% (IC95%: 17,9-20,9), sendo de 17,3% entre os homens e de 22,2% entre as mulheres. Observou-se aumento das estimativas com a idade, de 15,3% entre trabalhadores com menos de 30 anos para 31,1% entre aqueles com 60 anos ou mais. As estimativas também aumentaram conforme o número de filhos, de 16,0% entre trabalhadores sem filhos para 26,3% entre aqueles com quatro ou mais filhos. Em relação ao tempo de trabalho na empresa, a prevalência variou de 16,0% entre trabalhadores com menos de um ano de vínculo a 27,4% entre aqueles com mais de dez anos (Tabela 26).

Segundo a região geográfica, a menor estimativa foi observada na região Norte (Figura 25). Em relação ao porte da empresa, a prevalência foi de 19,9% (IC95%: 17,0-23,2) entre trabalhadores vinculados a empresas de menor porte e de 19,1% (IC95%: 17,5-20,9) entre aqueles vinculados a empresas de maior porte.

Tabela 26. Prevalência (IC95%) de **problema crônico de coluna referido** em trabalhadores(as) da indústria, segundo características demográficas. SESI, 2025.

Variável demográfica	Categoria	% (IC95%)
Sexo biológico	Masculino	**17,3** (16,0-18,7)
	Feminino	**22,2** (19,3-25,5)
Faixa etária (anos)	<30	**15,3** (12,8-18,1)
	30-39	**16,2** (13,4-19,3)
	40-59	**25,4** (23,1-27,9)
	≥60	**31,1** (27,2-35,3)
Situação conjugal	Solteiro(a)	**15,4** (13,3-17,7)
	Casado(a) ou vivendo com parceiro(a)	**21,6** (19,5-23,8)
	Viúvo(a), desquitado(a) ou divorciado(a)	**23,2** (19,9-26,9)
Escolaridade	Ensino fundamental incompleto	**25,4** (22,6-28,3)
	Ensino fundamental completo	**20,3** (18,1-22,7)
	Ensino médio ou técnico completo	**16,9** (15,4-18,5)
	Ensino superior incompleto	**14,0** (12,1-16,2)
	Ensino superior completo	**23,6** (19,3-28,5)
Número de filhos	Nenhum	**16,0** (13,5-18,8)
	1 filho(a)	**18,8** (16,1-21,8)
	2 a 3 filhos(as)	**23,1** (20,6-25,8)
	4 ou mais filhos(as)	**26,3** (23,1-29,7)

Acesso a plano de saúde	Não Sim	**19,3** (17,1-21,7) **19,3** (17,4-21,4)
Tempo de trabalho na empresa	Menos de 1 ano Entre 1 e 5 anos Entre 5 e 10 anos Mais de 10 anos	**16,0** (13,4-19,0) **17,2** (14,8-19,8) **21,8** (18,1-25,9) **27,4** (24,1-30,8)

Fonte: próprio autor.

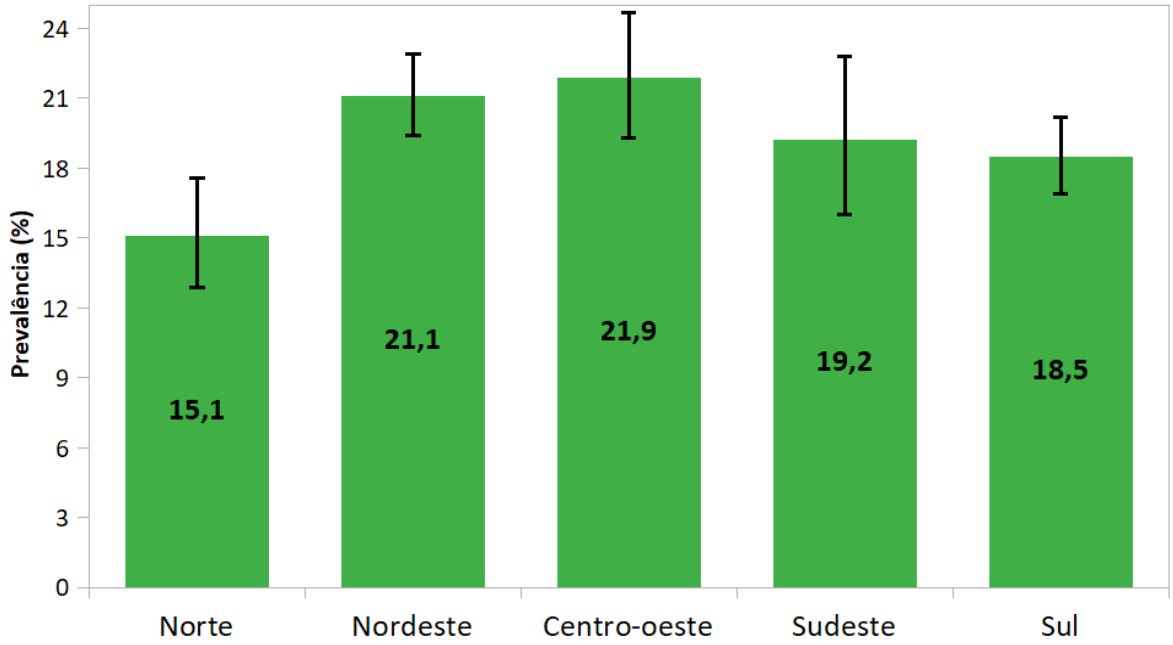


Figura 25. Prevalência de **problema crônico de coluna referido** em trabalhadores(as) da indústria, segundo região geográfica. As colunas representam as estimativas de prevalência e as barras de erro indicam os intervalos de confiança de 95% (IC95%). SESI, 2025.

Fonte: próprio autor.

Percepção de saúde e autocuidado

[Inserir uma página com ilustração adequada a essa dimensão]

Baixa frequência de atividades de controle de condições crônicas

> Considerou-se que a frequência de atividades de controle de condições crônicas era baixa quando o(a) trabalhador(a) que referiu ter, pelo menos, uma condição crônica relatou que raramente ou nunca realiza atividades direcionadas ao controle dessas condições.

Pessoas que convivem com condições crônicas (obesidade, diabetes, hipertensão, dentre outras) precisam desenvolver práticas de cuidado, como a adesão aos tratamentos instituídos e a realização de exames e consultas periódicos a fim de manter sob controle essas enfermidades[89]. Isso é importante porque esses indivíduos têm maior risco de mortalidade precoce e de sofrerem com as complicações decorrentes do agravamento da doença. Atividades de controle de condições crônicas são indicadas como estratégias efetivas na melhoria da qualidade de vida e de indicadores fisiológicos de controle das enfermidades[90].

A prevalência de baixa frequência de atividades de controle de condições crônicas foi de 32% (IC95%: 30,0-34,0), sendo de 34,5% entre homens e de 29,0% entre as mulheres (Tabela 27). Observou-se que a prevalência desse indicador foi mais elevada em pessoas jovens e entre os trabalhadores(as) com menor nível de escolaridade (ensino fundamental incompleto). A prevalência desse indicador também foi mais elevada entre os industriários(as) que referiram ter quatro ou mais filhos e que tem menor tempo de vínculo com a empresa (Tabela 27).

As estimativas segundo região geográfica estão apresentadas na Figura 26. Em relação ao porte da empresa, a prevalência foi de 38,2% (IC95%: 33,9-42,7) entre os trabalhadores de micro e pequenas empresas e de 30,2% (IC95%: 28,0-32,4) entre aqueles vinculados a empresas de médio e grande porte.

Tabela 27. Prevalência (IC95%) de **baixa frequência de atividades de controle de condições crônicas** em trabalhadores(as) da indústria, segundo características demográficas. SESI, 2025.

Variável demográfica	Categoria	% (IC95%)
Sexo biológico	Masculino	**34,5** (32,5-36,6)
	Feminino	**29,0** (25,6-32,7)
Faixa etária (anos)	<30	**41,5** (37,0-46,2)
	30-39	**30,2** (26,8-33,8)
	40-59	**27,6** (24,9-30,4)
	≥60	**24,2** (19,9-29,1)
Situação conjugal	Solteiro(a)	**34,1** (30,6-37,7)

	Casado(a) ou vivendo com parceiro(a) Viúvo(a), desquitado(a) ou divorciado(a)	**30,7** (28,1-33,4) **33,4** (26,8-40,9)
Escolaridade	Ensino fundamental incompleto Ensino fundamental completo Ensino médio ou técnico completo Ensino superior incompleto Ensino superior completo	**50,5** (45,4-55,7) **40,8** (37,2-44,5) **35,9** (33,1-38,9) **31,6** (27,4-36,0) **19,6** (15,5-24,4)
Número de filhos	Nenhum 1 filho(a) 2 a 3 filhos(as) 4 ou mais filhos(as)	**32,2** (28,3-36,4) **32,2** (28,5-36,2) **30,3** (27,7-33,2) **40,4** (35,3-45,7)
Acesso a plano de saúde	Não Sim	**41,5** (38,4-44,7) **25,5** (23,1-28,0)
Tempo de trabalho na empresa	Menos de 1 ano Entre 1 e 5 anos Entre 5 e 10 anos Mais de 10 anos	**41,1** (37,2-45,0) **33,3** (29,7-37,2) **28,8** (24,3-33,8) **21,6** (19,1-24,4)

Fonte: próprio autor.

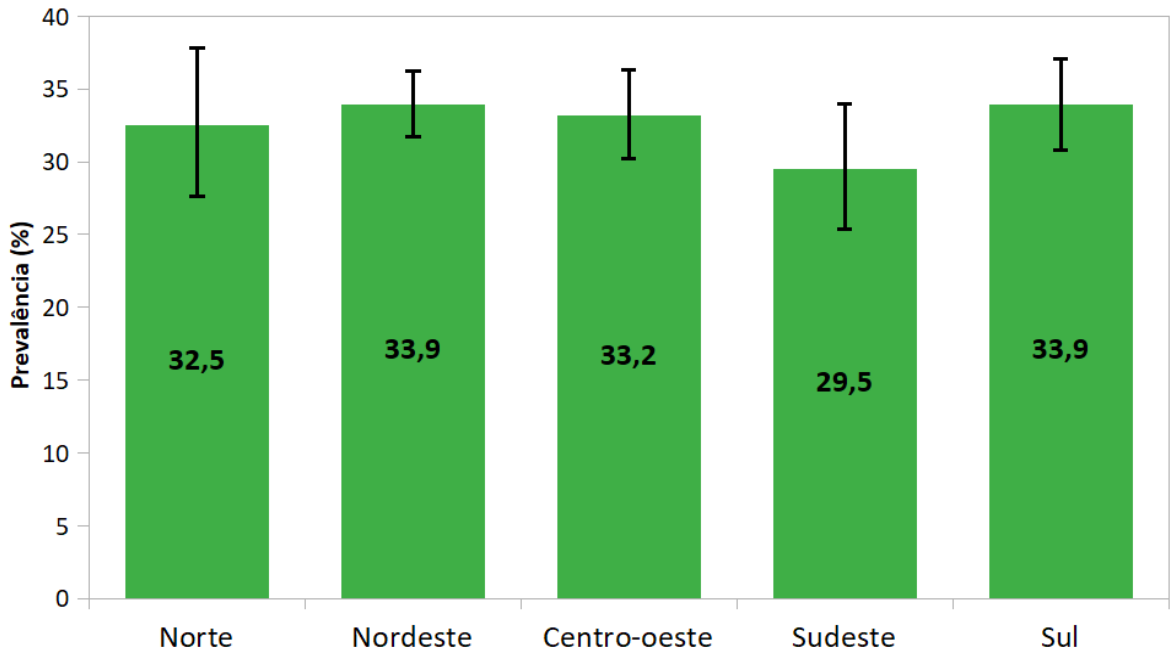


Figura 26. Prevalência (%) de trabalhadores(as) com baixa frequência de controle de condições crônicas, segundo região geográfica. As colunas representam as estimativas de prevalência e as barras de erro indicam os intervalos de confiança de 95% (IC95%). SESI, 2025.

Fonte: próprio autor.

Atitude negativa para o autocuidado

Considerou-se haver uma atitude negativa para o autocuidado quando o(a) trabalhador(a) relatou que “não acha importante cuidar da saúde e não

> pretende adotar cuidados em relação à saúde" ou que "cuidar da saúde pode ser importante, mas não pretende adotar cuidados em relação à saúde nos próximos seis meses".

A qualidade de vida de pessoas que lidam com a necessidade de controlar condições crônicas pode ser bastante influenciada pelas práticas de autocuidado que as mesmas adotam[91]. Práticas ou comportamentos de autocuidado dizem respeito a um constructo que expressa o comprometimento da pessoa com o cuidado em relação à própria saúde, abrangendo a aderência a tratamentos, adoção de estilos de vida saudáveis, controle de parâmetros fisiológicos (glicemia, pressão arterial e colesterol) e a realização de consultas e exames preventivos periódicos[92]. Mesmo nas práticas de cuidado relacionadas a enfermidades crônicas graves, estima-se que grande proporção das pessoas não realiza as atividades de autocuidado, comprometendo assim o adequado controle dessas condições[93-94].

A prevalência de atitude negativa para o autocuidado foi de 6,3% (IC95%: 5,3-7,4), sendo de 6,9% entre os homens e de 5,4% entre as mulheres (Tabela 28). Observou-se redução das estimativas com o aumento da escolaridade, variando de 20,7% entre trabalhadores(as) com ensino fundamental incompleto a 3,7% entre aqueles(as) com ensino superior completo. Estimativas mais elevadas também foram observadas entre trabalhadores(as) sem acesso a plano de saúde e com menos de um ano de vínculo com a empresa.

As estimativas de prevalência foram semelhantes nas diferentes regiões geográficas (Figura 27); além disso, a prevalência foi idêntica entre aqueles vinculados a empresas de menor (6,3% [IC95%: 5,0-7,8]) e maior (6,3% [IC95%: 5,1-7,8]) porte.

Tabela 28. Prevalência (IC95%) de **atitude negativa para o autocuidado** em trabalhadores(as), segundo características demográficas. SESI, 2025.

Variável demográfica	Categoria	% (IC95%)
Sexo biológico	Masculino	**6,9** (5,9-8,1)
	Feminino	**5,4** (3,6-7,9)
Faixa etária (anos)	<30	**7,5** (5,9-9,5)
	30-39	**5,7** (3,8-8,6)
	40-59	**5,8** (4,6-7,3)
	≥60	**5,6** (4,1-7,6)
Situação conjugal	Solteiro(a)	**7,5** (5,9-9,5)
	Casado(a) ou vivendo com parceiro(a)	**5,5** (4,3-7,2)

	Viúvo(a), desquitado(a) ou divorciado(a)	**5,5** (3,8-8,1)
Escolaridade	Ensino fundamental incompleto Ensino fundamental completo Ensino médio ou técnico completo Ensino superior incompleto Ensino superior completo	**20,7** (15,2-27,5) **7,6** (6,2-9,3) **5,2** (4,2-6,4) **4,6** (3,4-6,3) **3,7** (1,7-7,6)
Número de filhos	Nenhum 1 filho(a) 2 a 3 filhos(as) 4 ou mais filhos(as)	**5,9** (4,7-7,6) **7,8** (5,2-11,3) **5,4** (4,1-6,9) **6,5** (5,0-8,4)
Acesso a plano de saúde	Não Sim	**8,5** (7,0-10,2) **4,7** (3,4-6,4)
Tempo de trabalho na empresa	Menos de 1 ano Entre 1 e 5 anos Entre 5 e 10 anos Mais de 10 anos	**9,1** (6,9-11,9) **5,5** (4,4-6,7) **6,9** (3,1-14,6) **3,7** (3,1-4,3)

Fonte: próprio autor.

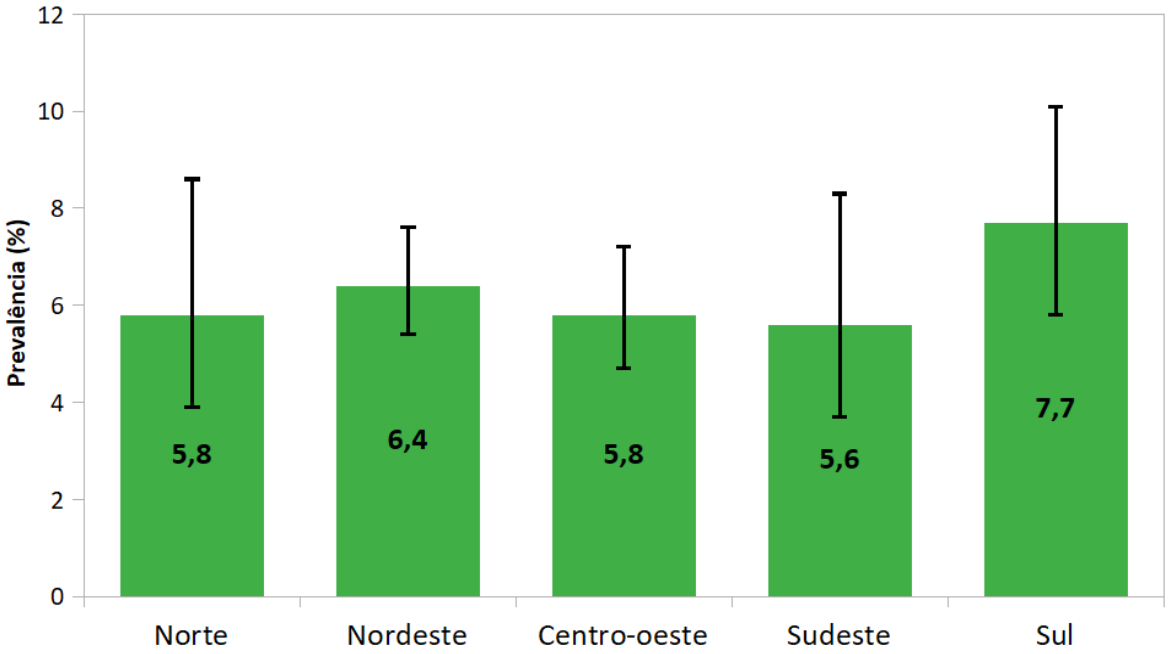


Figura 27. Prevalência de **atitude negativa para o autocuidado** em trabalhadores(as) da indústria, segundo região geográfica. As colunas representam as estimativas de prevalência e as barras de erro indicam os intervalos de confiança de 95% (IC95%). SESI, 2025.

Fonte: próprio autor.

<u>Percepção de saúde negativa</u>

Considerou-se percepção de saúde negativa quando o(a) trabalhador(a) classificou o seu estado de saúde atual como sendo “ruim” ou “muito ruim”.

A percepção da saúde é uma medida subjetiva que indica o nível global de saúde, a partir de uma autoavaliação feita pelo indivíduo considerando as suas condições pessoais[95]. A percepção de saúde é um forte preditor de mortalidade precoce, maior utilização de serviços médico-hospitalares e de maior uso de medicamentos[96-97]. Ser fisicamente inativo, ter excesso de peso, alimentar-se inadequadamente, ter pressão arterial elevada e exposição a elevado nível de estresse são fatores associados a uma percepção de saúde negativa[98]. Há também evidências de que trabalhadores que referem percepção de saúde negativa tendem a faltar mais ao trabalho e apresentar índices de presenteísmo mais elevados[99].

A prevalência de percepção de saúde negativa foi de 7,9% (IC95%: 6,6-9,5), sendo de 10,6% entre as mulheres e de 6,1% entre os homens. Diferente do esperado, verificou-se redução das estimativas com o aumento da faixa etária, variando de 8,9% entre trabalhadores(as) com menos de 30 anos a 3,2% entre aqueles(as) com 60 anos ou mais. Também foram observadas variações segundo situação conjugal, escolaridade e número de filhos, sem padrão consistente entre todas as categorias (Tabela 29).

Em relação às regiões geográficas, observou-se maior prevalência de percepção de saúde negativa na região Norte em comparação às demais regiões (Figura 28). Quanto ao porte das empresas, as estimativas foram de 6,8% (IC95%: 5,4-8,5) entre trabalhadores(as) de empresas de menor porte e de 8,3% (IC95%: 6,6-10,3) entre aqueles(as) de empresas de maior porte.

Tabela 29. Prevalência (IC95%) de **percepção de saúde negativa** em trabalhadores(as) da indústria, segundo características demográficas. SESI, 2025.

Variável demográfica	Categoria	% (IC95%)
Sexo biológico	Masculino	**6,1** (5,1-7,2)
	Feminino	**10,6** (7,8-14,3)
Faixa etária (anos)	<30	**8,9** (7,2-11,0)
	30-39	**9,0** (6,3-12,7)
	40-59	**6,2** (4,3-8,9)
	≥60	**3,2** (2,1-5,0)
Situação conjugal	Solteiro(a)	**10,0** (7,8-12,9)
	Casado(a) ou vivendo com parceiro(a)	**6,7** (5,1-8,9)
	Viúvo(a), desquitado(a) ou divorciado(a)	**5,4** (3,7-7,8)
Escolaridade	Ensino fundamental incompleto	**14,7** (10,0-21,0)
	Ensino fundamental completo	**7,8** (5,9-10,3)
	Ensino médio ou técnico completo	**5,4** (4,4-6,7)
	Ensino superior incompleto	**7,2** (5,6-9,3)

	Ensino superior completo	**9,7** (6,0-15,2)
Número de filhos	Nenhum 1 filho(a) 2 a 3 filhos(as) 4 ou mais filhos(as)	**9,6** (7,4-12,4) **7,9** (5,3-11,5) **6,1** (4,0-9,0) **6,0** (4,6-7,7)
Acesso a plano de saúde	Não Sim	**7,7** (6,4-9,3) **8,1** (6,1-10,7)
Tempo de trabalho na empresa	Menos de 1 ano Entre 1 e 5 anos Entre 5 e 10 anos Mais de 10 anos	**9,0** (7,0-11,4) **6,1** (5,0-7,4) **10,0** (4,7-20,0) **9,1** (5,7-14,2)

Fonte: próprio autor.

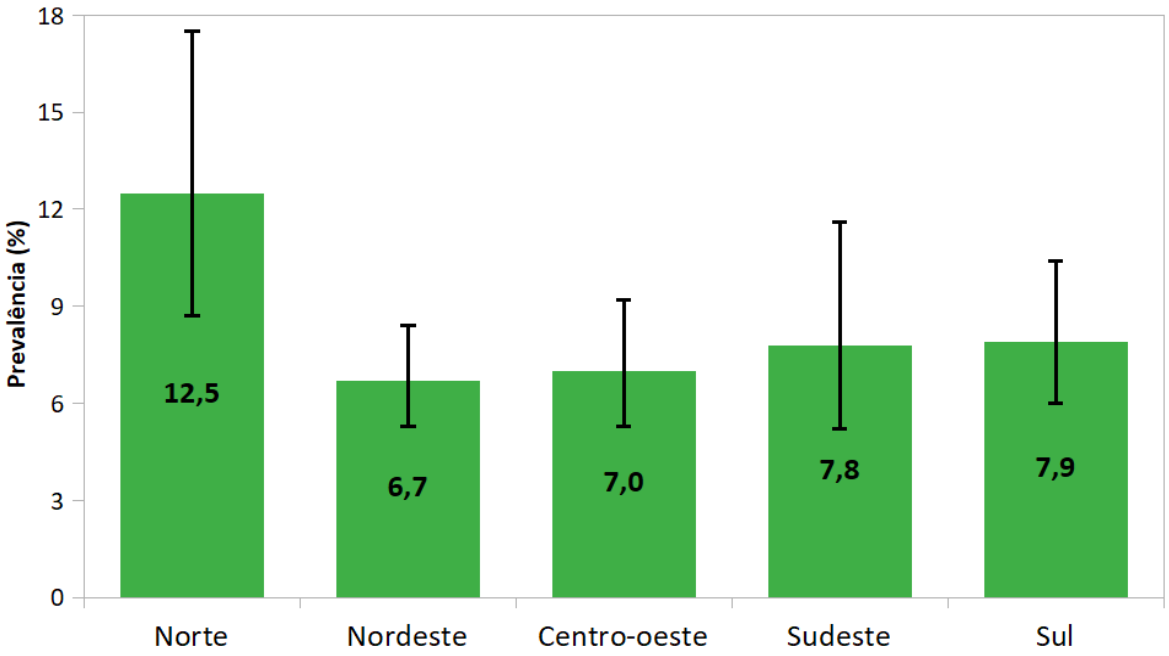


Figura 28. Prevalência de **percepção de saúde negativa** em trabalhadores(as) da indústria, segundo região geográfica. As colunas representam as estimativas de prevalência e as barras de erro indicam os intervalos de confiança de 95% (IC95%). SESI, 2025.

Fonte: próprio autor.

Percepção de saúde bucal negativa

> Considerou-se percepção de saúde bucal negativa quando o trabalhador classificou a sua saúde bucal como sendo “ruim” ou “muito ruim”.

A cárie é o principal problema de saúde bucal dos brasileiros, sendo que entre pessoas adultas a maior parte tem cáries ou restaurações dentárias realizadas[100]. A percepção de saúde bucal é uma

medida simples e que tem forte correlação com qualidade de vida e com a autoestima das pessoas[101]. Existem evidências até mesmo de que uma percepção de saúde bucal negativa está longitudinalmente associada a redução do vigor físico (velocidade de marcha) e, nos mais velhos, à fragilidade[102]. Mas, noutro sentido, uma percepção da saúde bucal negativa pode ser também um resultado de exposição a elevado nível de estresse[103].

A prevalência de percepção de saúde bucal negativa foi de 7,1% (IC95%: 5,9-8,5), observando-se maior estimativa deste indicador entre trabalhadores(as) com ensino fundamental incompleto (17,5%). Notou-se, ainda, redução das estimativas nas categorias de maior escolaridade, embora sem padrão linear de diminuição. Estimativas mais elevadas também foram observadas entre trabalhadores(as) sem acesso a plano de saúde e com menos de um ano de vínculo com a empresa (Tabela 30).

As estimativas de prevalência foram semelhantes entre as regiões geográficas (Figura 29). Em relação ao porte das empresas, também foram observadas prevalências semelhantes entre trabalhadores(as) vinculados a empresas de menor (8,2% [IC95%: 5,5-12,1]) e maior porte (6,8% [IC95%: 5,6-8,2]) (Figura 29).

Tabela 30. Prevalência (IC95%) de **percepção de saúde bucal negativa** em trabalhadores(as) da indústria, segundo características demográficas. SESI, 2025.

Variável demográfica	Categoria	% (IC95%)
Sexo biológico	Masculino	**6,6** (5,7-7,7)
	Feminino	**7,8** (5,5-11,0)
Faixa etária (anos)	<30	**7,5** (5,9-9,5)
	30-39	**6,5** (4,4-9,4)
	40-59	**7,5** (5,6-10,1)
	≥60	**4,9** (3,5-6,8)
Situação conjugal	Solteiro(a)	**7,0** (5,6-8,8)
	Casado(a) ou vivendo com parceiro(a)	**7,2** (5,5-9,4)
	Viúvo(a), desquitado(a) ou divorciado(a)	**6,8** (4,6-9,9)
Escolaridade	Ensino fundamental incompleto	**17,5** (12,7-23,5)
	Ensino fundamental completo	**8,2** (6,5-10,3)
	Ensino médio ou técnico completo	**5,6** (4,6-6,9)
	Ensino superior incompleto	**5,5** (4,1-7,3)
	Ensino superior completo	**6,4** (3,5-11,4)
Número de filhos	Nenhum	**6,6** (5,1-8,4)
	1 filho(a)	**7,4** (4,9-10,9)
	2 a 3 filhos(as)	**7,5** (5,4-10,3)

	4 ou mais filhos(as)	**8,0** (6,4-10,1)
Acesso a plano de saúde	Não Sim	**8,7** (7,3-10,3) **6,0** (4,3-8,2)
Tempo de trabalho na empresa	Menos de 1 ano Entre 1 e 5 anos Entre 5 e 10 anos Mais de 10 anos	**8,7** (6,9-11,1) **6,5** (5,3-7,9) **7,6** (3,7-15,0) **5,9** (3,0-11,2)

Fonte: próprio autor.

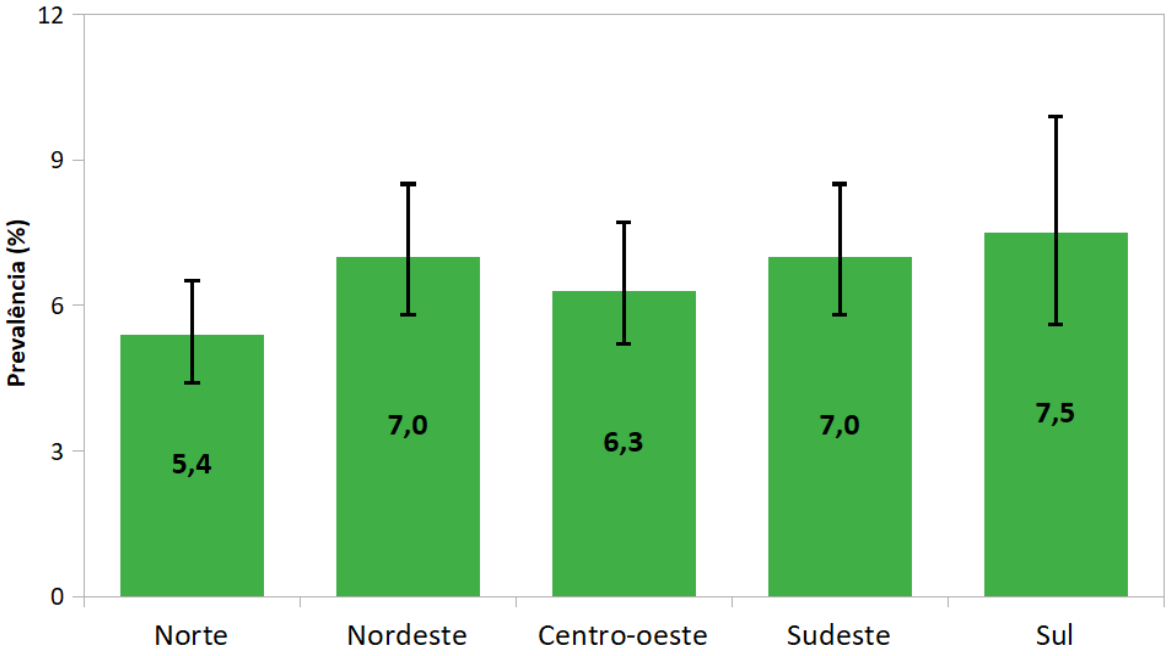


Figura 29. Prevalência de **percepção de saúde bucal negativa** em trabalhadores(as) da indústria, segundo região geográfica. As colunas representam as estimativas de prevalência e as barras de erro indicam os intervalos de confiança de 95% (IC95%). SESI, 2025.

Fonte: próprio autor.

Cultura de segurança

[Inserir uma página com ilustração adequada a essa dimensão]

Atenção! Até esta seção do relatório todos os indicadores analisados expressaram fatores negativos (comportamentos de risco, estresse psicossocial, adoecimento, dentre outros). Nesta seção, ao contrário, ao analisar a cultura de segurança, todos os indicadores expressam condições positivas, assim quanto maior for a estimativa melhor a condição observada.

Segurança e prevenção de acidentes são importantes para a empresa

Considerou-se que segurança e prevenção de acidentes são importantes para a empresa quando o trabalhador referiu que a empresa dá "alguma importância" ou "muita importância" para a segurança e a prevenção de acidentes.

A segurança e a prevenção de acidentes devem ser um valor para as empresas. Nas organizações onde a segurança é um valor, percebe-se que as políticas relacionadas à prevenção de acidentes têm muita importância e todos, administradores, lideranças e trabalhadores atuam de modo cooperativo e engajado em torno desse valor[104]. Nesse contexto, a percepção dos trabalhadores de que segurança e prevenção de acidentes têm muita importância tende a contribuir com maior aderência a comportamentos e normas que visam tornar o trabalho mais seguro[105]. Havendo demonstração clara de que a segurança é um tema importante para a organização todos tendem a se engajar de modo mais consistente nas ações direcionadas à prevenção de acidentes[105-106].

Neste inquérito, verificou-se que 84,0% (IC95%: 82,3-85,6) dos(as) trabalhadores(as) referiram que a segurança e a prevenção de acidentes são importantes para a empresa. As estimativas foram elevadas em todas as categorias demográficas analisadas. Observou-se aumento das prevalências nas categorias de maior escolaridade e maior tempo de vínculo com a empresa. Estimativa mais elevada também foi observada entre trabalhadores(as) com acesso a plano de saúde (Tabela 31).

A proporção de participantes que referiu que segurança e prevenção de acidentes são importantes para a empresa foi semelhante entre as regiões geográficas (Figura 30). Em relação ao porte das empresas, observou-se prevalência de 79,7% (IC95%: 75,1-83,7) entre trabalhadores(as) vinculados a empresas de menor porte e de 85,3% (IC95%: 83,5-87,0) entre aqueles(as) de empresas de maior porte.

Tabela 31. Proporção (IC95%) de trabalhadores(as) que referiram que **segurança e prevenção de acidentes são importantes para a empresa**, segundo características demográficas. SESI, 2025.

Variável demográfica	Categoria	% (IC95%)
Sexo biológico	Masculino	**83,8** (81,9-85,5)

	Feminino	**84,4** (80,9-87,3)
Faixa etária (anos)	<30	**82,3** (79,2-85,1)
	30-39	**83,6** (80,2-86,5)
	40-59	**85,7** (82,7-88,1)
	≥60	**88,2** (84,5-91,1)
Situação conjugal	Solteiro(a)	**83,0** (80,2-85,5)
	Casado(a) ou vivendo com parceiro(a)	**84,6** (82,2-86,8)
	Viúvo(a), desquitado(a) ou divorciado(a)	**84,9** (78,4-89,7)
Escolaridade	Ensino fundamental incompleto	**76,9** (70,3-82,4)
	Ensino fundamental completo	**83,9** (80,5-86,8)
	Ensino médio ou técnico completo	**84,3** (81,8-86,4)
	Ensino superior incompleto	**86,8** (84,3-89,0)
	Ensino superior completo	**84,4** (79,4-88,3)
Número de filhos	Nenhum	**84,3** (81,7-86,6)
	1 filho(a)	**81,8** (77,6-85,4)
	2 a 3 filhos(as)	**85,2** (82,1-87,8)
	4 ou mais filhos(as)	**88,1** (85,5-90,3)
Acesso a plano de saúde	Não	**81,5** (79,0-83,7)
	Sim	**85,9** (83,4-88,1)
Tempo de trabalho na empresa	Menos de 1 ano	**83,6** (80,8-86,0)
	Entre 1 e 5 anos	**82,2** (79,3-84,7)
	Entre 5 e 10 anos	**86,4** (80,1-90,9)
	Mais de 10 anos	**87,4** (82,9-90,8)

Fonte: próprio autor.

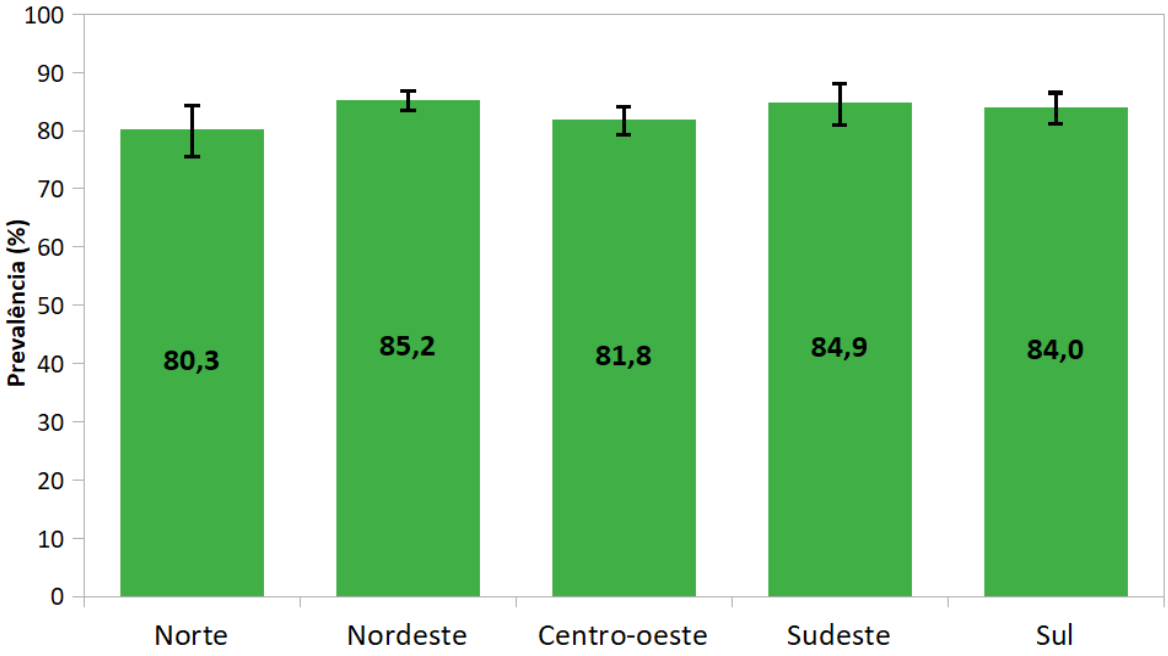


Figura 30. Proporção de trabalhadores(as) que consideram que **segurança e prevenção de acidentes são importantes para a empresa**, segundo região geográfica. As colunas representam as estimativas de prevalência e as barras de erro indicam os intervalos de confiança de 95% (IC95%). SESI, 2025.

Fonte: próprio autor.

Percepção de ambiente de trabalho seguro

> Considerou-se percepção de ambiente de trabalho seguro quando o(a) trabalhador(a) referiu sentir-se “seguro(a) no ambiente de trabalho” e considerar que esse “ambiente contribui para a prevenção de acidentes e para maior segurança”.

Promover um ambiente de trabalho seguro e saudável e garantir que os trabalhadores se sintam seguros são fatores-chave para o sucesso das organizações. Trabalhadores que tem uma percepção mais positiva em relação à segurança no ambiente de trabalho tendem a referir maior bem-estar e indicadores mais positivos de saúde mental[107]. Em sentido oposto, um ambiente de trabalho inseguro pode levar a um aumento do estresse e maior incidência de transtornos mentais, acidentes e doenças ocupacionais[108]. A percepção de segurança no trabalho favorece a concentração nas tarefas, reduzindo o risco de acidentes. Trabalhadores que se sentem seguros são mais propensos a seguir procedimentos de segurança e a utilizar equipamentos de proteção, o que, por sua vez, contribui para a prevenção de acidentes de trabalho e para maior satisfação com as condições de trabalho[109]. Além disso, empresas comprometidas com a segurança no trabalho retêm talentos, têm uma melhor reputação no mercado e demonstram responsabilidade social corporativa.

A proporção de trabalhadores que referiram perceber o ambiente de trabalho como seguro foi de 71,4% (IC95%: 69,6-73,1). As estimativas foram mais baixas entre trabalhadores(as) com menos de 30 anos (67,7%) e mais elevadas entre aqueles(as) com 60 anos ou mais (80,1%) (Tabela 32).

Em relação às regiões geográficas, foram observadas estimativas mais baixas nas regiões Centro-Oeste e Sul (Figura 31). Quanto ao porte das empresas, as prevalências foram semelhantes entre trabalhadores(as) vinculados a empresas de menor (69,8% [IC95%: 66,2–73,2]) e maior porte (71,8% [IC95%: 69,8–73,8]).

Tabela 32. Proporção (IC95%) de trabalhadores(as) que referiram **percepção de ambiente de trabalho seguro**, segundo características demográficas. SESI, 2025.

Variável demográfica	Categoria	% (IC95%)
Sexo biológico	Masculino	**72,3** (70,2-74,2)

	Feminino	**70,1** (66,7-73,2)
Faixa etária (anos)	<30 30-39 40-59 ≥60	**68,3** (66,0-70,6) **72,7** (69,4-75,8) **72,1** (68,4-75,5) **80,1** (76,3-83,5)
Situação conjugal	Solteiro(a) Casado(a) ou vivendo com parceiro(a) Viúvo(a), desquitado(a) ou divorciado(a)	**70,5** (67,7-73,1) **72,0** (69,5-74,4) **70,0** (64,0-75,4)
Escolaridade	Ensino fundamental incompleto Ensino fundamental completo Ensino médio ou técnico completo Ensino superior incompleto Ensino superior completo	**68,7** (63,5-73,4) **70,1** (64,3-75,4) **70,5** (68,0-72,9) **72,5** (67,9-76,7) **73,3** (69,0-77,1)
Número de filhos	Nenhum 1 filho(a) 2 a 3 filhos(as) 4 ou mais filhos(as)	**71,9** (69,3-74,4) **70,9** (67,5-74,1) **70,6** (66,7-74,2) **75,9** (72,1-79,4)
Acesso a plano de saúde	Não Sim	**68,7** (66,5-70,9) **73,3** (70,6-75,8)
Tempo de trabalho na empresa	Menos de 1 ano Entre 1 e 5 anos Entre 5 e 10 anos Mais de 10 anos	**70,3** (66,9-73,5) **70,3** (67,5-73,0) **74,0** (68,3-79,0) **73,5** (69,4-77,2)

Fonte: próprio autor.

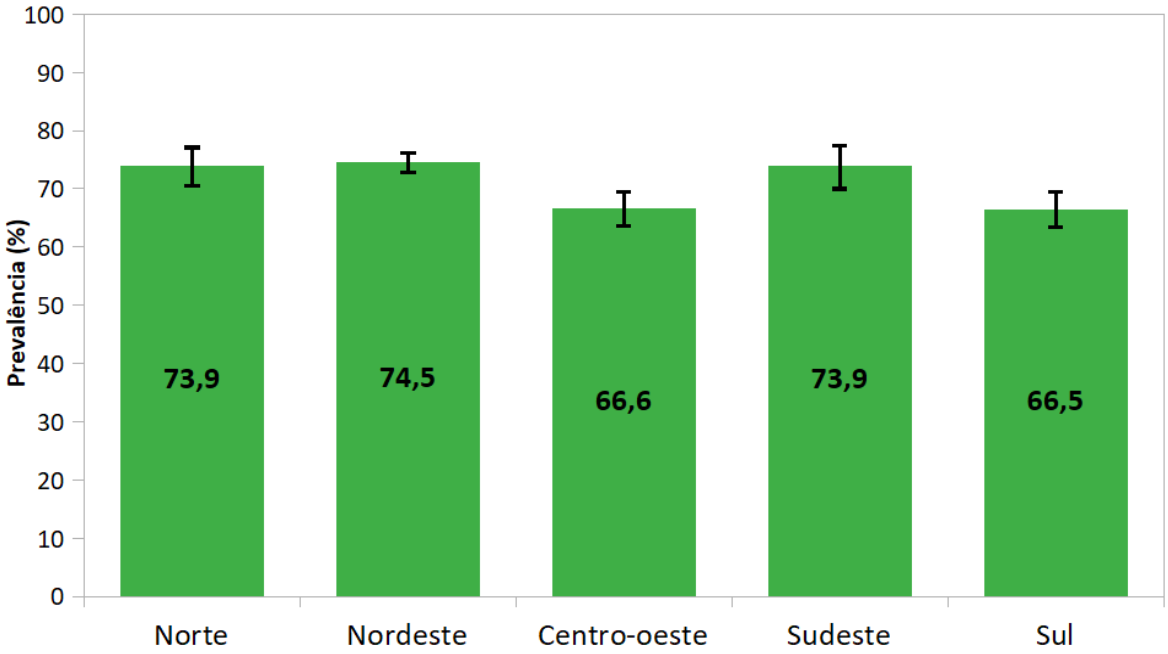


Figura 31. Proporção de trabalhadores(as) que referiram **percepção de ambiente de trabalho seguro**, segundo região geográfica. As colunas representam as estimativas de prevalência e as barras de erro indicam os intervalos de confiança de 95% (IC95%). SESI, 2025.

Fonte: próprio autor.

Liderança obedece e encoraja obediência às normas de segurança

> Considerou-se que a liderança obedece e encoraja a obediência às normas de segurança quando o(a) trabalhador(a) referiu que "a liderança é um exemplo de respeito e comprometimento com as questões de segurança no trabalho" e que "a liderança encoraja e apoia a obediência às normas de prevenção de acidentes".

As lideranças de uma organização deveriam servir de exemplo no que diz respeito ao compromisso com a segurança no trabalho, encorajando e apoiando a adesão dos trabalhadores às normas de prevenção de acidentes. Essa postura da liderança é vital, pois transmite à equipe a inegociável importância da segurança como um valor fundamental da empresa. A liderança exerce um papel crucial na construção e manutenção de uma cultura de segurança na organização[110]. Líderes que demonstram respeito pelas normas de segurança e se comprometem com a prevenção de acidentes inspiram os demais a adotar comportamentos seguros, fomentando uma cultura onde todos se consideram responsáveis pela própria segurança e pela de seus colegas[111]. A confiança na liderança para preservar o bem-estar e a segurança dos colaboradores resulta em maior engajamento e comprometimento de toda a equipe[111-112]. Isso não apenas protege a saúde e segurança dos trabalhadores, mas também traz economia de recursos financeiros e evita interrupções nas operações da empresa, o que, por sua vez, contribui para a sustentabilidade e sucesso a longo prazo da organização.

A proporção de trabalhadores(as) que referiram que a liderança obedece e encoraja obediência às normas de segurança foi de 72,6% (IC95%: 70,7-74,4), sendo mais elevada entre os homens (74,0%) em comparação as mulheres (70,7%), conforme apresentado na Tabela 33. Esta prevalência também foi maior entre os(as) trabalhadores(as) com 60 anos de idade ou mais e entre aqueles com quatro ou mais filhos. Em contrapartida, a prevalência foi mais baixa entre os trabalhadores da região Sul (Figura 32). As estimativas foram semelhantes entre trabalhadores(as) de empresas de menor (68,3% [IC95%: 64,2-72,1]) e maior (73,9% [IC95%: 71,8-75,9]) porte.

Tabela 33. Proporção (IC95%) de trabalhadores(as) que referiram que a **liderança obedece e encoraja obediência às normas de segurança**, segundo características demográficas. SESI, 2025.

Variável demográfica	Categoria	% (IC95%)
Sexo biológico	Masculino	**74,0** (71,9-75,9)
	Feminino	**70,7** (67,1-74,0)

Faixa etária (anos)	<30 30-39 40-59 ≥60	**70,9** (68,1-73,6) **73,4** (69,7-76,7) **72,9** (69,5-76,1) **79,7** (74,7-83,9)
Situação conjugal	Solteiro(a) Casado(a) ou vivendo com parceiro(a) Viúvo(a), desquitado(a) ou divorciado(a)	**72,0** (68,9-74,8) **73,2** (70,6-75,6) **71,1** (64,4-77,1)
Escolaridade	Ensino fundamental incompleto Ensino fundamental completo Ensino médio ou técnico completo Ensino superior incompleto Ensino superior completo	**70,2** (64,9-74,9) **69,3** (63,3-74,7) **72,0** (69,5-74,5) **75,9** (71,3-80,0) **73,5** (68,9-77,7)
Número de filhos	Nenhum 1 filho(a) 2 a 3 filhos(as) 4 ou mais filhos(as)	**71,5** (68,3-74,6) **72,7** (69,3-75,9) **73,0** (69,4-76,3) **80,5** (77,0-83,6)
Acesso a plano de saúde	Não Sim	**69,7** (66,9-72,3) **74,8** (72,3-77,2)
Tempo de trabalho na empresa	Menos de 1 ano Entre 1 e 5 anos Entre 5 e 10 anos Mais de 10 anos	**72,4** (68,4-76,0) **70,5** (67,4-73,4) **78,0** (74,5-81,1) **74,2** (70,1-77,9)

Fonte: próprio autor.

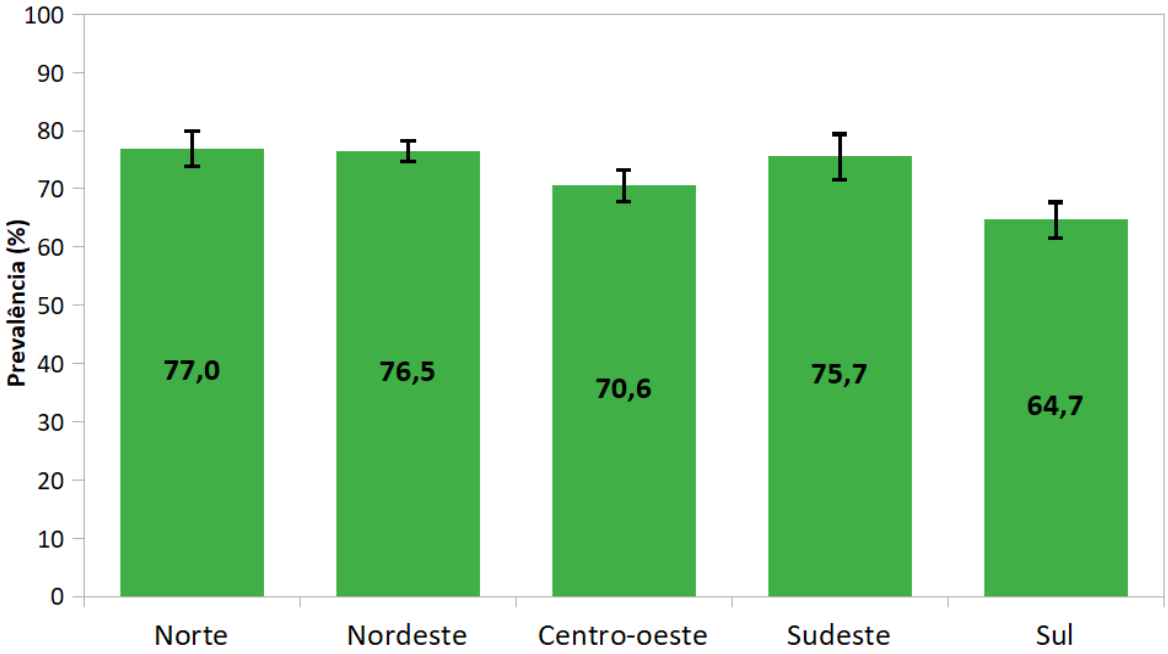


Figura 32. Proporção de trabalhadores(as) que referiram que a **liderança obedece e encoraja obediência às normas de segurança**, segundo região geográfica. As colunas representam as estimativas de prevalência e as barras de erro indicam os intervalos de confiança de 95% (IC95%). SESI, 2025.

Fonte: próprio autor.

Empresa prioriza e realiza esforços suficientes para prevenção de acidentes

> Considerou-se que a empresa prioriza e realiza esforços suficientes para prevenção de acidentes quando o(a) trabalhador(a) referiu que "a empresa considera a prevenção de acidentes e a segurança no trabalho como uma prioridade" e que "a empresa realiza esforços suficientes para a prevenção de acidentes e para garantir a segurança no trabalho".

O sucesso empresarial é um resultado que está associado à promoção de um ambiente de trabalho seguro e ao desenvolvimento de uma cultura de segurança, na qual a prevenção de acidentes e a segurança no trabalho são encarados como uma prioridade. Empresas que colocam a segurança no centro de suas operações refletem sua responsabilidade social corporativa, fortalecendo sua imagem perante clientes, parceiros comerciais e investidores, além de concorrer para atenuação da perda de produtividade[107]. Essa priorização da segurança no ambiente de trabalho contribui não apenas para a conformidade com princípios éticos, ao evitar lesões, doenças ocupacionais e acidentes no local de trabalho, mas também resulta em impactos financeiros positivos. Reduzir despesas com indenizações, licenças médicas, substituição de pessoal e custos judiciais associados a litígios trabalhistas são alguns dos benefícios tangíveis que podem derivar de uma cultura corporativa que prioriza a segurança e a prevenção de acidentes[112].

A proporção de trabalhadores(as) que referiram que a empresa prioriza e realiza esforços suficientes para prevenção de acidentes foi de 74,1% (IC95%: 72,3-75,7), maior entre trabalhadores com 60 anos de idade ou mais (83,4%) e da região Sudeste do país (78,9%) (Tabela 34). Em relação às regiões geográficas, foram observadas estimativas mais baixas nas regiões Centro-Oeste e Sul (Figura 33). Verificou-se uma prevalência de 70,2% (IC95%: 66,6-73,6) em trabalhadores de empresas de menor porte em comparação aos 75,2% (IC95%: 73,2-77,1) nas empresas de maior porte.

Tabela 34. Proporção (IC95%) de trabalhadores(as) que referiram que a **empresa prioriza e realiza esforços suficientes para prevenção de acidentes**, segundo características demográficas. SESI, 2025.

Variável demográfica	Categoria	% (IC95%)
Sexo biológico	Masculino	**74,5** (72,4-76,5)
	Feminino	**73,4** (70,4-76,3)
Faixa etária (anos)	<30	**71,0** (68,7-73,2)

	30-39 40-59 ≥60	**75,3** (72,0-78,3) **74,9** (71,4-78,0) **83,4** (79,8-86,5)
Situação conjugal	Solteiro(a) Casado(a) ou vivendo com parceiro(a) Viúvo(a), desquitado(a) ou divorciado(a)	**72,7** (70,0-75,3) **75,0** (72,6-77,2) **72,7** (66,6-78,0)
Escolaridade	Ensino fundamental incompleto Ensino fundamental completo Ensino médio ou técnico completo Ensino superior incompleto Ensino superior completo	**72,0** (66,7-76,8) **71,8** (65,6-77,3) **72,7** (70,2-75,1) **74,9** (70,2-79,0) **76,9** (73,3-80,2)
Número de filhos	Nenhum 1 filho(a) 2 a 3 filhos(as) 4 ou mais filhos(as)	**73,3** (70,7-75,8) **73,3** (69,9-76,5) **74,8** (71,2-78,1) **80,7** (77,0-84,0)
Acesso a plano de saúde	Não Sim	**70,8** (68,5-73,0) **76,4** (73,9-78,8)
Tempo de trabalho na empresa	Menos de 1 ano Entre 1 e 5 anos Entre 5 e 10 anos Mais de 10 anos	**72,7** (69,3-75,9) **72,1** (69,2-74,8) **80,6** (77,6-83,2) **76,0** (71,8-79,7)

Fonte: próprio autor.

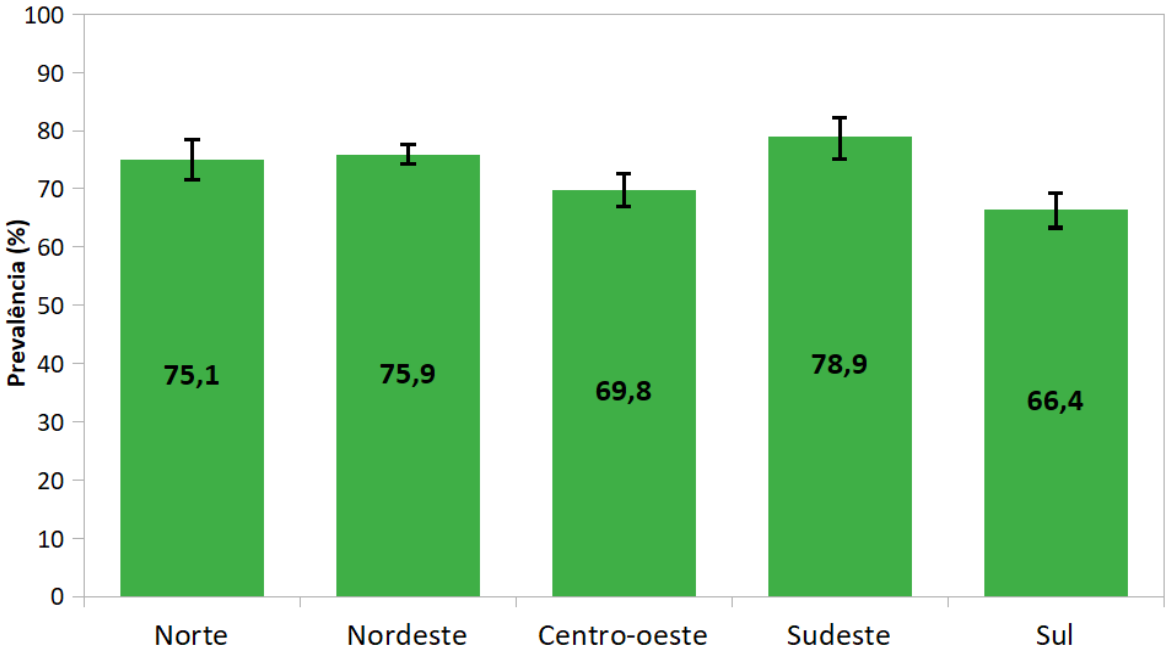


Figura 33. Proporção de trabalhadores(as) que referiram que a **empresa prioriza e realiza esforços suficientes para prevenção de acidentes**, segundo região geográfica. As colunas representam as estimativas de prevalência e as barras de erro indicam os intervalos de confiança de 95% (IC95%). SESI, 2025.

Fonte: próprio autor.

Treinamento para emergências e prevenção de acidentes

> Considerou-se que os trabalhadores recebem treinamento para emergências e prevenção de acidentes quando o(a) trabalhador(a) referiu que "recebeu treinamentos regulares" e que "sabe o que fazer ou onde procurar ajuda numa emergência ou quando ocorrer um acidente no trabalho".

Os trabalhadores devem ser informados e preparados para enfrentar emergências que podem ocorrer no local de trabalho. A prontidão para agir rapidamente em caso de incidentes pode ser a diferença entre evitar lesões graves e minimizar danos[113-114]. A realização de treinamentos regulares e de simulações desempenha um papel fundamental ao garantir que os trabalhadores saibam como responder de forma eficaz em situações de emergência[113]. Quando os trabalhadores estão preparados e confiantes em sua capacidade de lidar com emergências, a probabilidade de uma resposta eficaz aumenta significativamente. Investir na preparação dos funcionários para emergências não apenas protege a saúde e segurança dos trabalhadores, mas também fortalece a resiliência operacional da organização, contribuindo para o sucesso do negócio[115-116].

Nesse inquérito, verificou-se que 69,8% (IC95%: 68,1-71,5) dos(as) trabalhadores(as) referiram que receberam treinamento para emergências e prevenção de acidentes, uma proporção que foi maior entre os homens (71,2%) que o observado entre as mulheres (67,9%). Verificou-se que as estimativas desse indicador foram mais elevadas entre aqueles que tem acesso a plano de saúde e da região Sudeste, mas foi menor entre aqueles que não tem filhos (Tabela 35). A prevalência foi de 72,9% (IC95%: 71,0-74,8) entre os(a) trabalhadores(as) vinculados(as) a empresas de médio e grande porte em comparação ao observado entre aqueles de empresas de micro e pequeno porte (59,5% [IC95%: 56,0-63,0]).

Tabela 35. Proporção (IC95%) de trabalhadores(as) que referiram receber **treinamento para emergências e prevenção de acidentes**, segundo características demográficas. SESI, 2025.

Variável demográfica	Categoria	% (IC95%)
Sexo biológico	Masculino	**71,2** (69,2-73,1)
	Feminino	**67,9** (64,8-70,9)
Faixa etária (anos)	<30	**64,6** (62,1-67,0)
	30-39	**72,4** (69,0-75,5)
	40-59	**71,5** (68,3-74,5)
	≥60	**74,9** (70,4-78,9)
Situação conjugal	Solteiro(a)	**68,0** (65,2-70,7)
	Casado(a) ou vivendo com parceiro(a)	**71,1** (68,7-73,3)
	Viúvo(a), desquitado(a) ou divorciado(a)	**68,9** (64,1-73,3)

Escolaridade	Ensino fundamental incompleto	**65,5** (60,4-70,2)
	Ensino fundamental completo	**66,0** (60,3-71,2)
	Ensino médio ou técnico completo	**69,6** (67,2-71,9)
	Ensino superior incompleto	**70,9** (66,3-70,5)
	Ensino superior completo	**72,4** (68,6-76,0)
Número de filhos	Nenhum	**67,7** (65,0-70,3)
	1 filho(a)	**71,1** (67,7-74,2)
	2 a 3 filhos(as)	**70,7** (67,2-74,0)
	4 ou mais filhos(as)	**76,1** (72,2-79,6)
Acesso a plano de saúde	Não	**64,2** (61,9-66,4)
	Sim	**74,0** (71,5-76,4)
Tempo de trabalho na empresa	Menos de 1 ano	**62,6** (59,3-65,7)
	Entre 1 e 5 anos	**70,4** (67,6-73,0)
	Entre 5 e 10 anos	**78,1** (74,2-81,6)
	Mais de 10 anos	**73,1** (69,0-76,9)

Fonte: próprio autor.

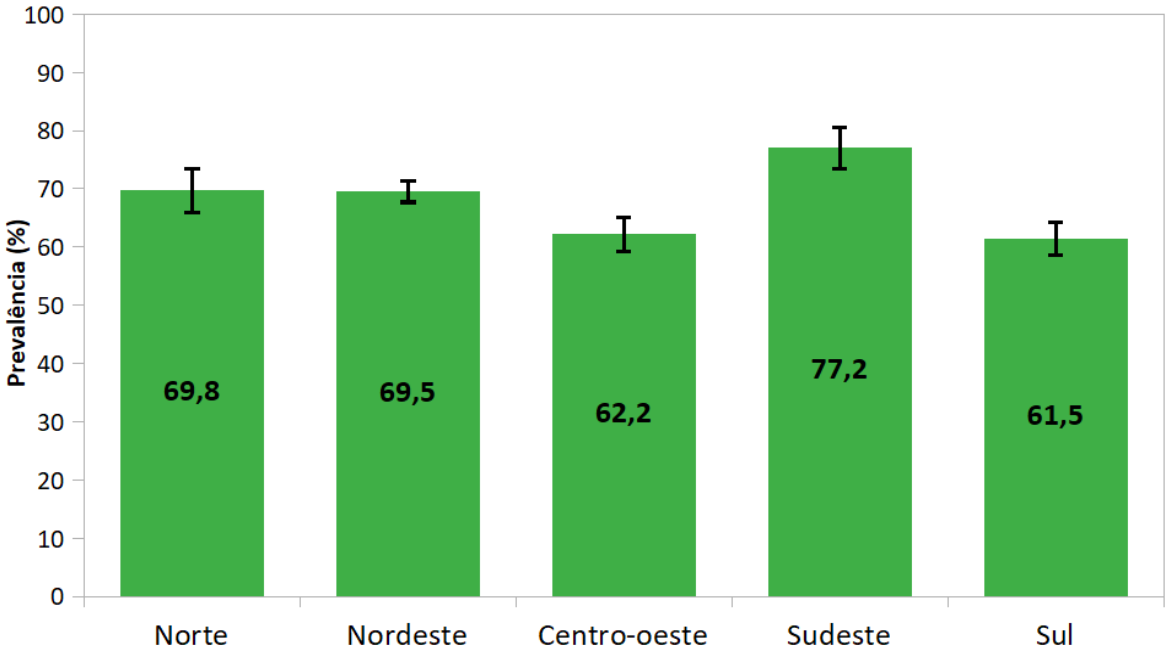


Figura 34. Proporção de trabalhadores(as) que referiram receber **treinamentos para emergências e prevenção de acidentes**, segundo região geográfica. As colunas representam as estimativas de prevalência e as barras de erro indicam os intervalos de confiança de 95% (IC95%). SESI, 2025.

Fonte: próprio autor.

Comunicação suficiente e adequada sobre prevenção de acidentes

Considerou-se comunicação suficiente e adequada sobre prevenção de acidentes quando o(a) trabalhador(a) referiu que no trabalho ocorrem conversas regulares ou debates sobre questões relacionadas à prevenção de acidentes e segurança no trabalho e que a empresa realiza ações suficientes

para informar sobre estes temas.

Promover conversas regulares e debates sobre questões relacionadas à prevenção de acidentes e segurança no trabalho, bem como realizar ações eficazes para informar os funcionários sobre esses temas, é uma prática de extrema importância para uma cultura prevencionista nas organizações[115]. Essa abordagem busca aumentar o conhecimento dos trabalhadores sobre os riscos e medidas preventivas no ambiente de trabalho, sendo um dos pilares essenciais para a prevenção de acidentes. Além disso, as discussões regulares sobre segurança permitem que os funcionários compreendam as políticas e procedimentos de segurança da empresa, assegurando que todos estejam alinhados com as diretrizes de prevenção de acidentes e reconheçam a segurança como um valor inegociável para a organização[117]. A inclusão dos(as) trabalhadores(a) em discussões sobre segurança no trabalho não apenas aumenta o engajamento, mas também cria um ambiente onde eles se sentem valorizados e parte ativa na criação de um local de trabalho seguro. Eles são frequentemente os mais familiarizados com os perigos em suas atividades diárias, contribuindo com informações valiosas sobre riscos e medidas preventivas. Promover debates regulares sobre segurança também é fundamental para construir uma cultura de segurança sólida na organização, onde todos os funcionários se envolvem na promoção da segurança, tornando-a parte intrínseca da cultura corporativa. Este investimento não apenas protege a saúde e a segurança dos funcionários, mas também contribui para o sucesso do negócio.

A proporção de trabalhadores que referiram comunicação suficiente e adequada sobre prevenção de acidentes foi de 65,6% (IC95%: 63,8-67,3), maior entre os homens (67,7%) que entre as mulheres (62,4%). A estimativa de prevalência deste indicador de cultura de segurança foi menor entre os(as) trabalhadores(as) com menos de 30 anos (60,3%) e entre aqueles que referiram não ter plano de saúde (60,9%) (Tabela 36).

Segundo a região geográfica, a maior estimativa de prevalência foi observada na região Sul (Figura 35). Além disso, essa prevalência foi baixa entre os(as) trabalhadores(as) vinculados a empresas de micro e pequeno porte (56,2%; IC95%: 52,5-59,9) quando comparados àqueles vinculados a empresas de médio e grande porte (68,4%; IC95%: 66,3-70,3).

Tabela 36. Proporção (IC95%) de trabalhadores(as) que referiram **comunicação suficiente e adequada sobre prevenção de acidentes**, segundo características demográficas. SESI, 2025.

Variável demográfica	Categoria	% (IC95%)
Sexo biológico	Masculino	**67,7** (65,7-69,7)
	Feminino	**62,4** (59,0-65,6)
Faixa etária (anos)	<30	**60,3** (57,5-63,0)
	30-39	**68,3** (64,9-71,4)
	40-59	**67,0** (63,7-70,1)
	≥60	**71,2** (66,2-75,8)
Situação conjugal	Solteiro(a)	**65,5** (62,7-68,2)
	Casado(a) ou vivendo com parceiro(a)	**65,6** (63,2-68,0)
	Viúvo(a), desquitado(a) ou divorciado(a)	**65,1** (60,2-69,7)
Escolaridade	Ensino fundamental incompleto	**65,0** (60,0-69,7)
	Ensino fundamental completo	**63,6** (58,1-68,8)
	Ensino médio ou técnico completo	**65,7** (63,2-68,1)
	Ensino superior incompleto	**65,4** (60,8-69,8)
	Ensino superior completo	**66,4** (62,1-70,4)
Número de filhos	Nenhum	**63,8** (60,8-66,6)
	1 filho(a)	**66,1** (62,7-69,3)
	2 a 3 filhos(as)	**66,4** (62,9-69,7)
	4 ou mais filhos(as)	**73,6** (69,7-77,2)
Acesso a plano de saúde	Não	**60,9** (58,4-63,2)
	Sim	**69,0** (66,5-71,4)
Tempo de trabalho na empresa	Menos de 1 ano	**61,6** (58,3-64,7)
	Entre 1 e 5 anos	**65,5** (62,5-68,3)
	Entre 5 e 10 anos	**73,5** (69,8-76,9)
	Mais de 10 anos	**65,9** (61,6-69,9)

Fonte: próprio autor.

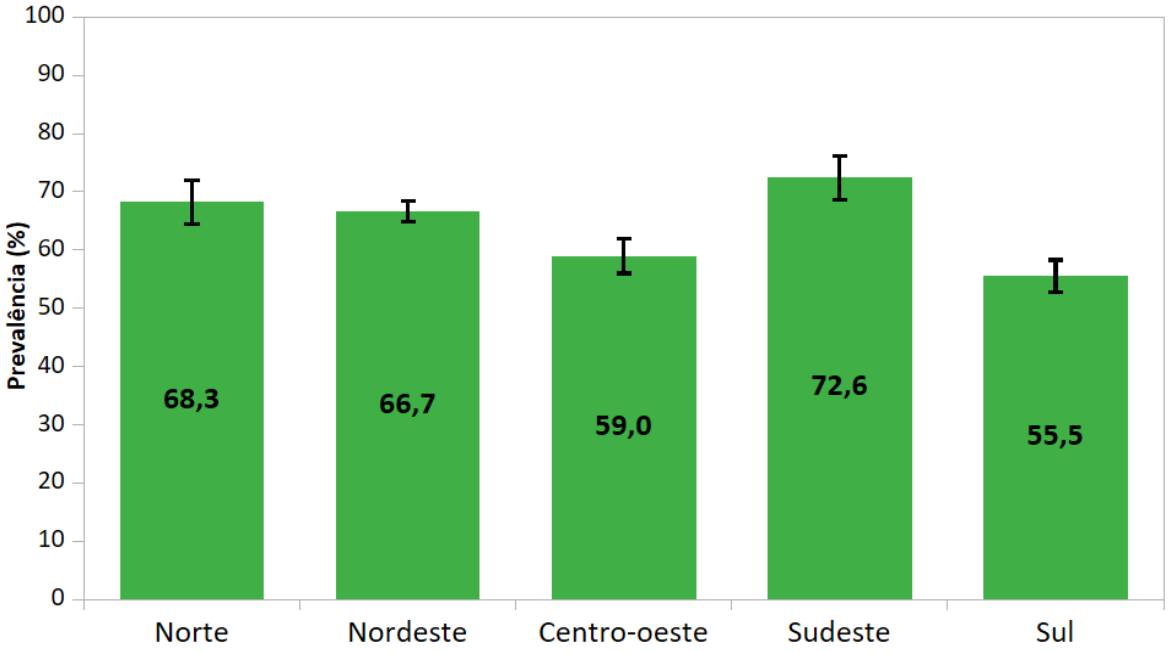


Figura 35. Proporção de trabalhadores(as) que referem **comunicação suficiente e adequada sobre prevenção de acidentes**, segundo região geográfica. As colunas representam as estimativas de prevalência e as barras de erro indicam os intervalos de confiança de 95% (IC95%). SESI, 2025. Fonte: próprio autor.

CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES

Os resultados consolidados neste relatório revelam um panorama complexo sobre a saúde e segurança da força de trabalho industrial. Embora o perfil demográfico aponte para uma população majoritariamente jovem e com níveis de escolaridade superiores à média nacional, observa-se uma prevalência preocupante de fatores de risco para Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT). A elevada prevalência de baixo consumo de frutas e hortaliças, assim como de inatividade física no lazer e de comportamento sedentário indicam a necessidade e a urgência de intervenções apropriadas, efetivas e escaláveis, em especial ao considerar que aproximadamente um em cada cinco trabalhadores(as) são obesos.

Soma-se a esses indicadores a elevada prevalência de consumo episódico pesado de bebidas alcoólicas observada no estudo (34,2%). Uma estimativa que é aproximadamente 68% maior que o observado em adultos brasileiros (20,4%), em 2024, pelo Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel)[118].

Em relação aos indicadores de bem-estar mental, aproximadamente um em cada cinco trabalhadores(as) referiram elevados níveis de estresse e dificuldade em relaxar e usufruir de atividades de lazer. Apesar de não se poder negligenciar os demais fatores analisados, estes dois parecem ser prioridades do ponto de vista do planejamento de intervenções. Ações para melhorar a capacidade de manejo do estresse e o melhor uso do tempo de lazer, especialmente entre os trabalhadores de menor escolaridade são urgentes. No âmbito organizacional, orienta-se o fortalecimento das competências de liderança para promover uma comunicação aberta e um ambiente psicologicamente seguro. Importante destacar que a própria promoção de um lazer mais ativo e saudável pode ser uma estratégia para apoiar os(as) trabalhadores(as) a lidar com fatores de estresse psicossocial.

Os indicadores de morbidade revelaram uma prevalência elevada de doenças crônicas não transmissíveis, sendo que a obesidade e os problemas crônicos de coluna se destacaram como as condições mais frequentes, afetando aproximadamente um em cada cinco industriários(as). As estimativas de prevalência dos indicadores de morbidade foram, de modo geral, mais elevadas nos grupos de maior faixa etária. Estudos subsequentes são necessários para identificar se as prevalências observadas exigem a priorização de linhas de cuidado e ou a promoção de campanhas

para ampliar a detecção precoce, garantindo que o diagnóstico inicial dessas condições interrompa a progressão de doenças que levam ao absenteísmo e à incapacidade precoce.

Trabalhadores com menor escolaridade apresentaram indicadores de autocuidado e percepção de saúde mais frágeis, o que sugere uma barreira informacional e, possivelmente, de acesso a serviços de saúde. Tais disparidades reforçam que as estratégias de promoção da saúde devem ser pensadas à luz das demandas e características específicas desse subgrupo de trabalhadores. Práticas e atitudes relacionadas ao autocuidado, assim como a percepção de saúde, são fatores que sofrem influência de inúmeras variáveis. Industriários(as) com menor escolaridade e, possivelmente, aqueles que enfrentam barreiras para acessar serviços de saúde apresentaram percepções de autocuidado mais frágeis. O autocuidado é um constructo que reflete o compromisso individual com a própria saúde, incluindo a adesão a tratamentos e o controle de parâmetros como glicemia e pressão arterial. Observou-se que uma parcela considerável de trabalhadores que lidam com condições crônicas não realiza atividades de autocuidado de forma adequada, o que compromete o controle dessas enfermidades.

Além disso, fatores como inatividade física, excesso de peso e elevado nível de estresse estão diretamente associados a uma percepção de saúde negativa[23,96], a qual funciona como um preditor de mortalidade precoce e maior absenteísmo no trabalho[99]. Para fortalecer o autocuidado e melhorar a percepção de saúde, recomenda-se a implementação de campanhas direcionadas ao aumento da literacia em saúde. Por fim, orienta-se que as empresas integrem o apoio ao autocuidado na cultura organizacional, visando não apenas a redução de custos assistenciais, mas a contribuição para elevação da longevidade saudável.

No que tange à cultura de segurança, a percepção positiva referida por aproximadamente sete em cada dez trabalhadores é um resultado positivo, embora sinalize que ainda é possível avançar na promoção da cultura de segurança nas empresas do setor, em especial nas empresas de menor porte (micro e pequenas empresas). Apesar de grande proporção dos industriários referirem uma percepção de que “segurança e prevenção de acidentes são importantes para a empresa”, notou-se que há espaço para implementação de intervenções, em especial no tocante à realização de “treinamentos para emergências e prevenção de acidentes” e na melhoria das ações de comunicação para prevenção de acidentes.

Além disso, no âmbito da saúde ocupacional, orienta-se o fortalecimento contínuo das competências de liderança voltadas para a segurança do trabalho, com ênfase em processos de mentoria para novos colaboradores. Os indicadores de cultura de segurança sinalizaram a necessidade de padronização rigorosa dos protocolos de treinamento e uma supervisão mais ativa nos postos de trabalho com maior rotatividade. A continuidade do monitoramento sistemático por meio do Vigindústria será fundamental para validar a efetividade das intervenções em andamento e, por conseguinte, da eventual necessidade de reorientá-las, garantindo a sustentabilidade e a competitividade da indústria brasileira no longo prazo.

Diante do cenário exposto, recomenda-se a implementação de programas de gestão de saúde populacional focados na modificação de comportamentos sedentários e no manejo de fatores de risco metabólicos. É imperativo que as indústrias adotem modelos de intervenção baseados em evidências, sendo que a utilização dos dados do sistema ASSTI pode auxiliar na customização das ações de acordo com as necessidades específicas de cada região e dos diferentes setores de produção industrial. Programas de incentivo à adoção de comportamentos saudáveis e campanhas de promoção da literacia em saúde devem ser priorizados como estratégia de redução de absenteísmo e aumento da longevidade laboral saudável.

A fim de lidar com o desafio que representam, na atualidade, as Doenças e Agravos Não Transmissíveis (DANT) o Ministério da Saúde elaborou o Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças e Agravos Não Transmissíveis no Brasil (Plano DANT 2021–2030), criado pelo para orientar e fortalecer as políticas públicas de promoção da saúde, vigilância e atenção integral no Sistema Único de Saúde (SUS)[119]. A realização desse estudo é a concretização de uma ação intersetorial prevista nas ações estratégicas do referido plano, o qual prevê ainda um conjunto de ações estratégicas para promoção da saúde, prevenção, produção do cuidado e assistência para enfrentamento dos fatores de risco para as doenças e agravos não transmissíveis.

Além da consulta e disseminação do Plano DANT 2021-2030, recomenda-se também ampla divulgação de outras importantes diretrizes, como o Guia de Atividade Física para a População Brasileira[120] e o Guia Alimentar para a População Brasileira[121]. Esses documentos trazem importantes contribuições para profissionais de saúde e para a população em geral, indicando meios para promoção da atividade física e alimentação saudável em diferentes contextos. Outra importante fonte de consulta são os Cadernos de Atenção Básica do Ministério da Saúde, os quais

apresentam orientações importantes para organização do cuidado às pessoas com condições crônicas (e.g., obesidade, hipertensão e diabetes).

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA (SESI). Departamento Nacional. **Estudo SESI: perfil epidemiológico de fatores de risco para doenças não transmissíveis em trabalhadores da indústria do Brasil**. Brasília: SESI/DN, 2007.

2. SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA (SESI). Departamento Nacional. **Estilo de Vida e Hábitos de Lazer dos Trabalhadores das Indústrias Brasileiras: relatório geral**. Org. Markus V. Nahas [et al.]. Brasília: SESI/DN, 2009.

3. CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA (CNI). **Perfil da Indústria Brasileira - Mercado de Trabalho**. [S. l.], 2024. Disponível em: https://industriabrasileira.portaldaindustria.com.br/grafico/total/mercado-trabalho/#/industria-total. Acesso em: 21 mar. 2026.

4. SMARTLAB. **Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho**. [S. l.], [202-?]. Disponível em: https://smartlabbr.org/sst/localidade/0?dimensao=prevalenciaAcidentes. Acesso em: 24 mar. 2023.

5. HÄMÄLÄINEN, P.; TAKALA, J.; KIAT, T. B. **Global Estimates of Occupational Accidents and Work-related Illnesses 2017**. Singapore: Workplace Safety and Health Institute, 2017.

6. MALTA, D. C. *et al*. Trends in mortality due to non-communicable diseases in the Brazilian adult population: national and subnational estimates and projections for 2030. **Popul Health Metr**, v. 18, n. 16, Suppl 1, 30 set. 2020.

7. RASMUSSEN, B.; SWEENY, K.; SHEEHAN, P. **Economic Costs of Absenteeism, Presenteeism and Early Retirement Due to Ill Health: A Focus on Brazil**. Report to the Brazil-U.S. Business Council. Melbourne: Victoria University, 2015.

8. SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA (SESI). Departamento Nacional. **Sistema ASSTI: avaliação de saúde e segurança em trabalhadores da indústria: caderno técnico**. Brasília: SESI/DN, 2023. 107 p.

9. PANTELI, D. et al. Artificial intelligence in public health: promises, challenges, and an agenda for policy makers and public health institutions. The Lancet Public Health, v. 10, e428-e432, 2025.

10. KRUEGER, R. A.; CASEY, M. A. Focus groups: a practical guide for applied research. 3. ed. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2000.

11. HILL, Manuela Magalhães; HILL, Andrew. Investigação por questionário. 2. ed. Lisboa: Edições Sílabo, 2002.

12. HAYNES, S. N.; RICHARD, D. C. S.; KUBANY, E. S. Content validity in psychological assessment: a functional approach to concepts and methods. Psychological Assessment, v. 7, n. 3, p. 238-247, 1995.

13. ALEXANDRE, N. M. C.; COLUCI, M. Z. O. Validade de conteúdo nos processos de construção e adaptação de instrumentos de medidas. Ciência & Saúde Coletiva, v. 16, n. 7, p. 3061-3068, 2011. DOI: https://doi.org/10.1590/S1413-81232011000800006.

14. RANGANATHAN, P.; CADUFF, C. Designing and validating a research questionnaire - Part 1. Perspectives in Clinical Research, v. 14, n. 3, p. 152-155, 2023.

15. RANGANATHAN, P.; CADUFF, C.; FRAMPTON, C. M. Designing and validating a research questionnaire - Part 2. Perspectives in Clinical Research, v. 15, n. 1, p. 42-45, 2024.

16. INDU, P. V. et al. Criterion validity, construct validity, and factor analysis: an introductory overview. Indian Journal of Psychiatry, [S. l.], v. 67, n. 9, p. 916-921, set. 2025.

17. BYRT, T.; BISHOP, J.; CARLIN, J. B. Bias, prevalence and kappa. Journal of Clinical Epidemiology, [S. l.], v. 46, n. 5, p. 423-429, maio 1993. DOI: https://doi.org/10.1016/0895-4356(93)90018-V.

18. LANDIS, J. R.; KOCH, G. G. The measurement of observer agreement for categorical data. Biometrics, v. 33, n. 1, p. 159-174, 1977.

19. WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Physical status: the use of and interpretation of anthropometry: report of a WHO expert committee**. Geneva: World Health Organization, 1995. 452 p. (WHO Technical Report Series, 854). Disponível em: https://iris.who.int/handle/10665/37003. Acesso em: 25 mar. 2026.

20. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **PNAD Contínua: educação 2023**. Rio de Janeiro: IBGE, 2024. Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv102068_informativo.pdf. Acesso em: 21 mar. 2026.

21. UMANE. **Observatório de Saúde Pública: cobertura de planos de saúde**. São Paulo: Umane, 2024. Disponível em: https://umane.org.br/observatorio-de-saude-publica/. Acesso em: 21 mar. 2026.

22. BRASIL. Ministério da Saúde. **Nota Técnica Conjunta nº 263/2024-SVSA/SAPS/SAES/MS: o uso do álcool no Brasil como um problema de saúde pública**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2024.

23. BARROS, M. V. G.; NAHAS, M. V. Comportamentos de risco, auto-avaliação do nível de saúde e percepção de estresse entre trabalhadores da indústria. **Rev. Saúde Pública**, v. 35, n. 6, p. 554-563, dez. 2001.

24. ROSSOW, I. *et al*. Associations between heavy episodic drinking and alcohol related injuries: a case control study. **BMC Public Health**, v. 13, n. 1076, 2013.

25. BRASIL. Ministério da Saúde. **Guia alimentar para a população brasileira**. 2. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2014. 156 p.

26. DEVIRGILIIS, C. *et al*. Effect of Fruit and Vegetable Consumption on Human Health: An Update of the Literature. **Foods**, v. 13, n. 19, p. 3149, 2 out. 2024.

27. KABTHYMER, R. H. *et al*. The association of sweetened beverage intake with risk of type 2 diabetes in an Australian population: A longitudinal study. **Diabetes & Metabolism**, v. 51, n. 6, 101665, 2025.

28. DIAZ, C. *et al*. Artificially Sweetened Beverages and Health Outcomes: An Umbrella Review. **Adv. Nutr.**, v. 14, n. 4, p. 710-717, jul. 2023.

29. RAMÍREZ VARELA, A. *et al*. Low global physical activity despite two decades of policy progress. **Nature Health**, v. 1, n. 3, p. 338-354, 2026.

30. FOSTER, H. M. E. *et al*. Understanding How Much TV is Too Much: A Nonlinear Analysis of the Association Between Television Viewing Time and Adverse Health Outcomes. **Mayo Clin. Proc.**, v. 95, n. 11, p. 2429-2441, nov. 2020.

31. SAUNDERS, T. J. *et al*. Sedentary behaviour and health in adults: an overview of systematic reviews. **Appl. Physiol. Nutr. Metab.**, v. 45, n. 10, p. S197-S217, out. 2020.

32. O'CONNOR, D. B.; GARTLAND, N.; O'CONNOR, R. C. Stress, cortisol and suicide risk. **Int. Rev. Neurobiol.**, v. 152, p. 101-130, 2020.

33. KIVIMÄKI, M.; STEPTOE, A. Effects of stress on the development and progression of cardiovascular disease. **Nat. Rev. Cardiol.**, v. 15, n. 4, p. 215-229, abr. 2018.

34. EBONG, I. A. *et al*. The Role of Psychosocial Stress on Cardiovascular Disease in Women: JACC State-of-the-Art Review. **J. Am. Coll. Cardiol.**, v. 84, n. 3, p. 298-314, jul. 2024.

35. TAN, X.; AN, Y.; CHEN, C. Avoidant coping as mediator of the relationship between rumination and mental health among family caregivers of Chinese breast cancer patients. **Eur. J. Cancer Care**, v. 31, n. 1, e13523, jan. 2022.

36. IOVOLI, F.; RUBEL, J. A.; STEINBRENNER, T. Interpersonal Problems and Their Mental Health Correlates: A Meta-Analytic Review. **J. Clin. Psychol.**, v. 81, n. 11, p. 1046-1056, nov. 2025.

37. PETROV, K. K. *et al*. Is poor self-rated sleep quality associated with elevated systemic inflammation in healthy older adults? **Mechanisms of Ageing and Development**, 111388, 2020.

38. WINSPER, C.; TANG, N. K. Y. Linkages between insomnia and suicidality: Prospective associations, high-risk subgroups and possible psychological mechanisms. **Int. Rev. Psych.**, v. 26, p. 189–204, 2014.

39. FANCOURT, D. *et al*. How leisure activities affect health: a narrative review and multi-level theoretical framework of mechanisms of action. **Lancet Psychiatry**, v. 8, n. 4, p. 329-339, abr. 2021.

40. PAYNE, P.; WATTCHOW, B. Phenomenological deconstruction, slow pedagogy and the corporeal turn in wild environmental/outdoor education. **Canadian Journal of Environmental Education**, v. 14, p. 15-32, 2009.

41. GOODMAN, A.; MAZEROLLE, S. M.; EASON, C. M. Organizational Infrastructure in the Collegiate Athletic Training Setting, Part II: Benefits of and Barriers in the Athletics Model. **Journal of Athletic Training**, v. 52, n. 1, p. 23–34, 2017.

42. LLOYD, K. M.; AULD, C. J. The role of leisure in determining quality of life: issues of content and measurement. **Social Indicators Research**, v. 57, n. 1, p. 43-71, 2002.

43. KELLOWAY, E. K.; BARLING, J. Job characteristics, role stress and mental health. **Journal of Occupational Psychology**, v. 64, p. 291-304, 1991.

44. LEE, Y. W. *et al*. Predicting quality of work life on nurses' intention to leave. **J. Nurs. Scholarsh.**, v. 45, n. 2, p. 160-168, 2013.

45. BURGARD, S. A.; LIN, K. Y. Bad Jobs, Bad Health? How Work and Working Conditions Contribute to Health Disparities. **Am. Behav. Sci.**, v. 57, n. 8, 2013.

46. OBESITY. Guidelines (2013) for managing overweight and obesity in adults. **Obesity (Silver Spring)**, v. 22, Suppl 2, p. S40, 2014.

47. RABACOW, F. M.; AZEREDO, C. M.; REZENDE, L. F. M. Deaths attributable to high body mass in Brazil. **Prev. Chron. Dis.**, v. 16, n. 10, 190143, 2019.

48. NILSON, E. A. F. *et al*. The projected burden of non-communicable diseases attributable to overweight in Brazil from 2021 to 2030. **Sci Rep**, v. 12, n. 1, 22483, 28 dez. 2022.

49. KOCHANEK, P. M. *et al*. Guidelines for the acute medical management of severe traumatic brain Injury in Infants, children, and adolescents. 2. ed. **Pediatr. Crit. Care Med.**, v. 13, n. 1, p. S1-S82, 2012.

50. SOCIEDADE BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO. 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial: Capítulo 3 - Avaliação Clínica e Complementar. **Arquivos Brasileiros de Cardiologia**, v. 107, n. 3, Supl. 3, 2016.

51. WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). **WHO Global report on diabetes**. Geneva: WHO, 2016.

52. ISMAIL, L.; MATERWALA, H.; AL KAABI, J. Association of risk factors with type 2 diabetes: A systematic review. **Comput Struct Biotechnol J**, v. 19, p. 1759-1785, 2021.

53. HERQUELOT, E. *et al*. Impact of diabetes on work cessation: data from the GAZEL cohort study. **Diabetes Care**, v. 34, p. 1344 – 1349, 2011.

54. VIJAN, S.; HAYWARD, R. A.; LANGA, K. M. The impact of diabetes on workforce participation: results from a national household sample. **Health Serv. Res.**, v. 39, n. 6, Pt 1, p. 1653-1669, 2004.

55. TUNCELI, K. *et al*. The impact of diabetes on employment and work productivity. **Diabetes Care**, v. 28, n. 11, p. 2662-2667, 2005.

56. HIRD, T. R. *et al*. The impact of diabetes on productivity in China. **Diabetologia**, v. 62, p. 1195–1203, 2019.

57. MAGLIANO, D. J. *et al*. The Productivity Burden of Diabetes at a Population Level. **Diabetes Care**, v. 41, n. 5, p. 979 – 984, 2018.

58. BENJAMIN, E. J. *et al*. Heart disease and stroke statistics - 2017 update: a report from the American Heart Association. **Circulation**, v. 135, p. e1 – e458, 2017.

59. TSAI, J. C. *et al*. The beneficial effect of regular endurance exercise training on blood pressure and quality of life in patients with hypertension. **Clin. Exp. Hypertens.**, v. 26, n. 3, p. 255-265, 2004.

60. JAMA. Executive Summary of The Third Report of The National Cholesterol Education Program (NCEP). **JAMA**, v. 285, n. 19, p. 2486-2497, 2001.

61. GUO, J. *et al*. Adherence to lifestyle advice and its related cardiovascular disease risk among US adults with high cholesterol. **Clin. Nutr. ESPEN**, v. 51, p. 267-273, 2022.

62. BARONE, G. B. *et al*. Physical Activity as a Critical Component of First-Line Treatment for Elevated Blood Pressure or Cholesterol: A Scientific Statement From the American Heart Association. **Hypertension**, v. 78, n. 2, p. e26-e37, 2021.

63. SAINI, V.; GUADA, L.; YAVAGAL, D. R. Global Epidemiology of Stroke and Access to Acute Ischemic Stroke Interventions. **Neurology**, v. 97, n. 20 Suppl 2, p. S6-S16, 2021.

64. HUANG, X. *et al*. Coagulation and Fibrinolytic Activity of Tenecteplase and Alteplase in Acute Ischemic Stroke. **Stroke**, v. 46, n. 12, p. 3543 – 3546, 2015.

65. STRILCIUC, S. *et al*. The economic burden of stroke: a systematic review of cost of illness studies. **J. Med. Life**, v. 14, n. 5, p. 606-619, 2021.

66. HOLDEN, L. *et al*. Health-related productivity losses increase when the health condition is co-morbid with psychological distress. **BMC Public Health**, v. 11, n. 417, 2011.

67. LIMA, M. G. *et al*. Associação do autorrelato de problemas no sono com morbidades e multimorbidades segundo sexo: Pesquisa Nacional de Saúde 2019. **Epidemiol. Serv. Saúde**, v. 31, e2021386, 2022.

68. OEMRAWSINGH, A. *et al*. Patient-Reported Morbidity Instruments: A Systematic Review. **Value Health**, v. 23, n. 6, p. 791-811, jun. 2020.

69. FRANCISCO, P. M. S. B.; BACURAU, A. G. M.; ASSUMPÇÃO, D. Prevalência de doenças crônicas e posse de plano de saúde em idosos: comparação dos dados da Pesquisa Nacional de Saúde de 2013 e 2019. **Cad. Saúde Pública**, v. 38, n. 8, e00040522, 2022.

70. SOUSA, N. F. S. *et al*. Association of major depressive disorder with chronic diseases and multimorbidity in Brazilian adults: 2019 National Health Survey. **Rev. bras. epidemiol.**, v. 24, e210015, 2021.

71. MALTA, D. C. *et al*. A vigilância e o monitoramento das principais doenças crônicas não transmissíveis no Brasil - Pesquisa Nacional de Saúde, 2013. **Rev. bras. epidemiol.**, v. 18, p. 03-16, 2015.

72. DELPINO, F. M. *et al*. Occurrence and inequalities by education in multimorbidity in Brazilian adults between 2013 and 2019. **Rev. bras. epidemiol.**, v. 24, e210016, 2021.

73. FORNO, E. *et al*. Asthma in the Americas: An Update. **Ann. Am. Thorac. Soc.**, v. 19, n. 4, p. 525-535, 2022.

74. TARLO, S. M. *et al*. Diagnosis and management of work-related asthma: American College Of Chest Physicians Consensus Statement. **Chest**, v. 134, n. 3 Suppl, p. 1S-41S, set. 2008.

75. BALJET, E. *et al*. Chronic comorbid conditions and asthma exacerbation occurrence in a general population sample. **NPJ Prim. Care Respir. Med.**, v. 33, n. 1, p. 29, 2023.

76. NURMAGAMBETOV, T.; KUWAHARA, R.; GARBE, P. The Economic Burden of Asthma in the United States, 2008-2013. **Ann. Am. Thorac. Soc.**, v. 15, n. 3, p. 348-356, 2018.

77. MALHI, G. S.; MANN, J. J. Depression. **Lancet**, v. 392, n. 10161, p. 2299-2312, 24 nov. 2018.

78. LIU, Q. *et al*. Changes in the global burden of depression from 1990 to 2017: Findings from the Global Burden of Disease study. **J. Psychiatr. Res.**, v. 126, p. 134-140, 2020.

79. BURTON, W. N. *et al*. The association of medical conditions and presenteeism. **J. Occup. Environ. Med.**, v. 46, n. 6 Suppl, p. S38-45, 2004.

80. HENDERSON, J. **Health Economics and Policy**. 3. ed. Boston: Cengage Learning, 2011.

81. EVANS-LACKO, S. *et al*. The mental health consequences of the recession. **PLoS One**, v. 8, n. 7, e69792, 2013.

82. SUNG, H. *et al*. Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide. **CA Cancer J. Clin.**, v. 71, n. 3, p. 209-249, 2021.

83. ORTEGA-ORTEGA, M. *et al*. Paid and unpaid productivity losses due to premature mortality from cancer in Europe in 2018. **Int. J. Cancer**, v. 150, n. 4, p. 580-593, 2022.

84. NAYAK, M. G. *et al*. Quality of Life among Cancer Patients. **Indian J. Palliat. Care**, v. 23, n. 4, p. 445-450, 2017.

85. OLIVEIRA, M. M. *et al*. Problema crônico de coluna e diagnóstico de distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho (Dort) autorreferidos no Brasil: pesquisa nacional de saúde, 2013. **Epidemiol. Serv. Saúde**, v. 24, n. 2, p. 287-296, 2015.

86. CAMARGOS, M. C. S. Estimativas de expectativa de vida com doenças crônicas de coluna no Brasil. **Ciênc. Saúde Coletiva**, v. 19, n. 6, p. 1803-1811, 2014.

87. MALTA, D. C. *et al*. Doenças crônicas não transmissíveis e a utilização de serviços de saúde: análise da Pesquisa Nacional de Saúde no Brasil. **Rev. Saúde Pública**, v. 51, n. 1, 4s, 2017.

88. ROMERO, D. E. *et al*. Prevalência, fatores associados e limitações relacionados ao problema crônico de coluna entre adultos e idosos no Brasil. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 34, n. 2, e00012817, 2018.

89. WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). **Self-care among patients with cardiovascular disease, diabetes or respiratory disease**. PEN protocol 5. Geneva: WHO, 2020.

90. HEARN, J. *et al*. Self-management of non-communicable diseases in low- and middle-income countries: A scoping review. **PLOS ONE**, v. 14, n. 7, e0219141, 2019.

91. CHO, S. E.; KWON, M.; KIM, S. A. Influence of Diabetes Knowledge, Self-Stigma, and Self-Care Behavior on Quality of Life in Patients with Diabetes. **Healthcare (Basel)**, v. 10, n. 10, 1983, 2022.

92. MARTÍNEZ, N.; CONNELLY, C. D.; PÉREZ, A. Self-care: A concept analysis. **Int. J. Nurs. Sci.**, v. 8, n. 4, p. 418-425, 2021.

93. HABIBI, H. *et al*. Self-Care Practices and Related Factors in Patients with Multiple Sclerosis (MS) Based on the Health Belief Model. **J. Caring Sci.**, v. 10, n. 2, p. 77-83, 2021.

94. WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). **WHO Guideline on Self-Care Interventions for Health and Well-Being**. Geneva: WHO, 2021.

95. VEROMAA, V. *et al*. Self-rated health as an indicator of ideal cardiovascular health among working-aged women. **Scand. J. Prim. Health Care**, v. 35, n. 4, p. 322-328, 2017.

96. JYLHÄ, M. What is self-rated health and why does it predict mortality? Towards a unified conceptual model. **Soc. Sci. Med.**, v. 69, p. 307–316, 2009.

97. PALLADINO, R. *et al*. Associations between multimorbidity, healthcare utilisation and health status: evidence from 16 European countries. **Age Ageing**, v. 45, n. 3, p. 431-435, 2016.

98. SANTOS, M. N.; MARQUES, A. C.; CARRICONDE, C. Condições de saúde, estilo de vida e características de trabalho de professores de uma cidade do Sul do Brasil. **Ciênc. Saúde Coletiva**, v. 18, n. 3, p. 837-846, 2013.

99. ERIKSSON, H. G. *et al*. Sickness absence and self-reported health a population-based study of 43,600 individuals in central Sweden. **BMC Public Health**, v. 8, n. 426, 2008.

100. WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). **Oral health surveys: basic methods**. 5. ed. Geneva: WHO, 2013. 137 p.

101. BENYAMINI, Y.; LEVENTHAL, H.; LEVENTHAL, E. A. Self-rated oral health as an independent predictor of self-rated general health, self-esteem and life satisfaction. **Soc. Sci. Med.**, v. 59, n. 5, p. 1109-1116, set. 2004.

102. KIMBLE, R. *et al*. Association between oral health markers and decline in muscle strength and physical performance in later life. **Lancet Healthy Longev.**, v. 3, n. 11, p. e777-e788, 2022.

103. VASILIOU, A.; SHANKARDASS, K.; NISENBAUM, R. Current stress and poor oral health. **BMC Oral Health**, v. 16, n. 1, p. 88, 2016.

104. WAGNER, A.; SCHÖNE, L.; RIEGER, M. A. Determinants of Occupational Safety Culture in Hospitals and other Workplaces—Results from an Integrative Literature Review. **Int. J. Environ. Res. Public Health**, v. 17, n. 18, 6588, 2020.

105. VARON, U.; MATTILA, M. The safety climate and its relationship to safety practices, safety of the work environment and occupational accidents in eight wood processing plants. **Accident Analysis and Prevention**, v. 32, p. 761–769, 2000.

106. HAHN, S. E.; MURPHY, L. R. A short scale for measuring safety climate. **Safety Science**, v. 46, p. 1047–1066, 2008.

107. KATZ, A. S. *et al*. Perceived Workplace Health and Safety Climates: Associations With Worker Outcomes and Productivity. **American Journal of Preventive Medicine**, v. 57, n. 4, p. 487 – 494, 2019.

108. RAMOS, A. K.; MCGINLEY, M.; CARLO, G. The relations of workplace safety, perceived occupational stress, and adjustment among Latino/a immigrant cattle feedyard workers in the United States. **Safety Science**, v. 139, 2021.

109. NIELSEN, M. B. *et al*. Using the Job Demands-Resources model to investigate risk perception, safety climate and job satisfaction in safety critical organizations. **Scand. J. Psychol.**, v. 52, p. 465–478, 2011.

110. WEI, S.; KUO, Y. The relationship among safety leadership, risk perception, safety culture, and safety performance. **Frontiers in Psychology**, v. 14, 1000331, 2023.

111. OAH, S.; NA, R.; MOON, K. The Influence of Safety Climate, Safety Leadership, Workload, and Accident Experiences on Risk Perception. **Safety and Health at Work**, v. 9, n. 4, p. 427-433, 2018.

112. SCHWATKA, N. V. *et al*. A training intervention to improve frontline construction leaders' safety leadership practices and overall jobsite safety climate. **J. Safety Res.**, v. 70, p. 253-262, 2019.

113. SINELNIKOV, S.; BIXLER, E. A.; KOLOSH, A. Effectiveness of safety training interventions for supervisors: A systematic review and narrative synthesis. **American Journal of Industrial Medicine**, 2020.

114. LIN, J.; CAI, Y.; LI, Q. Development of Safety Training in Construction: Literature Review, Scientometric Analysis, and Meta-Analysis. **Journal of Management in Engineering**, v. 39, n. 6, 5445, 2023.

115. AL-MEKHLAFI, A. A. *et al*. Moderating effect of safety culture on the association inter work schedule and driving performance. **Heliyon**, v. 8, n. 11, e11289, 2022.

116. GERSHON, R. R. *et al*. Hospital safety climate and its relationship with safe work practices and workplace exposure incidents. **Am. J. Infect. Control**, v. 28, n. 3, p. 211-221, 2000.

117. WAGNER, A.; SCHÖNE, L.; RIEGER, M. A. Determinants of Occupational Safety Culture in Hospitals and other Workplaces—Results from an Integrative Literature Review. **Int. J. Environ. Res. Public Health**, v. 17, 6588, 2020.

118. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Departamento de Análise Epidemiológica e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis. Vigitel Brasil 2006-2024: vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico: estimativas sobre frequência e distribuição sociodemográfica de fatores de risco e proteção para doenças crônicas nas capitais dos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal entre 2006 e 2024. Brasília: Ministério da Saúde, 2025. 211 p.

119. BRASIL. Ministério da Saúde. Plano de ações estratégicas para o enfrentamento das doenças crônicas e agravos não transmissíveis no Brasil, 2021-2030. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2021. Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/cartilhas/2021/09-plano-de-dant-2022_2030.pdf. Acesso em: 25 ago. 2026.

120. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Departamento de Promoção da Saúde. Guia de atividade física para a população brasileira. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2021. Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/guias-e-manuais/2021/guia-de-atividade-fisica-para-a-populacao-brasileira.pdf. Acesso em: 25 ago. 2026.

121. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Guia alimentar para a população brasileira. 2. ed. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2014. 156 p. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_alimentar_populacao_brasileira_2ed.pdf. Acesso em: 25 ago. 2026.

ANEXO I

INSTRUMENTO UTILIZADO PARA COLETA DE DADOS

FATORES DEMOGRÁFICOS
Qual é o seu sexo biológico?
[ ] Masculino [ ] Feminino
Qual a sua identidade de gênero?
[ ] Homem Cis [ ] Mulher Cis [ ] Homem Trans [ ] Mulher Trans [ ] Não binário [ ] Não me senti representado nas opções [ ] Não sei [ ] Prefiro não responder
Qual é a sua idade?
_____
Qual das opções melhor descreve a sua situação conjugal, o seu estado civil?
[ ] Solteiro(a) [ ] Casado(a) ou vivendo com parceiro(a) [ ] Viúvo(a), desquitado(a) ou divorciado(a)
Você estudou até que série?
[ ] Não concluí a 8ª série (tenho o ensino fundamental incompleto) [ ] Concluí a 8ª série (tenho o ensino fundamental completo) [ ] Concluí a 3ª série do segundo grau (tenho o ensino médio ou técnico completo) [ ] Iniciei um curso numa faculdade ou universidade, mas ainda não conclui [ ] Concluí um curso numa faculdade ou universidade (tenho o ensino superior completo)
Quantos filhos você tem?
[ ] Não tenho filhos [ ] 1 filho(a) [ ] 2 filhos(as) [ ] 3 filhos(as) [ ] Tenho 4 ou mais filhos(as)
Você tem algum plano de saúde (médico ou odontológico) ou convênio médico?
[ ] Não [ ] Sim, eu mesmo pago [ ] Sim, a empresa paga uma parte do valor do plano ou convênio [ ] Sim, a empresa paga integralmente o valor do plano ou convênio
Há quantos anos você trabalha nesta empresa?
[ ] Há menos de 1 ano [ ] Entre 1 e 2 anos [ ] Entre 2 e 5 anos [ ] Entre 5 e 10 anos [ ] Mais de 10 anos

No último ano, você participou de atividades de promoção da saúde e segurança no trabalho que foram oferecidas aos trabalhadores desta empresa?
[ ] Não participei [ ] Participei
Qual foi o motivo de você não ter participado desse tipo de atividade?
[ ] Essas atividades não foram oferecidas [ ] Não tive interesse nas atividades que foram oferecidas [ ] Não tive tempo [ ] Não fui liberado pelo meu Supervisor/Chefe imediato
Com que frequência você participou das atividades oferecidas?
[ ] Raramente, com frequência muito baixa (menos de 1 vez por mês) [ ] Às vezes, com pouca frequência (1-2 vezes por mês) [ ] Participei com frequência (1-2 vezes por semana) [ ] Participei com muita frequência (3-5 vezes por semana)

FATORES COMPORTAMENTAIS
Você fuma?
[ ] NÃO fumo atualmente e nunca fumei [ ] Parei de fumar há mais de 2 anos [ ] Parei de fumar há menos de 2 anos [ ] FUMO menos de 10 cigarros por dia [ ] FUMO de 10 a 20 cigarros por dia [ ] FUMO mais de 20 cigarros por dia
Se homem: Nos últimos 30 dias, você tomou cinco (5) doses ou mais de bebidas alcoólicas numa mesma ocasião? Se mulher: Nos últimos 30 dias, você tomou quatro (4) doses ou mais de bebidas alcoólicas numa mesma ocasião? Atenção: considere que 1 dose = 1/2 garrafa de cerveja, 1 latinha de cerveja, 1 copo de vinho ou 1 dose comercial de qualquer bebida destilada como cachaça, vodca, uísque ou conhaque.
[ ] Não [ ] Sim
Durante uma semana normal, com que frequência você come frutas ou toma suco de frutas natural? Atenção: não considerar o consumo de sucos artificiais
[ ] Nunca [ ] 1 a 3 vezes por semana [ ] 4 a 6 vezes por semana [ ] Diariamente, 1 vez por dia [ ] Diariamente, 2 ou mais vezes por dia

Durante uma semana normal, com que frequência você come verduras, hortaliças, saladas verdes ou legumes crus ou cozidos? Atenção: não considerar o consumo de batata, mandioca ou inhame
[ ] Nunca [ ] 1 a 3 vezes por semana [ ] 4 a 6 vezes por semana [ ] Diariamente, 1 vez por dia [ ] Diariamente, 2 ou mais vezes por dia
Durante uma semana normal, com que frequência você toma refrigerantes ou sucos artificiais?
[ ] Nunca [ ] 1 a 3 vezes por semana [ ] 4 a 6 vezes por semana [ ] Diariamente, 1 vez por dia [ ] Diariamente, 2 ou mais vezes por dia
No seu tempo de lazer, você realiza regularmente algum tipo de atividade física, como esportes, exercícios físicos (ginástica, caminhada, corrida), danças ou artes marciais?
[ ] NÃO, e não estou interessado(a) em realizar atividades físicas no meu tempo de lazer num futuro próximo [ ] NÃO, mas estou interessado(a) em realizar atividades físicas no meu tempo de lazer num futuro próximo [ ] SIM, participo de atividades físicas 1 ou 2 vezes por semana [ ] SIM, participo de atividades físicas 3 ou 4 vezes por semana [ ] SIM, participo de atividades físicas 5 ou mais vezes por semana
Em média, quantas horas por dia você costuma gastar assistindo televisão?
[ ] Não assisto televisão [ ] Menos de 1 hora [ ] Entre 1 e 2 horas [ ] Entre 2 e 3 horas [ ] Entre 3 e 4 horas [ ] Entre 4 e 5 horas [ ] Entre 5 e 6 horas [ ] Mais de 6 horas
Em média, quantas horas por dia você costuma gastar usando o computador, tablet ou celular para participar de redes sociais como Instagram ou Facebook, para ver filmes ou para se distrair com jogos?
[ ] Não uso computador, tablet ou celular [ ] Menos de 1 hora [ ] Entre 1 e 2 horas [ ] Entre 2 e 3 horas [ ] Entre 3 e 4 horas [ ] Entre 4 e 5 horas [ ] Entre 5 e 6 horas [ ] Mais de 6 horas

BEM-ESTAR MENTAL
Como você classifica o nível de estresse em sua vida?
[ ] Raramente estressado, vivendo muito bem [ ] À s vezes estressado, vivendo razoavelmente bem [ ] Quase sempre estressado, enfrentando problemas com frequência [ ] Sempre estressado, com dificuldade para enfrentar a vida diária
Com que frequência você pensa de forma negativa e pessimista em relação ao futuro?
[ ] Nunca [ ] Raramente [ ] Algumas vezes [ ] Na maior parte das vezes [ ] Sempre
De uma maneira geral, como você classifica a qualidade dos relacionamentos que mantém com outras pessoas (amigos, colegas de trabalho, chefes)?
[ ] Excelente [ ] Boa [ ] Regular [ ] Ruim
Com que frequência você considera que dorme bem?
[ ] Nunca [ ] Raramente [ ] Algumas vezes [ ] Na maior parte das vezes [ ] Sempre
Com que frequência você é capaz de relaxar e aproveitar o seu tempo de lazer?
[ ] Nunca [ ] Raramente [ ] Algumas vezes [ ] Na maior parte das vezes [ ] Sempre
Qual o seu nível de satisfação em relação às condições de trabalho que você tem nesta empresa? Atenção: considere como condições de trabalho fatores como remuneração, jornada de trabalho, percepção de segurança, relação com a chefia, dentre outros.
[ ] Muito satisfeito [ ] Satisfeito [ ] Nem satisfeito/nem insatisfeito [ ] Insatisfeito [ ] Muito insatisfeito

MORBIDADE

Qual é o seu peso atual? (em quilogramas - kg)
_____
Qual é a sua altura? (em metros - m)
_____
Algum médico ou profissional de saúde já lhe disse que você tem ou teve hipertensão arterial ou pressão alta?
[ ] Não [ ] Sim [ ] Não sei ou não lembro
Algum médico já lhe receitou um medicamento para pressão alta?
[ ] Não [ ] Sim [ ] Não sei ou não lembro
Algum médico ou profissional de saúde já lhe disse que você tem ou teve diabetes?
[ ] Não [ ] Sim [ ] Não sei ou não lembro
Algum médico já lhe receitou algum medicamento para diabetes?
[ ] Não [ ] Sim [ ] Não sei ou não lembro
Algum médico ou profissional de saúde já lhe disse que você tem ou teve colesterol alto ou que o seu nível de triglicérides (gorduras no sangue) está elevado?
[ ] Não [ ] Sim [ ] Não sei ou não lembro
Algum médico ou profissional de saúde já lhe disse que você teve um AVC (acidente vascular cerebral) ou derrame?
[ ] Não [ ] Sim [ ] Não sei ou não lembro
Algum médico ou profissional de saúde já lhe disse que você tem ou teve artrite ou reumatismo?
[ ] Não [ ] Sim [ ] Não sei ou não lembro

Algum médico ou profissional de saúde já lhe disse que você tem ou teve asma ou bronquite

asmática?
[ ] Não [ ] Sim [ ] Não sei ou não lembro
Algum médico ou profissional de saúde mental (como psiquiatra ou psicólogo) já lhe disse que você tem ou teve depressão?
[ ] Não [ ] Sim [ ] Não sei ou não lembro
Algum médico ou profissional de saúde já lhe disse que você tem ou teve câncer?
[ ] Não [ ] Sim [ ] Não sei ou não lembro
Você tem algum problema crônico de coluna, como dor crônica nas costas ou no pescoço, lombalgia, dor ciática, problemas nas vértebras ou disco?
[ ] Não [ ] Sim [ ] Não sei ou não lembro

PERCEPÇÃO DE SAÚDE E AUTOCUIDADO
De modo geral, com que frequência você considera que realiza atividades que lhe ajudam a controlar essas doenças ou condições crônicas? Atenção: considere como atividades de controle a realização de exames periódicos, consultas regulares com o médico e o dentista, uso correto das medicações, adoção de uma alimentação mais saudável, prática de atividades físicas, dentre outras.
[ ] Nunca [ ] Raramente [ ] Algumas vezes [ ] Na maior parte das vezes [ ] Sempre
De um modo geral, como você classifica o seu estado de saúde atual?
[ ] Muito ruim [ ] Ruim [ ] Regular [ ] Bom [ ] Muito bom
De um modo geral, como você avalia a sua saúde bucal (dentes, gengivas e língua)?
[ ] Muito ruim [ ] Ruim [ ] Regular [ ] Boa [ ] Muito boa
Qual das alternativas melhor descreve “como você cuida de sua saúde”?

[ ] Eu não acho importante cuidar da saúde e não pretendo adotar cuidados em relação a minha saúde
[ ] Cuidar da saúde pode ser importante, mas não pretendo adotar cuidados em relação a minha saúde nos próximos seis meses
[ ] Eu acho importante e quero cuidar da saúde, mas eu não sei o que fazer para adotar esses cuidados
[ ] Eu comecei a cuidar melhor da minha saúde nos últimos meses, mas esse processo de mudança é recente
[ ] Eu estou cuidando da minha saúde e faço isso, de modo regular, há mais de dois anos

FATORES DE REDUÇÃO DA PRODUTIVIDADE
Nos últimos 30 dias, em quantos dias você precisou faltar ao trabalho por motivos de saúde (com ou sem licença médica ou atestado)?
[ ] Nenhum - Neste período, não me afastei do trabalho [ ] 1 a 2 dias [ ] 3 a 7 dias [ ] 8 dias ou mais
Nos últimos 30 dias, em quantos dias você NÃO sentiu vontade de vir ao trabalho?
[ ] Nenhum - Sinto sempre vontade de vir o trabalho [ ] 1 a 2 dias [ ] 3 a 7 dias [ ] 8 dias ou mais
Nos últimos 30 dias, em quantos dias você se sentiu indisposto ou sem ânimo (energia) para realizar tarefas que o seu trabalho exige?
[ ] Nenhum - sinto-me sempre com bom ânimo para o trabalho [ ] 1 a 2 dias [ ] 3 a 7 dias [ ] 8 dias ou mais
Nos últimos 30 dias, em quantos dias você sentiu dificuldade para se concentrar no trabalho?
[ ] Nenhum - Consigo sempre manter bom nível de concentração [ ] 1 a 2 dias [ ] 3 a 7 dias [ ] 8 dias ou mais
Nos últimos 30 dias, em quantos dias você sentiu dores ou desconforto ao realizar as tarefas que o seu trabalho exige?
[ ] Nenhum - Não sinto dores/desconforto ao realizar as minhas tarefas [ ] 1 a 2 dias [ ] 3 a 7 dias [ ] 8 dias ou mais

CULTURA DE SEGURANÇA

De modo geral, como você classifica o grau de importância que essa empresa dá para as medidas de prevenção de acidentes e para a segurança no trabalho?
[ ] Nenhuma importância [ ] Pouca importância [ ] Alguma Importância [ ] Muita importância
De modo geral, você se sente seguro em seu ambiente de trabalho?
[ ] Não [ ] Sim [ ] Não sei ou não quero responder
Você considera que o ambiente dessa empresa contribui para prevenção de acidentes e para maior segurança no trabalho?
[ ] Não [ ] Sim [ ] Não sei ou não quero responder
O seu chefe ou supervisor(a) é um exemplo de respeito e comprometimento com as questões de segurança no trabalho?
[ ] Não [ ] Sim [ ] Não sei ou não quero responder
Você se sente encorajado e apoiado pelo seu chefe a obedecer às normas de prevenção de acidentes e segurança no trabalho?
[ ] Não [ ] Sim [ ] Não sei ou não quero responder
De modo geral, você diria que essa empresa considera a prevenção de acidentes e a segurança no trabalho um assunto muito importante (uma prioridade, um valor)?
[ ] Não [ ] Sim [ ] Não sei ou não quero responder
Você considera que essa empresa realiza esforços suficientes para a prevenção de acidentes e para garantir a segurança no trabalho?
[ ] Não [ ] Sim [ ] Não sei ou não quero responder
Numa situação de emergência ou de acidente no seu trabalho, você sabe o que fazer ou onde deve procurar ajuda?
[ ] Não [ ] Sim [ ] Não sei ou não quero responder

Essa empresa realiza treinamentos regulares sobre prevenção de acidentes e outros temas

relacionados à segurança no trabalho?
[ ] Não [ ] Sim [ ] Não sei ou não quero responder
No seu trabalho ocorrem conversas regulares ou debates sobre questões relacionadas à prevenção de acidentes e segurança no trabalho?
[ ] Não [ ] Sim [ ] Não sei ou não quero responder
Você diria que nessa empresa são realizadas ações suficientes para informar sobre prevenção de acidentes e segurança no trabalho?
[ ] Não [ ] Sim [ ] Não sei ou não quero responder